

Manuel entreprise Medora-S (FR)

Table des matières

Manuel d'exploitation entreprise Medora-S — Assemblage export	21
Manuel d'exploitation entreprise Medora-S	21
Édition française — assemblage opérationnel	21
Identification du document	21
Avertissement institutionnel	21
Dépendance technique	22
Structure de la collection	22
Références d'assemblage	22
Table des matières — Manuel entreprise Medora-S (FR)	23
Partie 0 — Couverture et métadonnées	23
Partie I — Fondations transverses	23
I.1 Introduction générale — sous-sections	23
I.2 Glossaire — domaines	24
Partie II — Volumes opérationnels (M-BOOK.FR.2–10)	24
Partie III — Documents transverses canon (M-BOOK.FR.1)	25
Partie IV — Annexes opérationnelles	25
Partie V — Assets visuels (intégration future)	25
Partie VI — Gouvernance et export	25
Ordre d'assemblage recommandé (PDF monolithique)	25
Références externes (hors manuel)	26
Introduction générale — Manuel entreprise Medora-S	27
1. Qu'est-ce que Medora-S ?	27
2. Environnements de soins visés	27
3. Soins urgents vs urgences (ED)	28
4. Philosophie opérationnelle	28
5. Philosophie workflow	28
6. Philosophie responsive / mobile (initiative 19M)	29
7. Philosophie gouvernance	29
7.1 Carry-forward (19T)	29
7.2 Intelligence motif (19MDM)	29
7.3 ROI et export dossier (Phase 5G / 5F)	29
7.4 Modèles de sortie gouvernés	29
8. Philosophie déploiement Haïti	29
9. Mode d'emploi du manuel	30
10. Limites et responsabilité institutionnelle	30
Références	30
Glossaire — Manuel entreprise Medora-S (FR)	31
1. Terminologie Medora de base	31

2. Orientation, disposition et sortie	31
3. Documentation clinique	32
4. Triage et soins infirmiers	32
5. Carry-forward et historique (19T)	33
6. Intelligence motif (19MDM)	33
7. ROI, audit et gouvernance	33
8. Mobile, tablette et connectivité	34
9. Rôles (libellés formation)	34
10. Abréviations approuvées (aperçu)	34
Références	34
Index des workflows — Manuel entreprise Medora-S	36
Légende	36
1. Index par rôle	36
Personnel d'accueil (FRONT_DESK)	36
Infirmier(ère) triage (RN)	36
Médecin / IPS (PROVIDER)	36
Infirmier(ère) soins (RN)	37
Pharmacie (PHARMACY)	37
Laboratoire (LAB)	37
Imagerie (RADIOLOGY)	37
Administration (ADMIN)	37
Transversal — tous rôles	37
2. Index par département	38
3. Index par urgence opérationnelle	38
4. Index par pertinence mobile	38
5. Index par sensibilité gouvernance	38
6. Matrice synthèse P1 / P2	39
Références routes	39
Index des routes opérationnelles — Manuel entreprise Medora-S	40
Légende	40
Accueil et patients	40
Urgences (ED)	40
Documentation clinique	40
Auxiliaires — pharmacie, labo, imagerie	41
Facturation	41
Administration	41
Santé publique / MSPP (selon rôle)	42
Landing par rôle (post-connexion)	42
Notes export / formation	42
Références	43
Index des acronymes — Manuel entreprise Medora-S	44
Acronymes cliniques et documentation	44
Acronymes orientation / sortie / conformité	44
Acronymes produit et gouvernance	45
Acronymes formation (Volume 9)	45
Acronymes anatomiques (documentation — sigles anglais acceptés)	45
Règles d'usage manuel / UI	46
Références	46
Volume 1 — Accueil, inscription et arrivée patient	47
Métadonnées du volume	47

1. Introduction	47
1.1 Qu'est-ce que Medora-S ?	47
1.2 Accueil et inscription : sens opérationnel	47
1.3 Rôle du personnel d'accueil	48
1.4 Importance de la qualité d'inscription	48
1.5 Philosophie opérationnelle : soins urgents vs urgences	48
1.6 Responsabilité du personnel	48
2. Définitions des rôles	48
2.1 Agent d'accueil / inscription	48
2.2 Infirmier(ère) de triage	49
2.3 Personnel urgences (ED)	49
2.4 Personnel clinique (médecin / IPS)	49
2.5 Superviseur	50
2.6 Administrateur	50
3. Workflows d'arrivée patient	50
3.1 Nouvelle inscription patient	50
Flux opérationnel	50
Bonnes pratiques	50
Points de contrôle sécurité	50
Erreurs fréquentes	51
Escalade	51
3.2 Recherche patient existant	51
Flux	51
Bonnes pratiques	51
Escalade	51
3.3 Prévention des doublons	51
Comportement Medora	51
Checklist anti-doublon	51
3.4 Patient walk-in — urgences (ED)	52
Flux	52
Bonnes pratiques	52
Erreurs fréquentes	52
3.5 Patient soins urgents (UC)	52
Flux actuel (produit)	52
Bonnes pratiques	52
3.6 Patient clinique programmé	53
Flux	53
3.7 Arrivée ambulance / EMS	53
État actuel	53
Pratique opérationnelle recommandée	53
3.8 Escalade patient critique	53
Signaux	53
Actions	53
3.9 Patient transféré entrant	54
Flux opérationnel	54
Escalade	54
3.10 Patient de retour (visite récente)	54
Flux	54
Erreur fréquente	54
4. Workflow hybride UC → urgence (conversion)	54
4.1 État actuel du produit Medora-S	54
4.2 Workflow cible (orientation entreprise — évolution produit)	55

Principes non négociables	55
4.3 Exemples opérationnels	55
Douleur thoracique en UC	55
Douleur abdominale avec signes d'alarme	55
Motifs à haut risque (liste indicative formation)	56
4.4 Quand ne pas convertir	56
4.5 Refus du patient	56
4.6 Implications facturation (orientation)	56
4.7 Attentes de documentation	56
5. Introduction au tableau des urgences	56
5.1 Deux tableaux — ne pas confondre	56
5.2 Informations visibles (vue opérationnelle)	57
5.3 Assignation	57
5.4 États d'attente	57
5.5 Réévaluation	57
5.6 Orientation (disposition)	57
6. Sécurité identité patient	58
6.1 Prévention mauvais patient	58
6.2 Doublons et dossiers multiples	58
6.3 Orthographe et DOB	58
6.4 Identifiant national / NIR	58
6.5 Patient non identifié (urgence)	58
6.6 Allergies et antécédents	58
6.7 Reprise d'antécédents (carry-forward)	59
7. Mobile et tablette	59
7.1 Alignement initiative 19M (responsive)	59
7.2 Appareils recommandés	59
7.3 Limitations mobile	59
7.4 Connectivité Haïti	59
8. Sécurité opérationnelle et escalade	59
8.1 Quand appeler le superviseur	59
8.2 Correction d'inscription	60
8.3 Panne système (haut niveau)	60
8.4 Barrière linguistique	60
8.5 Patient agressif ou perturbateur	60
8.6 Consentement et litiges paiement	60
9. Résumé opérationnel rapide	60
9.1 Checklist inscription	60
9.2 Checklist intake (accueil clinique)	60
9.3 Checklist anti-doublon	61
9.4 Checklist escalade UC → urgence	61
9.5 Checklist anti mauvais patient	61
10. Gouvernance du manuel	61
10.1 Versionnement	61
10.2 Maintenance	61
10.3 Mises à jour	62
10.4 Formation	62
10.5 Révision annuelle	62
Annexes	62

A. Routes et libellés UI (référence formation)	62
B. Références internes	62
C. Placeholders visuels (production future)	63
Volume 2 — Triage et intake clinique	64
Métadonnées du volume	64
1. Introduction au triage	64
1.1 Objectif du triage	64
1.2 Objectifs opérationnels	64
1.3 Triage vs évaluation médicale	64
1.4 Intake clinique : urgences vs soins urgents	65
1.5 Importance de la réévaluation	65
1.6 Responsabilité du personnel	65
2. Définitions des rôles	65
2.1 Infirmier(ère) de triage	65
2.2 Personnel d'accueil	66
2.3 Personnel urgences (ED)	66
2.4 Prestataire clinique (médecin / IPS)	66
2.5 Superviseur clinique	66
3. Vue d'ensemble du workflow triage	66
3.1 Séquence opérationnelle Medora (consultation d'urgence)	66
3.2 Étapes détaillées	67
Avertissements opérationnels	67
Déclencheurs d'escalade (indicatifs)	67
4. Workflow motif de consultation	68
4.1 Philosophie de saisie	68
4.2 Concis vs détaillé	68
4.3 Exemples opérationnels	68
4.4 Reconnaissance des motifs à haut risque	68
5. Workflow ESI	68
5.1 Rôle opérationnel de l'ESI	68
5.2 Libellés produit (référence formation)	69
5.3 Priorisation et salle d'attente	69
5.4 Réévaluation et modification de l'ESI	69
Exemples de déclencheurs de réévaluation	69
Exemples d'escalade d'acuité	69
6. Allergies et conciliation médicamenteuse	70
6.1 Vérification des allergies	70
Workflow Medora (triage ED)	70
Médicaments à haut risque (exemples formation)	70
6.2 Conciliation des médicaments domicile	70
Workflow	70
Limites produit (honnêteté formation)	70
Scénarios d'incertitude patient	70
7. Reprise d'antécédents (carry-forward) — 19T.1–19T.3	71
7.1 Principe	71
7.2 Sections concernées	71
7.3 Statuts de revue	71

7.4 Ancienneté (staleness)	71
7.5 Actions interface	71
7.6 Réconciliation des écarts	72
7.7 Pourquoi la revue est critique	72
8. Workflows de dépistage	72
8.1 Objectif opérationnel	72
8.2 Dépistages disponibles dans le triage ED	72
8.3 Non disponibles comme écran triage dédié (ne pas documenter comme existants)	72
8.4 Attentes documentation	73
9. Workflow de réévaluation	73
9.1 Philosophie	73
9.2 Réévaluation salle d'attente	73
9.3 Détérioration	73
9.4 Réévaluation douleur	74
9.5 Attentes documentation	74
10. Mobile et tablette — triage	74
10.1 Alignement initiative 19M	74
10.2 Recommandations	74
10.3 Workflow chevet / salle	74
10.4 Haïti — connectivité	74
11. Sécurité opérationnelle	75
11.1 Mauvais patient	75
11.2 Doublons	75
11.3 Allergies	75
11.4 Échecs de réévaluation	75
11.5 Détérioration salle d'attente	75
11.6 Patient agressif / perturbateur	75
11.7 Barrière linguistique	75
11.8 Panne système	75
12. Résumé opérationnel rapide — checklists	75
12.1 Checklist intake triage	75
12.2 Checklist conciliation allergies	76
12.3 Checklist revue carry-forward	76
12.4 Checklist réévaluation	76
12.5 Checklist escalade	76
12.6 Checklist sécurité salle d'attente	76
13. Gouvernance du chapitre	77
13.1 Propriété	77
13.2 Mises à jour	77
13.3 Révision annuelle	77
13.4 Formation	77
Annexes	77
A. Routes et libellés UI	77
B. Références	77
C. Placeholders visuels	78
Volume 3 — Workflow prestataire et documentation clinique	79
Métadonnées du volume	79

1. Introduction au workflow prestataire	79
1.1 Rôle du prestataire dans Medora	79
1.2 Relation avec le triage	79
1.3 Philosophie de documentation	79
1.4 Objectifs opérationnels et sécurité patient	80
1.5 Responsabilité clinique	80
2. Vue d'ensemble du workflow prestataire	80
2.1 Séquence opérationnelle (urgences)	80
2.2 File prestataire vs documentation	81
2.3 Détail par étape	81
Escalade	81
3. Workflow documentation clinique	82
3.1 HPI (histoire de la maladie)	82
3.2 ROS (revue des systèmes)	82
3.3 Examen physique	82
3.4 MDM (aide à la décision médicale)	82
3.5 Réévaluation (documentation prestataire)	82
3.6 Consultations évoquées	82
3.7 Justifications orientation / observation / admission	82
3.8 Communication patient / famille	83
4. Workflow MDM	83
4.1 Philosophie MDM dans Medora	83
4.2 Menu MDM multi-sélection	83
Comportement opérationnel	83
Prompts à valeur élevée (fixes)	83
4.3 Modèle actif vs intelligence motif	83
4.4 Champs MDM typiques	83
4.5 Responsabilité finale	84
5. Workflow intelligence motif (19MDM)	84
5.1 Principes	84
5.2 Organisation en sous-groupes (picker)	84
5.3 Utilisation opérationnelle	84
5.4 Limitations et gouvernance (sécurité)	85
Ce que l'intelligence motif ne fait pas	85
Gouvernance produit (19MDM)	85
Revue prestataire obligatoire	85
6. Réévaluation et évolution clinique	85
6.1 Philosophie	85
6.2 Workflow répété	85
6.3 Détérioration	86
6.4 Séjour prolongé aux urgences	86
6.5 Mode observation	86
7. Consultations, observation et admission	86
7.1 Documentation consult	86
7.2 Justification observation	86
7.3 Justification admission	86
7.4 Transfert	86
7.5 Incertitude clinique	87

8. Orientation et documentation de sortie	87
8.1 Deux niveaux (rappel)	87
8.2 Workflow sortie	87
8.3 Planification partagée	87
8.4 Philosophie (sans détail gouvernance interne)	87
La documentation de sortie doit refléter	87
9. Historique longitudinal et carry-forward	88
9.1 Revue prestataire	88
9.2 Reprise d'antécédents (Volume 2)	88
9.3 Profil longitudinal (19T.3)	88
9.4 Risque données anciennes	88
10. Mobile et tablette — prestataire	88
10.1 Initiative 19M.5 (documentation)	88
10.2 Recommandations	88
10.3 Haïti — connectivité	89
11. Sécurité opérationnelle prestataire	89
12. Résumé opérationnel rapide — checklists	89
12.1 Checklist intake prestataire	89
12.2 Checklist MDM	89
12.3 Checklist réévaluation	90
12.4 Checklist sortie	90
12.5 Checklist observation / admission	90
12.6 Checklist sécurité intelligence motif	90
12.7 Checklist anti mauvais patient	90
13. Gouvernance du chapitre	90
13.1 Propriété	90
13.2 Revue leadership prestataire	91
13.3 Formation déploiement Haïti	91
13.4 Mises à jour	91
Annexes	91
A. Enregistrement et brouillon (aperçu)	91
B. Références	91
C. Placeholders visuels	91
Volume 4 — Workflow infirmier et exécution de sortie	93
Métadonnées du volume	93
1. Introduction au workflow infirmier	93
1.1 Rôle infirmier dans Medora	93
1.2 Relation avec triage et documentation prestataire	93
1.3 Responsabilité documentaire infirmière	94
1.4 Réévaluation continue	94
1.5 Suivi médicament et ordres	94
1.6 Exécution de sortie	94
1.7 Responsabilité clinique et politique institutionnelle	94
2. Vue d'ensemble du workflow infirmier	94
2.1 Séquence opérationnelle (urgences)	94
2.2 Surfaces Medora	95
2.3 Détail par étape	95

3. Documentation infirmière aux urgences	96
3.1 Panneau réévaluation infirmière	96
3.2 Brouillon local (aperçu)	96
3.3 Distinction triage vs soins infirmiers	96
4. Workflow réévaluation	97
4.1 Philosophie	97
4.2 Réévaluation douleur	97
4.3 Signes vitaux répétés	97
4.4 Détérioration clinique	97
4.5 Réévaluation salle d'attente	97
4.6 Réponse au traitement	97
4.7 Séjour prolongé aux urgences	97
4.8 Notification prestataire	98
4.9 Mode observation	98
5. Suivi des ordres et résultats	98
5.1 Conscience des ordres actifs	98
5.2 Coordination labo / imagerie / pharmacie	98
5.3 Ordres en attente	98
5.4 Ordres complétés et résultats	98
5.5 Changements critiques	98
5.6 Attentes documentaires	98
6. Administration de médicament	99
6.1 Conscience des ordres médicament	99
6.2 Documentation d'administration	99
6.3 Refus patient	99
6.4 Médicament retenu (held)	99
6.5 Réaction / événement indésirable	99
6.6 Réévaluation après médicament	99
6.7 Analgésie et réévaluation douleur	99
6.8 Médicaments à haut risque	99
7. Exécution de sortie infirmière	100
7.1 Distinction fondamentale	100
7.2 Workflow exécution sortie (sortie à domicile)	100
7.3 Champs typiques exécution sortie	100
7.4 Handoff infirmier (panneau complémentaire)	100
7.5 Erreurs critiques à éviter	101
8. Éducation patient et enseignement	101
8.1 Médicaments	101
8.2 Suivi	101
8.3 Consignes de retour	101
8.4 Soins de plaie / appareils	101
8.5 Communication famille / aidant	101
8.6 Barrière linguistique	101
8.7 Refus ou non-compréhension	101
9. Admission, transfert et observation — workflow infirmier	102
9.1 Préparation admission	102
9.2 Préparation transfert	102
9.3 Responsabilités infirmières en observation	102
9.4 Handoff	102

9.5 Effets personnels et documentation	102
9.6 Transport	102
10. Historique longitudinal et carry-forward	102
10.1 Revue infirmière du carry-forward	102
10.2 Médicaments domicile	102
10.3 Données anciennes (stale)	103
10.4 Profil longitudinal (19T.3)	103
10.5 Discordances infirmier / prestataire	103
11. Mobile et tablette — infirmier	103
11.1 Initiative responsive (19M)	103
11.2 Recommandations	103
11.3 Haïti — connectivité	103
12. Sécurité opérationnelle infirmière	103
13. Résumé opérationnel rapide — checklists	104
13.1 Checklist intake infirmier	104
13.2 Checklist réévaluation	104
13.3 Checklist administration médicament	104
13.4 Checklist suivi ordres	105
13.5 Checklist exécution sortie	105
13.6 Checklist enseignement patient	105
13.7 Checklist handoff admission / transfert	105
13.8 Checklist anti mauvais patient	106
14. Gouvernance du chapitre	106
14.1 Propriété	106
14.2 Revue leadership infirmier	106
14.3 Lien gouvernance terminologique	106
14.4 Formation déploiement Haïti	106
14.5 Mises à jour	106
14.6 Révision annuelle	107
Annexes	107
A. Enregistrement (aperçu)	107
B. Références	107
C. Placeholders visuels	107
Volume 5 — Pharmacie, laboratoire et imagerie	108
Métadonnées du volume	108
1. Introduction aux workflows auxiliaires	108
1.1 Rôle des services auxiliaires dans Medora	108
1.2 Relation avec prestataire et infirmier	108
1.3 Coordination opérationnelle	108
1.4 Cycle ordre / résultat (aperçu)	109
1.5 Objectifs sécurité patient	109
1.6 Attentes de communication	109
1.7 Responsabilité et politiques institutionnelles	109
2. Workflow pharmacie — vue d'ensemble	109
2.1 Périmètre opérationnel honnête	109
2.2 Séquence opérationnelle	110
2.3 File pharmacie — concepts	110

2.4	Priorisation file	110
2.5	ED vs soins urgents (UC)	110
2.6	Disponibilité médicament	110
2.7	Workflow synchronisation en attente	111
2.8	Communication pharmacie équipe soignante	111
2.9	Escalade	111
3.	Workflow laboratoire — vue d’ensemble	111
3.1	Séquence opérationnelle	111
3.2	File laboratoire — concepts	112
3.3	Coordination prélèvement	112
3.4	États opérationnels	112
3.5	Workflow résultat	112
3.6	Délais (turnaround)	112
3.7	Analyses répétées / additionnelles	112
3.8	Attentes documentaires	112
4.	Workflow imagerie — vue d’ensemble	113
4.1	Séquence opérationnelle	113
4.2	File imagerie — concepts	113
4.3	Priorisation et débit urgences	113
4.4	Coordination transport	113
4.5	Imagerie en attente vs complétée	113
4.6	Escalade imagerie haute acuité	113
5.	Cycle de vie ordre / résultat	114
5.1	Concepts opérationnels Medora	114
5.2	Rôle des auxiliaires	114
5.3	Interprétation clinique — limitation explicite	114
5.4	Coordination inter-départements	114
6.	Résultats critiques et sensibilisation à l’escalade	115
6.1	Sensibilisation (pas de politique institutionnelle)	115
6.2	Communication urgente	115
6.3	Résultat retardé	115
6.4	Panne / downtime	115
6.5	Attentes documentaires	115
7.	Sécurité dispensation et résultats	115
7.1	Pharmacie	115
7.2	Laboratoire	116
7.3	Imagerie	116
8.	Mobile et tablette — workflows auxiliaires	116
8.1	Initiative 19M.7 (files auxiliaires)	116
8.2	Recommandations appareil	116
8.3	Haïti — connectivité	117
9.	Communication opérationnelle	117
9.1	Avec le prestataire	117
9.2	Avec l’infirmier	117
9.3	Handoff et relève	117
9.4	Résultats en attente côté clinique	117
9.5	Observation / admission	117

10. Résumé opérationnel rapide — checklists	118
10.1 Checklist file pharmacie	118
10.2 Checklist workflow laboratoire	118
10.3 Checklist workflow imagerie	118
10.4 Checklist résultats en attente	118
10.5 Checklist escalade résultat critique	119
10.6 Checklist anti mauvais patient	119
10.7 Checklist auxiliaire — downtime	119
11. Gouvernance du chapitre	119
11.1 Propriété	119
11.2 Revue leadership auxiliaire	119
11.3 Lien terminologie	119
11.4 Formation déploiement Haïti	120
11.5 Adaptation Haïti	120
11.6 Révision annuelle	120
Annexes	120
A. Actions file (aperçu)	120
B. RBAC (aperçu)	120
C. Références	120
D. Placeholders visuels	121
Volume 6 — Orientation, admission, transfert et dévoilement de dossier	122
Métadonnées du volume	122
Distinction terminologique canonique	122
1. Introduction au workflow disposition	122
1.1 Objectif opérationnel	122
1.2 Rôles	123
1.3 Réévaluation avant orientation	123
1.4 Continuité des soins	123
1.5 Attentes documentation / communication	123
1.6 Responsabilité et politiques institutionnelles	123
2. Workflow congé et sortie	123
2.1 Philosophie de sortie	123
2.2 Séquence opérationnelle	124
2.3 Distinction fondamentale	124
2.4 Planification partagée et famille	124
2.5 Résultats en attente	124
2.6 Refus, LAMA, LWBS	124
2.7 Deux niveaux dans Medora (rappel)	125
3. Workflow observation	125
3.1 Objectif opérationnel	125
3.2 Décision et documentation	125
3.3 Réévaluation en observation	125
3.4 Séjour prolongé aux urgences vs observation	125
3.5 Résultats en attente	125
3.6 Transition	126
4. Workflow admission	126
4.1 Séquence opérationnelle	126
4.2 Philosophie justification admission	126
4.3 Coordination lit / placement	126

4.4 Handoff infirmier	126
4.5 Escalade	126
4.6 Résultats en attente	126
5. Workflow transfert	127
5.1 Objectif opérationnel	127
5.2 Séquence	127
5.3 Sensibilisation EMTALA (sans conseil juridique)	127
5.4 Dossier / paquet transfert	127
5.5 Patient instable	127
5.6 Retards transport	127
5.7 Résultats en attente	127
6. Dévoilement de dossier (ROI)	128
6.1 Définition et objectif	128
6.2 Périmètre Medora (honnête)	128
6.3 Types de demande (produit)	128
6.4 Cycle de vie demande ROI	128
6.5 Rôles	128
6.6 Gouvernance et audit (aperçu)	129
6.7 Demandes externes	129
7. Export dossier et instantané — sensibilisation	129
7.1 Objectif opérationnel (Phase 5F)	129
7.2 Philosophie instantané immuable	129
7.3 Formats opérationnels	129
7.4 Vérification opérationnelle	129
7.5 Ce que ce chapitre n'expose pas	129
7.6 Panne durée / intégrité	129
8. Sécurité opérationnelle disposition et ROI	130
8.1 Disposition / sortie / admission / transfert	130
8.2 ROI / confidentialité	130
9. Mobile et tablette — disposition	130
9.1 Initiative 19M.6	130
9.2 Recommandations	130
9.3 Haïti — connectivité	131
10. Communication opérationnelle et handoffs	131
10.1 Prestataire infirmier	131
10.2 Handoff admission	131
10.3 Handoff transfert	131
10.4 Observation	131
10.5 Aidants	131
10.6 Relève de quart	131
11. Résumé opérationnel rapide — checklists	131
11.1 Checklist sortie	131
11.2 Checklist observation	132
11.3 Checklist admission	132
11.4 Checklist transfert	132
11.5 Checklist demande ROI	132
11.6 Checklist résultats en attente	133
11.7 Checklist anti mauvais patient	133

11.8 Checklist communication sortie	133
12. Gouvernance du chapitre	133
12.1 Propriété	133
12.2 Revue leadership	133
12.3 Lien gouvernance ROI (Phase 5G)	133
12.4 Lien export dossier (Phase 5F)	134
12.5 Déploiement Haïti	134
12.6 Formation	134
12.7 Révision annuelle	134
Annexes	134
A. Orientations produit (urgences — aperçu)	134
B. Références	134
C. Placeholders visuels	134
Volume 7 — Administration, gouvernance et opérations plateforme	136
Métadonnées du volume	136
1. Introduction à la gouvernance plateforme	136
1.1 Rôle opérationnel de l'administration	136
1.2 Philosophie de gouvernance	136
1.3 Responsabilités sécurité	136
1.4 Continuité des opérations	137
1.5 Attentes audit	137
1.6 Comptes utilisateurs	137
1.7 Intendance des données	137
1.8 Responsabilité institutionnelle	137
2. Définitions des rôles administratifs	137
2.1 Administrateur plateforme / établissement	137
2.2 Superviseur clinique	137
2.3 Responsable ROI	138
2.4 Responsable conformité	138
2.5 Support opérationnel	138
2.6 Gestionnaire établissement	138
2.7 Responsable formation	138
3. Établissement et gestion utilisateurs	139
3.1 Concept établissement (facility)	139
3.2 Provisionnement utilisateur	139
3.3 Activation / désactivation	139
3.4 Mot de passe et sécurité	139
3.5 Assignation rôles — sensibilisation	139
3.6 Onboarding / offboarding	140
3.7 Escalade superviseur	140
4. RBAC et gouvernance des accès	140
4.1 Contrôle d'accès par rôle (RBAC)	140
4.2 Philosophie du moindre privilège	140
4.3 Accès clinique vs administratif	140
4.4 Auditabilité	140
4.5 Interdiction des comptes partagés	141
4.6 Poste de travail	141
4.7 Accès mobile	141
4.8 Ce que ce chapitre n'expose pas	141

5. Audit et workflows de gouvernance	141
5.1 Philosophie audit	141
5.2 Traçabilité opérationnelle	141
5.3 Responsabilité	141
5.4 Surveillance workflow	141
5.5 Gouvernance disposition (aperçu)	142
5.6 Gouvernance carry-forward (aperçu)	142
5.7 Gouvernance export dossier (Phase 5F)	142
5.8 Métadonnées audit	142
6. Administration ROI et surveillance	142
6.1 Workflow admin ROI (Phase 5G)	142
6.2 Revue demande	142
6.3 Surveillance ROI agrégée	142
6.4 Confidentialité et minimum nécessaire	142
6.5 Escalade	142
7. Opérations plateforme et déploiement	143
7.1 Philosophie déploiement	143
7.2 Environnements (aperçu opérationnel)	143
7.3 Planification mise à jour	143
7.4 Coordination formation	143
7.5 Pilote Haïti	143
7.6 Connectivité	143
7.7 Escalade opérationnelle	143
8. Panne et continuité d'activité	144
8.1 Position honnête	144
8.2 Interruption internet	144
8.3 Connectivité dégradée	144
8.4 Panne plateforme (API / hébergement)	144
8.5 Vérification reprise	144
8.6 Communication panne	144
9. Mobile et tablette — gouvernance	144
9.1 Initiative 19M (rappel)	144
9.2 Recommandations appareils	145
9.3 Appareil partagé	145
9.4 Confidentialité écran	145
9.5 Limitations téléphone	145
9.6 Haïti	145
10. Sécurité et confidentialité	145
11. Support opérationnel	146
11.1 Escalade incident	146
11.2 Dépannage opérationnel (premier niveau)	146
11.3 Communication panne	146
11.4 Escalade formation	146
11.5 Urgence opérationnelle clinique	146
12. Résumé opérationnel rapide — checklists	146
12.1 Checklist onboarding administrateur	146
12.2 Checklist provisionnement utilisateur	147
12.3 Checklist revue RBAC	147

12.4 Checklist gouvernance ROI	147
12.5 Checklist panne	147
12.6 Checklist sécurité / confidentialité	147
12.7 Checklist déploiement Haïti	148
12.8 Checklist escalade opérationnelle	148
13. Gouvernance du chapitre	148
13.1 Propriété	148
13.2 Revue leadership	148
13.3 Lien gouvernance ROI / export	148
13.4 Revue déploiement Haïti	149
13.5 Gouvernance formation	149
13.6 Mises à jour	149
Annexes	149
A. Routes admin (aperçu)	149
B. Références exploitation	149
C. Placeholders visuels	149
Volume 8 — Mobile, tablette et opérations de déploiement Haïti	151
Métadonnées du volume	151
1. Introduction aux opérations mobile et tablette	151
1.1 Pourquoi Medora supporte mobile / tablette	151
1.2 Mobilité opérationnelle aux urgences	151
1.3 Philosophie chevet	151
1.4 Concepts tablette-first (sans exagération)	152
1.5 Limitations téléphone	152
1.6 Objectifs responsive Medora	152
1.7 Position produit	152
2. Vue d'ensemble des workflows responsive	152
2.1 Initiative 19M.1–19M.9 — résultats	152
2.2 Classes d'appareils supportées	152
2.3 Attentes tablette	153
2.4 Limitations téléphone	153
2.5 Attentes poste de travail	153
2.6 Lacunes connues (honnêteté 19M)	153
3. Guide par classe d'appareil	153
3.1 Poste de travail hospitalier (desktop)	153
3.2 Portable (laptop)	154
3.3 Tablette portrait	154
3.4 Tablette paysage	154
3.5 Téléphone	154
4. Triage et workflows tablette au chevet	155
4.1 Triage sur tablette	155
4.2 Soins infirmiers chevet	155
4.3 Réévaluation rapide	155
4.4 Exécution sortie chevet	155
4.5 Revue carry-forward tablette	155
4.6 Prestataire box à box	155
5. Workflow mobile prestataire	155
5.1 Revue dossier	155

5.2 Réévaluation prestataire	156
5.3 MDM sur tablette	156
5.4 Intelligence motif sur tablette	156
5.5 Disposition sur tablette	156
5.6 Documentation prolongée — limitation	156
6. Tableau des urgences et flux ED mobile	156
6.1 Comportement responsive tableau	156
6.2 Navigation sections dossier actif	156
6.3 Assignment et visibilité	156
6.4 Revue file rapide	156
6.5 Limitation	157
7. Workflows mobile auxiliaires	157
7.1 Alignement 19M.7	157
7.2 Pharmacie	157
7.3 Laboratoire / imagerie	157
7.4 Revue file en déplacement	157
8. Opérations de déploiement Haïti	157
8.1 Réalités opérationnelles	157
8.2 Dépendance cloud — position honnête	157
8.3 Stratégie déploiement phasé	158
8.4 Supervision opérationnelle	158
8.5 Formation	158
8.6 Inventaire matériel recommandé	158
9. Connectivité dégradée	158
9.1 Synchronisation en attente	158
9.2 Mises à jour retardées	158
9.3 Après reconnexion	159
9.4 Escalade connectivité dégradée	159
9.5 Protocole papier temporaire	159
9.6 Communication	159
10. Appareils partagés et confidentialité	159
11. Sécurité opérationnelle mobile	159
12. Déploiement et formation — recommandations	160
12.1 Go-live phasé	160
12.2 Super-utilisateurs	160
12.3 Revue opérationnelle quotidienne (15 min)	160
12.4 Inventaire appareils	160
12.5 Évaluation réseau	160
12.6 Onboarding	160
13. Résumé opérationnel rapide — checklists	161
13.1 Checklist déploiement tablette	161
13.2 Checklist workflow chevet	161
13.3 Checklist déploiement Haïti	161
13.4 Checklist connectivité dégradée	161
13.5 Checklist appareil partagé	162
13.6 Checklist sécurité mobile	162
13.7 Checklist préparation opérationnelle quotidienne	162

14. Gouvernance du chapitre	162
14.1 Propriété	162
14.2 Lien initiative responsive	162
14.3 Revue annuelle	162
14.4 Revue déploiement Haïti	163
14.5 Gouvernance formation	163
14.6 Politique appareils	163
Annexes	163
A. Seuils responsive (aperçu staff)	163
B. Références	163
C. Placeholders visuels	163
Volume 9 — Formation, intégration et certification opérationnelle	164
Métadonnées du volume	164
1. Introduction à la formation Medora-S	164
1.1 Objectif de ce volume	164
1.2 Philosophie formation	164
1.3 Certification opérationnelle — définition	164
1.4 Responsabilité institutionnelle	165
2. Cartographie des volumes par rôle	165
2.1 Matrice curriculum (référence)	165
2.2 Priorité P1 vs P2 (formation go-live)	165
2.3 Parcours patient type (fil conducteur formation)	166
3. Intégration (onboarding) — workflow standard	166
3.1 Avant le premier jour	166
3.2 Jour 1 — Fondations	166
3.3 Semaine 1 — Supervision	166
3.4 Semaine 2-4 — Montée autonomie	166
3.5 Offboarding	166
4. Niveaux de certification opérationnelle	167
4.1 Niveau 0 — Observation	167
4.2 Niveau 1 — Autonomie supervisée	167
4.3 Niveau 2 — Autonomie routine	167
4.4 Niveau 3 — Super-utilisateur / formateur	167
4.5 Registre d’attestation (recommandé)	167
4.6 Limites explicites	167
5. Guide du formateur / facilitateur	167
5.1 Rôle formateur	167
5.2 Préparation session	168
5.3 Méthodes pédagogiques	168
5.4 Pièges formation fréquents	168
5.5 Évaluation formateur	168
6. Programme pilote Haïti	168
6.1 Contexte	168
6.2 Calendrier type (4 semaines)	168
6.3 Super-utilisateurs Haïti (minimum)	169
6.4 Matériel formation	169
6.5 Critères go-live formation	169

7. Programme super-utilisateur	169
7.1 Mission	169
7.2 Curriculum super-utilisateur	169
7.3 Compétences attendues	169
7.4 Relève	170
8. Exercices pratiques et scénarios	170
8.1 Scénarios transverses (tous rôles)	170
8.2 Accueil	170
8.3 Triage	170
8.4 Prestataire	170
8.5 Infirmier	170
8.6 Auxiliaires	170
8.7 Admin	171
9. Recertification et revue annuelle	171
9.1 Fréquence	171
9.2 Contenu recertification (light)	171
9.3 Changements produit	171
9.4 Échec recertification	171
10. Formation transversale obligatoire	171
10.1 Sécurité patient (tous)	171
10.2 Connectivité (tous)	171
10.3 Mobile (clinique)	172
10.4 Gouvernance sortie / ROI (cibles)	172
11. Évaluation des compétences	172
11.1 Modalités	172
11.2 Critères minimum niveau 1 (exemple infirmier triage)	172
11.3 Critères minimum niveau 2 (exemple prestataire)	172
11.4 Traçabilité	172
12. Résumé opérationnel rapide — checklists	172
12.1 Checklist onboarding administrateur formation	172
12.2 Checklist onboarding nouvel utilisateur	173
12.3 Checklist session formateur	173
12.4 Checklist certification niveau 1	173
12.5 Checklist certification niveau 2	173
12.6 Checklist recertification annuelle	173
12.7 Checklist formation Haïti go-live	174
12.8 Checklist escalade formation	174
13. Gouvernance du chapitre	174
13.1 Propriété	174
13.2 Revue annuelle collection M-BOOK	174
13.3 Revue Haïti	174
13.4 Lien phases produit	174
13.5 Index des volumes	174
Annexes	175
A. Sigles formation	175
B. Références	175
C. Placeholders visuels	175
Annexe A — Déploiement Haïti	177

Objectif	177
Contenu planifié (TODO)	177
A.1 Contexte pilote	177
A.2 Prérequis go-live	177
A.3 Checklist 19M.8	177
A.4 Contacts et escalade	177
Références volumes	177
Références externes	177
Annexe B — Sécurité mobile et tablette	179
Objectif	179
Contenu planifié (TODO)	179
B.1 Confidentialité écran	179
B.2 Comptes nominatifs	179
B.3 Appareils perdus / volés	179
B.4 Connectivité	179
Références	179
Annexe C — Référence rapide	180
Objectif	180
Contenu planifié (TODO)	180
C.1 Accueil (FRONT_DESK)	180
C.2 Triage (RN)	180
C.3 Médecin (PROVIDER)	180
C.4 Infirmier soins (RN)	180
C.5 Admin	180
Références	181
Annexe D — Scénarios de formation	182
Objectif	182
Scénarios transverses (tous rôles)	182
Par rôle (TODO expansion)	182
Références	182
Annexe E — Workflow papier / panne (downtime)	183
Objectif	183
Principes	183
Contenu planifié (TODO)	183
E.1 Déclencheurs activation papier	183
E.2 Formulaires papier recommandés	183
E.3 Reconnexion	183
Références externes	184
Gouvernance documentaire — Manuel entreprise Medora-S	185
1. Objectif	185
2. Périmètre de la collection	185
3. Stratégie de versionnement	185
4. Revue annuelle	185
5. Propriété et responsabilités	186
6. Gouvernance traduction (édition anglaise future)	186
7. Politique refresh captures d'écran	187
8. Cadence revue déploiement	187
9. Cadence revue Haïti	187
10. Intégrité et tests	187
11. Export et distribution	187

12. Limites explicites	188
Références	188

Manuel d'exploitation entreprise Medora-S — Assemblage export

Phase : M-BOOK.FR.12

Langue : Français

Statut : Assemblage automatique — revue direction requise avant diffusion

Ce manuel soutient l'exploitation et la formation. Il ne remplace pas les politiques institutionnelles ni le jugement clinique. Medora-S est **dépendant du cloud** en production MVP.

Manuel d'exploitation entreprise Medora-S

Édition française — assemblage opérationnel

Phase : M-BOOK.FR.11

Version : 1.0.0-draft

Statut : Assemblage documentation — prêt pour export PDF/DOCX, formation et revue direction

Langue produit : Français (interface et manuel)

Public : Direction clinique, direction technique, formateurs, super-utilisateurs, personnel opérationnel

Identification du document

Champ	Valeur
Titre complet	Manuel d'exploitation entreprise Medora-S — Édition française
Collection	M-BOOK.FR.1 à M-BOOK.FR.11
Volumes opérationnels	9 (Accueil → Formation)
Documents transverses	Canon terminologique, inventaire workflows, registre risques, guide de style
Déploiement cible	Pilote Haïti — clinique MVP Phase 1

Avertissement institutionnel

Ce manuel soutient l'exploitation, la formation et l'intégration de Medora-S. Il ne remplace pas :

- les politiques institutionnelles de l'établissement ;
- le jugement clinique des professionnels de santé ;
- les obligations légales et réglementaires locales ;
- les protocoles papier de continuité en cas de panne.

Medora-S **assiste** les workflows ; la responsabilité des soins et des décisions reste au personnel et à la direction de l'établissement.

Dépendance technique

Medora-S est **dépendant du cloud** pour la synchronisation des données en production. Ce manuel documente les pratiques de continuité (protocole papier, vérification post-reconnexion) sans prétendre à un mode hors-ligne complet.

Structure de la collection

1. **Partie I — Fondations** — Introduction, glossaire, index (workflows, routes, acronymes)
 2. **Partie II — Volumes opérationnels 1–9** — Parcours métier par rôle
 3. **Partie III — Annexes** — Haïti, mobile, référence rapide, scénarios, panne
 4. **Partie IV — Assets visuels** — Inventaires captures et diagrammes (intégration future)
 5. **Partie V — Gouvernance documentaire** — Versionnement, revue, traduction
-

Références d’assemblage

- Table des matières
 - Manifeste machine
 - Gouvernance documentaire
 - Checklist export
-

Document d’assemblage M-BOOK.FR.11 — Medora-S

Table des matières — Manuel entreprise Medora-S (FR)

Phase : M-BOOK.FR.11

Format : Structure logique pour export PDF/DOCX — numérotation entreprise

Version : 1.0.0-draft

Partie 0 — Couverture et métadonnées

§	Titre	Fichier
0.1	Page de garde	00-page-garde.md
0.2	Table des matières	01-table-des-matieres.md
0.3	Manifeste d’assemblage	handbook-manifest-fr.ts

Partie I — Fondations transverses

§	Titre	Fichier	Pages (PDF est.)
I.1	Introduction générale	02-introduction-generale.md	—
I.2	Glossaire canonique	03-glossaire.md	—
I.3	Index des workflows	04-index-workflows.md	—
I.4	Index des routes opérationnelles	05-index-routes.md	—
I.5	Index des acronymes	06-index-acronymes.md	—

I.1 Introduction générale — sous-sections

1. Qu’est-ce que Medora-S
2. Environnements de soins ciblés
3. Soins urgents vs urgences (ED)
4. Philosophie opérationnelle
5. Philosophie workflow
6. Philosophie responsive / mobile (19M)
7. Philosophie gouvernance (19T, 19MDM, ROI)
8. Philosophie déploiement Haïti
9. Mode d’emploi du manuel
10. Limites et responsabilité institutionnelle

I.2 Glossaire — domaines

- Terminologie Medora de base
 - Documentation clinique (HPI, ROS, MDM)
 - Triage et soins infirmiers
 - Orientation / disposition / sortie
 - Mobile et connectivité
 - ROI et gouvernance
 - Carry-forward et intelligence motif
-

Partie II — Volumes opérationnels (M-BOOK.FR.2–10)

Vol.	Phase	Titre	Source	Public principal
1	FR.2	Accueil, inscription et arrivée patient	handbook-fr-registration-intake.md	Accueil, triage
2	FR.3	Triage et intake clinique	handbook-fr-triage-clinical-intake.md	Infirmier triage
3	FR.4	Workflow prestataire et documentation	handbook-fr-provider-workflow-documentation.md	Médecin, IPS
4	FR.5	Workflow infirmier et exécution sortie	handbook-fr-nursing-discharge-execution.md	Infirmier ED
5	FR.6	Pharmacie, laboratoire et imagerie	handbook-fr-pharmacy-lab-radiology.md	Auxiliaires
6	FR.7	Orientation, admission, transfert et ROI	handbook-fr-disposition-admission-transfer-roi.md	Médecin, admin
7	FR.8	Administration et gouvernance plateforme	handbook-fr-administration-governance-operations.md	Administrateur
8	FR.9	Mobile, tablette et déploiement Haïti	handbook-fr-mobile-tablette-haiti.md	Tous (transversal)
9	FR.10	Formation, intégration et certification	handbook-fr-training-onboarding-certification.md	Formateurs, direction

Partie III — Documents transverses canon (M-BOOK.FR.1)

Doc.	Titre	Source
C.1	Canon terminologique français	french-terminology-canon.md
C.2	Guide de style manuel	french-handbook-style-guide.md
C.3	Inventaire des workflows	french-workflow-inventory.md
C.4	Registre des risques terminologiques	french-terminology-risks.md

Partie IV — Annexes opérationnelles

Annexe	Titre	Fichier
A	Déploiement Haïti	appendix-a-haiti-deployment.md
B	Sécurité mobile / tablette	appendix-b-mobile-safety.md
C	Référence rapide	appendix-c-quick-reference.md
D	Scénarios de formation	appendix-d-training-scenarios.md
E	Workflow papier / panne	appendix-e-downtime-paper-workflow.md

Partie V — Assets visuels (intégration future)

§	Titre	Fichier
V.1	Inventaire captures d'écran	07-index-captures-ecran.md
V.2	Inventaire diagrammes	08-index-diagrammes.md
V.3	Dossiers placeholders	assets-placeholders/

Partie VI — Gouvernance et export

§	Titre	Fichier
VI.1	Gouvernance documentaire	09-gouvernance-documentaire.md
VI.2	Checklist préparation export	exports/export-readiness-checklist.md

Ordre d'assemblage recommandé (PDF monolithique)

1. Page de garde (0.1)

2. Table des matières (0.2)
 3. Introduction générale (I.1)
 4. Glossaire (I.2)
 5. Index workflows, routes, acronymes (I.3–I.5)
 6. Volumes 1 → 9 (Partie II)
 7. Annexes A → E (Partie IV)
 8. Inventaires visuels (Partie V) — placeholders jusqu’à capture
 9. Gouvernance documentaire (VI.1)
 10. Canon terminologique complet (annexe ou volume séparé selon taille export)
-

Références externes (hors manuel)

- docs/HAITI_MVP_PILOT.md
 - docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md
 - docs/DEPLOYMENT_RUNBOOK.md
 - docs/clinical/longitudinal-history-production-validation-19T4.md
-

Fin table des matières — M-BOOK.FR.11

Introduction générale — Manuel entreprise Medora-S

Phase : M-BOOK.FR.11

Section : I.1

Public : Tous les lecteurs du manuel — direction, formateurs, personnel clinique et administratif

1. Qu'est-ce que Medora-S ?

Medora-S est un **dossier médical électronique (DME)** modulaire conçu pour des cliniques et services d'urgence en **environnement à ressources limitées**. Le premier déploiement cible est le **pilote Haïti** (Phase 1 — Clinic MVP).

Medora-S couvre :

- Accueil et inscription patient
- Triage et documentation aux urgences
- Documentation médicale (HPI, ROS, examen, MDM)
- Soins infirmiers et réévaluation
- Prescriptions, laboratoire, imagerie, pharmacie
- Orientation, admission, transfert, sortie
- Administration, audit, dévoilement de dossier (ROI)
- Formation et intégration opérationnelle

L'interface utilisateur visible par le personnel est en **français**. Les identifiants techniques (routes, champs API) peuvent rester en anglais.

2. Environnements de soins visés

Contexte	Description	Couverture manuel
Service d'urgence (ED)	Parcours complet : accueil → triage → tableau → documentation → ordres → disposition	Volumes 1–4, 6, 8
Soins urgents / intensifs (UC)	Consultation ambulatoire accélérée, sans parcours ED identique	Volume 1 (distinction type)
Clinique ambulatoire	Visites programmées, suivi	Volume 1 (aperçu)
Observation / court séjour	Admission prolongée sans unité complète	Volume 6
Auxiliaires	Pharmacie, labo, imagerie	Volume 5
Administration	Utilisateurs, audit, ROI, santé système	Volumes 6–7

Ce manuel **ne prétend pas** reproduire un système hospitalier national ou multi-établissements entreprise.

3. Soins urgents vs urgences (ED)

Type produit	Libellé UI	Usage
EMERGENCY	Consultation d'urgence / Urgences	Parcours ED : triage, tableau des urgences, documentation ED
URGENT_CARE	Soins urgents / intensifs	Consultation ouverte ; parcours ED dédié réduit
OUTPATIENT	Clinique	Ambulatoire

Règle formation : le personnel d'accueil et de triage doit connaître le **protocole local** pour ouvrir le bon type de consultation. Medora distingue ces types pour la facturation, le tableau de bord et certains droits d'accès.

4. Philosophie opérationnelle

Principe	Application
Sécurité patient d'abord	Identité vérifiée, escalade explicite, pas de contournement silencieux
Simplicité	Workflows courts, libellés clairs, peu de navigation profonde
Moindre privilège	Chaque rôle accède uniquement aux écrans nécessaires
Honnêteté produit	Limites documentées (cloud, pas de diagnostic automatique)
Français UI	Terminologie canonique — voir glossaire
Phase discipline	MVP clinique d'abord ; pas de promesse entreprise prématurée

5. Philosophie workflow

Le parcours patient type aux urgences :

Accueil (Vol. 1) → Triage (Vol. 2) → Tableau urgences
→ Documentation prestataire (Vol. 3) → Ordres / résultats (Vol. 5)
→ Soins / réévaluation (Vol. 4) → Orientation + exécution sortie (Vol. 6)

Distinctions critiques (canon) :

Concept	Signification
Orientation	Décision clinique d'issue (domicile, observation, transfert...)
Disposition	Panneau / zone dossier / synthèse opérationnelle
Décision prestataire sortie	Acte médical documenté
Exécution sortie infirmière	Acte infirmier distinct (Volume 4)

Voir french-terminology-canon.md et french-terminology-risks.md.

6. Philosophie responsive / mobile (initiative 19M)

Medora-S adopte une approche **responsive pragmatique** (initiative 19M) :

- Navigation mobile (drawer, touch targets)
- Layouts adaptés tablette pour triage, chevet, documentation prestataire
- Fichiers auxiliaires (pharmacie, labo, imagerie) avec modes compact

Ce n'est pas : une application native offline-first complète.

Volume dédié : Volume 8 — Mobile et Haïti.

Checklist terrain : **19M.8** (régression cross-device).

7. Philosophie gouvernance

7.1 Carry-forward (19T)

Les données de triage peuvent être **reprises** en documentation prestataire et infirmière. Le personnel doit **revoir section par section** — la reprise n'est pas une validation automatique.

Référence : docs/clinical/longitudinal-history-production-validation-19T4.md · Volume 2.

7.2 Intelligence motif (19MDM)

Les **inserts cliquables** (pastilles HPI/ROS/MDM par motif) sont une **aide à la saisie** — insertion **manuelle** uniquement. Ce n'est **pas** un diagnostic automatique.

Référence : Volume 3 · manifeste COMPLAINT_INTELLIGENCE_SUBGROUP_CANON.

7.3 ROI et export dossier (Phase 5G / 5F)

Le **dévoilement de dossier (ROI)** et l'**export du dossier** sont des workflows **audités**, réservés aux rôles autorisés. Volume 6–7.

7.4 Modèles de sortie gouvernés

Les gabarits de sortie et registres de gouvernance clinique sont administrés — ne pas contourner par copier-coller non tracé.

8. Philosophie déploiement Haïti

Facteur	Implication manuel
Effectifs réduits	Formation par rôle, super-utilisateurs
Connectivité variable	Protocole papier parallèle obligatoire
Tablettes chevet	Volume 8 prioritaire
Cadre professionnel local	Titres IPS/IDE/médecin validés avec direction
Cloud-dépendant	Pas de promesse hors-ligne complet

Références : docs/HAITI_MVP_PILOT.md · Annexe A — Haïti · Volume 9.

9. Mode d'emploi du manuel

Besoin	Où aller
Premier jour accueil	Volume 1 + checklist Volume 9
Formation triage	Volume 2 + scénarios Annexe D
Cartographie écrans	Index routes
Terme inconnu	Glossaire
Workflow par rôle	Index workflows
Sigle US (LWBS, EMTALA...)	Index acronymes
Export PDF formation	Checklist export
Revue annuelle	Gouvernance documentaire

Ordre lecture recommandé nouvel utilisateur : Introduction → Glossaire (aperçu) → Volume métier assigné → Volume 8 (mobile) → Volume 9 (certification).

10. Limites et responsabilité institutionnelle

Ce manuel soutient l'exploitation, la formation et l'intégration de Medora-S. Il ne remplace pas les politiques institutionnelles, le jugement clinique, ni les obligations légales locales.

Élément	Statut
Certification opérationnelle Medora (Vol. 9)	Attestation interne établissement — licence professionnelle
Protocole papier panne	Obligation institutionnelle — documenté, non imposé par le logiciel
Connectivité cloud	Medora dépendant du cloud en production MVP
Traduction future EN	Prévue gouvernance documentaire — édition FR = canon opérationnel

Medora-S **assiste** les workflows. Le personnel et la direction de l'établissement restent responsables de la qualité des soins, de l'exactitude des données et de la conformité locale.

Références

- Table des matières
 - Canon terminologique
 - Inventaire workflows
 - Manifeste d'assemblage
-

Fin introduction générale — M-BOOK.FR.11

Glossaire — Manuel entreprise Medora-S (FR)

Phase : M-BOOK.FR.11

Section : I.2

Source canonique : french-terminology-canon.md

Registre risques : french-terminology-risks.md

Ce glossaire **consolide** les termes opérationnels pour l'assemblage entreprise. En cas de conflit, le canon terminologique prévaut.

1. Terminologie Medora de base

Terme (EN)	Terme français officiel	Définition opérationnelle	Volume(s)
Patient	Patient	Personne identifiée dans le dossier	1
Encounter	Consultation	Instance de prise en charge liée à une visite	1, 3
Visit	Visite	Épisode administratif ou clinique	1
ED encounter	Consultation d'urgence	Type EMERGENCY — parcours ED complet	1, 2
Urgent care	Consultation de soins urgents	Type URGENT_CARE	1
Clinic visit	Consultation clinique	Type OUTPATIENT	1
Triage	Triage	Évaluation initiale gravité + accueil urgences	2
Trackboard	Tableau des urgences	Vue consultations ouvertes	1, 2, 8
Reassessment	Réévaluation	Nouvelle évaluation clinique après intervalle	2, 4
Chief complaint	Motif de consultation	Raison principale de la visite	2, 3
Orders	Ordres ; Prescriptions / demandes	Médicaments, labo, imagerie	3, 5
Results	Résultats	Valeurs labo / comptes-rendus imagerie	5
Follow-up	Suivi	Continuité après la visite	1, 6
Task queue	File de travail ; File	Liste ordonnée tâches département	5
Assignment	Attribution ; Affectation	Médecin / infirmier responsable	2, 4
Escalation	Escalade	Montée en charge équipe / supervision	2, 4, 8
Boarding	Attente de lit ; Séjour prolongé	Délai long aux urgences sans orientation	2, 6
Critical patient	Patient critique	ESI 1-2 ou gravité équivalente	2

2. Orientation, disposition et sortie

Terme	Terme français	Notes	Volume(s)
Disposition (decision)	Orientation	Acte décisionnel médical	3, 6
Disposition (panel)	Disposition	Panneau / zone dossier / synthèse	3, 6

Terme	Terme français	Notes	Volume(s)
Discharge (decision)	Sortie (décision)	Décision prestataire	3, 6
Discharge execution	Exécution sortie	Acte infirmier distinct	4, 6
Observation	Observation ; Observation et court séjour	Prise en charge prolongée	6
Admission	Admission	Décision admission observation	6
Transfer	Transfert	Vers autre établissement	6
Return precautions	Consignes de retour ; Signes d'alarme	Instructions réévaluation si aggravation	3, 4, 6
LWBS	Départ avant fin de prise en charge	Acronyme US — expansion FR en formation	6
LAMA	Contre avis médical (LAMA)	Sortie contre avis	6

Règle canon : ne pas confondre **orientation** (décision) et **disposition** (panneau).

3. Documentation clinique

Sigle / terme	Terme français	Notes
HPI	Histoire de la maladie (HPI)	Sigle autorisé
ROS	Revue des systèmes (ROS) ; Revue ciblée	ED : revue ciblée
Physical exam	Examen physique	—
MDM	Aide à la décision médicale (MDM)	Sigle entre parenthèses
Clinical impression	Impression clinique	—
Differential diagnosis	Diagnostic différentiel	—
Red flags	Signaux d'alerte ; Signes d'alarme	Éviter « red flags » en UI FR
Provider documentation	Documentation médicale	Section médecin ED
Shared planning	Planification partagée ; Dossier partagé	Champs communs équipe

4. Triage et soins infirmiers

Terme	Terme français	Notes
ESI	Indice ESI ; Gravité triage ESI	Sigle conservé
Pain scale	Échelle de douleur	Protocole local
MAR	Administration de médicament	Acte infirmier

Terme	Terme français	Notes
Nursing care	Soins infirmiers	Volume 4
Discharge execution	Exécution sortie ; Exécution équipe	décision médicale
IDE	Infirmier(ère) diplômé(e) d'État	Contexte Haïti — UI : Infirmier(ère)

5. Carry-forward et historique (19T)

Terme	Terme français	Définition
Carry-forward history	Reprise d'antécédents ; Antécédents repris	Données triage reprises en documentation
Longitudinal history	Historique longitudinal	Vue multi-consultations
Reconciliation	Réconciliation	Revue section par section obligatoire
Clinical history	Antécédents cliniques	Allergies, médicaments, problèmes actifs

Gouvernance 19T : la reprise assiste la saisie ; le clinicien **valide** chaque section.

6. Intelligence motif (19MDM)

Terme	Terme français	Règle
Complaint intelligence	Intelligence motif (inserts cliquables)	Aide saisie — pas diagnostic auto
Clickable inserts	Pastilles cliquables	Insertion manuelle
Template subgroup	Sous-groupe de motif	8 sous-groupes canon (manifeste)
Discharge template	Modèle de sortie	Gabarit gouverné — distinct registre

Interdit en formation : « appliquer automatiquement », « diagnostic suggéré par le système ».

7. ROI, audit et gouvernance

Terme	Terme français	Notes
ROI	Dévoilement de dossier (ROI)	Workflow audité Phase 5G
Chart export	Export du dossier	Phase 5F
Audit log	Journal d'audit	Actions sensibles
Clinical governance	Gouvernance clinique	Modèles, garde-fous
Pending results	Résultats en attente	Analyses non finalisées
Pending sync	Synchronisation en attente	Post-reconnexion — vérifier

8. Mobile, tablette et connectivité

Terme	Terme français	Notes
Mobile nav	Navigation mobile	Drawer, menu principal
Touch target	Zone tactile	Initiative 19M
Responsive layout	Mise en page responsive	19M.1–19M.9
Cloud-dependent	Dépendant du cloud	Pas de mode offline complet MVP
Paper protocol	Protocole papier	Continuité panne
Bedside tablet	Tablette chevet	Usage clinique Haïti

9. Rôles (libellés formation)

Rôle (EN)	Terme français	Route landing typique
FRONT_DESK	Personnel d'accueil	/app/registration
RN	Infirmier(ère)	/app/nursing
PROVIDER	Médecin ; Professionnel de santé	/app/provider
PHARMACY	Pharmacien	/app/pharmacy-worklist
LAB	Technicien de laboratoire	/app/lab-worklist
RADIOLOGY	Technicien en imagerie	/app/rad-worklist
ADMIN	Administrateur	/app/admin
BILLING	Facturation	/app/billing

10. Abréviations approuvées (aperçu)

Liste complète : 06-index-acronymes.md

Sigle	Expansion FR
ED	Urgences (service)
UC	Soins urgents
ESI	Échelle de gravité infirmière (Emergency Severity Index)
HPI	Histoire de la maladie
ROS	Revue des systèmes
MDM	Aide à la décision médicale
ROI	Dévoilement de dossier (Release of Information)
PMH	Antécédents médicaux
PSH	Antécédents chirurgicaux
EMTALA	Loi fédérale US transferts urgences — contexte pilote

Références

- Canon terminologique complet
- Manifeste machine

Index des workflows — Manuel entreprise Medora-S

Phase : M-BOOK.FR.11

Section : I.3

Source : french-workflow-inventory.md

Index croisé pour formation, revue direction et export. Références volumes M-BOOK.FR.2–10.

Légende

Colonne	Valeurs
Priorité manuel	P1 = go-live · P2 = post go-live
Mobile	Oui / Partiel / Faible
Gouvernance	Sensibilité données / décisions / audit
Urgence	Critique / Élevé / Moyen / Faible (impact erreur)

1. Index par rôle

Personnel d'accueil (FRONT_DESK)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
Accueil et inscription patient	1	P1	Partiel	Identité — élevée
Ouverture visite / consultation	1	P1	Partiel	Élevée
Distinction UC vs ED	1	P1	—	Moyenne
Exécution sortie (accueil)	6	P1	Partiel	Élevée

Infirmier(ère) triage (RN)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
Triage aux urgences	2	P1	Oui	Critique
Tableau des urgences	2	P1	Oui	Élevée
Carry-forward / reprise triage	2	P2	Oui	Moyenne (19T)
Réévaluation ESI	2	P1	Oui	Critique

Médecin / IPS (PROVIDER)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
Documentation médicale ED	3	P1	Oui	Critique
Intelligence motif (19MDM)	3	P2	Oui	Moyenne
Prescription et demandes	3, 5	P1	Partiel	Critique
Orientation / disposition	3, 6	P1	Partiel	Critique
Historique longitudinal	3	P2	Partiel	Moyenne

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
----------	------	----------	--------	-------------

Infirmier(ère) soins (RN)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
Soins infirmiers et réévaluation	4	P1	Oui	Élevée
Exécution sortie	4, 6	P1	Oui	Critique
Administration médicament (MAR)	4	P1	Oui	Critique

Pharmacie (PHARMACY)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
File pharmacie et délivrance	5	P2	Faible	Critique
Inventaire / stock	5, 7	P2	Faible	Élevée

Laboratoire (LAB)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
File laboratoire	5	P2	Partiel	Élevée
Résultats et réconciliation	5	P2	Partiel	Élevée

Imagerie (RADIOLOGY)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
File imagerie	5	P2	Partiel	Élevée
Résultats critiques	5	P2	Partiel	Élevée

Administration (ADMIN)

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
Utilisateurs et rôles	7	P2	Faible	Critique
Journal d'audit	7	P2	Faible	Critique
ROI (dévoilement dossier)	6, 7	P2	Faible	Critique
Santé système / go-live	7, 8	P2	Faible	Élevée
Gouvernance médicaments	7	P2	Faible	Élevée

Transversal — tous rôles

Workflow	Vol.	Priorité	Mobile	Gouvernance
Navigation mobile (19M)	8	P1	Oui	Moyenne
Connectivité / pending sync	8	P1	Oui	Élevée
Formation / certification	9	P1	Partiel	Faible
Protocole papier panne	8, Annexe E	P1	—	Critique

2. Index par département

Département	Workflows clés	Volumes
Accueil	Inscription, routage, identité	1
Urgences — triage	Triage, ESI, tableau	2
Urgences — médical	Documentation, ordres, orientation	3, 6
Urgences — infirmier	Soins, réévaluation, exécution sortie	4, 6
Observation	Admission, handoff	6
Pharmacie	File, dispense, stock	5, 7
Laboratoire	File, résultats	5
Imagerie	File, comptes-rendus	5
Dossiers médicaux	ROI, export	6, 7
IT / Admin	Utilisateurs, audit, déploiement	7, 8
Formation	Onboarding, certification	9

3. Index par urgence opérationnelle

Niveau	Workflows
Critique — erreur = risque patient majeur	Triage ESI, documentation MDM, dispense pharmacie, orientation/sortie, identité patient
Élevé	Tableau urgences, soins infirmiers, résultats labo/rad, ROI, audit
Moyen	Carry-forward, intelligence motif, mobile ergonomie
Faible	Navigation générale, libellés cosmétiques

4. Index par pertinence mobile

Mobile	Workflows	Volumes
Oui (priorité capture)	Triage, chevet, documentation prestataire, réévaluation, tableau urgences	2, 3, 4, 8
Partiel	Accueil, ordres, files labo/rad, disposition	1, 5, 6
Faible	Admin, ROI, inventaire pharmacie détaillé	5, 7

Voir 07-index-captures-ecran.md.

5. Index par sensibilité gouvernance

Domaine	Workflows	Référence gouvernance
Orientation vs disposition	Décision vs panneau vs exécution	Canon · Vol. 6

Domaine	Workflows	Référence gouvernance
Carry-forward (19T)	Reprise triage	19T4 · Vol. 2
Intelligence motif (19MDM)	Pastilles HPI/ROS/MDM	Manifeste sous-groupes · Vol. 3
ROI (5G)	Dévoilement dossier	Vol. 6–7
Export dossier (5F)	Extraction légale	Vol. 6–7
Modèles sortie	Gabarits gouvernés	Vol. 3, 6, 7
Identité patient	Inscription, doublons	Vol. 1 · risques terminologiques

6. Matrice synthèse P1 / P2

P1 (go-live)	P2 (post go-live)
Accueil, triage, tableau, doc prestataire, soins, disposition, mobile	Pharmacie, labo, imagerie, transfert, ROI, admin, historique, intelligence motif

Références routes

Index routes opérationnelles

Fin index workflows — M-BOOK.FR.11

Index des routes opérationnelles — Manuel entreprise Medora-S

Phase : M-BOOK.FR.11

Section : I.4

Ce document recense les **routes utilisateur visibles** dans la navigation opérationnelle Medora-S.

Exclus : routes API internes, pages de développement, endpoints techniques non exposés au personnel clinique.

Source navigation : `apps/web/src/components/app-shell/sidebarNavConfig.ts`

Légende

Colonne	Description
Mobile	Pertinence tablette/téléphone en pratique clinique
Vol.	Volume handbook principal

Accueil et patients

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
<code>/app/accueil</code>	Accueil, inscription, ouverture visite	FRONT_DESK, ADMIN	1	Partiel
<code>/app/patients</code>	Recherche et fiche patient	FRONT_DESK, RN, PROVIDER, ADMIN	1	Partiel
<code>/app/encounters</code>	Liste consultations	RN, PROVIDER, ADMIN	1, 3	Partiel
<code>/app/trackboard</code>	Tableau de bord général	ADMIN, PROVIDER, RN	1	Oui

Urgences (ED)

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
<code>/app/emergency-triage</code>	Urgences — consultations ouvertes	RN, PROVIDER, ADMIN	1, 2	Oui
<code>/app/emergency-activation</code>	Activation / désactivation	RN, ADMIN	2	Oui
<code>/app/emergency-chart</code>	Consultation urgence	RN, PROVIDER	2, 3, 4	Oui
<code>/app/emergency-chart-history</code>	Historique consultation	RN, PROVIDER	3, 4	Oui
<code>/app/hospitalization</code>	Observation / hospitalisation	RN, PROVIDER, ADMIN	6	Partiel

Documentation clinique

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
/app/provider	Documentation médicale, workspace prestataire	PROVIDER, RN, ADMIN	3	Oui
/app/nursing	Soins infirmiers, réévaluation	RN, PROVIDER, ADMIN	4	Oui
/app/follow-up	Suivis post-visite	RN, PROVIDER, FRONT_DESK, ADMIN	6	Faible

Auxiliaires — pharmacie, labo, imagerie

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
/app/pharmacy/lookup	Hub pharmacie — ordres à délivrer	PHARMACY, ADMIN	5	Partiel
/app/pharmacy/hub	Hub pharmacie	PHARMACY, ADMIN	5	Faible
/app/pharmacy/inventory	Vue des médicaments	PHARMACY, ADMIN	5, 7	Faible
/app/pharmacy/disperse	Dispense	PHARMACY, ADMIN	5	Faible
/app/pharmacy/lowstock	Alertes stock bas	PHARMACY, ADMIN	5	Faible
/app/pharmacy/expiration	Alertes péremption	PHARMACY, ADMIN	5	Faible
/app/lab-workflow	Flux laboratoire	LAB, RN, ADMIN	5	Partiel
/app/lab-workflow/commande/{labId}	Détail commande {labId}	LAB, ADMIN	5	Partiel
/app/rad-workflow	Flux imagerie	RADIOLOGY, ADMIN	5	Partiel
/app/rad-workflow/commande/{orderId}	Détail commande {orderId}	RADIOLOGY, ADMIN	5	Partiel

Facturation

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
/app/billing	Facturation	BILLING, ADMIN, FRONT_DESK	—	Faible

Hors scope volumes cliniques MVP — référence navigation uniquement.

Administration

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
/app/admin	Hub administration	ADMIN	7	Faible
/app/admin/users	Gestion utilisateurs et rôles	ADMIN	7	Faible
/app/admin/audit	Journal d'audit	ADMIN	7	Faible
/app/admin/roi	Workflow dévoilement dossier (ROI)	ADMIN	6, 7	Faible
/app/admin/roi/monitor	Surveillance ROI	ADMIN	6, 7	Faible
/app/admin/exports	Exports système	ADMIN	7	Faible
/app/admin/golive	Checklist go-live	ADMIN	7, 8	Faible

Route	Objectif opérationnel	Utilisateurs	Vol.	Mobile
/app/admin/système-svt	Système SVT	ADMIN	7, 8	Faible
/app/admin/back-office	Back-office	ADMIN	7	Faible
/app/admin/compliance	Compliance	ADMIN	7	Faible
/app/admin/medication-master	Préparation-médicaments	ADMIN	7	Faible
/app/admin/medication-governing	Préparation-médicaments	ADMIN	7	Faible
/app/reports	Rapports administratifs	ADMIN	7	Faible

Santé publique / MSPP (selon rôle)

Route	Objectif	Utilisateurs	Vol.
/app/public-health/synthes	Synthèse santé publique	ADMIN (selon config)	—
/app/public-health/vaccinations	Vaccinations	ADMIN	—
/app/public-health/disease-reports	Maladies	ADMIN	—
/app/mspp/*	Modules MSPP	ADMIN (accès restreint)	—

Modules santé publique — voir documentation MSPP séparée ; formation ED prioritaire sur Volumes 1–9.

Landing par rôle (post-connexion)

Rôle	Route d’atterrissage typique
FRONT_DESK	/app/registration
RN	/app/nursing
PROVIDER	/app/provider
PHARMACY	/app/pharmacy
LAB	/app/lab-worklist
RADIOLOGY	/app/rad-worklist
ADMIN	/app/admin
BILLING	/app/billing

Source : `apps/web/src/lib/landingRoute.ts`

Notes export / formation

1. Les routes avec `{id}` utilisent l’identifiant de consultation — **ne pas** capturer d’écran avec ID patient réel.
2. Préférer dossier **formation** / **test** pour captures (voir 07-index-captures-ecran.md).
3. En cas de doute sur une route, vérifier le menu latéral du rôle concerné — seules les routes **autorisées RBAC** apparaissent.

Références

- Index workflows
- Volume 8 — navigation mobile
- sidebarNavConfig.ts

Fin index routes — M-BOOK.FR.11

Index des acronymes — Manuel entreprise Medora-S

Phase : M-BOOK.FR.11

Section : I.5

Acronymes **approuvés** pour formation et manuel. En UI française, préférer l'expansion lors de la première occurrence sur un écran de formation.

Source : french-terminology-canon.md · manifeste APPROVED_FR_UI_ABBREVIATIONS

Acronymes cliniques et documentation

Sigle	Expansion française	Signification opérationnelle	Précaution gouvernance
ED	Urgences (service) ; Emergency Department	Service d'urgence type parcours EMERGENCY	Distinct de UC
UC	Soins urgents ; Urgent Care	Consultation URGENT_CARE — parcours réduit	Ne pas confondre avec ED
ESI	Échelle de gravité infirmière (Emergency Severity Index)	Score triage 1–5	certification ESI internationale complète
HPI	Histoire de la maladie (History of Present Illness)	Narratif motif et chronologie	—
ROS	Revue des systèmes (Review of Systems)	Symptômes par système	ED : « revue ciblée »
MDM	Aide à la décision médicale (Medical Decision Making)	Complexité et justification décision	Ne pas traduire par « diagnostic auto »
PMH	Antécédents médicaux (Past Medical History)	Historique médical	—
PSH	Antécédents chirurgicaux (Past Surgical History)	Chirurgies antérieures	—
MAR	Administration de médicament	Registre actes infirmiers médicaments	Critique sécurité
NIR	Numéro d'identification / registre patient	Identifiant patient (contexte local)	Valider mapping Haïti

Acronymes orientation / sortie / conformité

Sigle	Expansion française	Signification opérationnelle	Précaution gouvernance
ROI	Dévoilement de dossier (Release of Information)	Accès audité au dossier patient	Phase 5G — admin uniquement
LWBS	Départ avant fin de prise en charge (Left Without Being Seen)	Patient quitte avant évaluation complète	Terme US — adapter manuel Haïti
LAMA	Contre avis médical (Left Against Medical Advice)	Sortie refusant recommandations	Documenter clairement
EMTALA	Loi fédérale US sur les transferts d'urgence	Contexte conformité pilote US	Expliquer portée limitée Haïti

Acronymes produit et gouvernance

Sigle	Expansion	Signification	Précaution
19M	Initiative responsive mobile Medora	Layouts, touch, cross-device	19M.1–19M.9
19T	Initiative carry-forward / historique	Reprise triage, longitudinal	Revue section par section
19MDM	Initiative intelligence motif	Pastilles HPI/ROS/MDM	Insertion manuelle seulement
5F	Phase export dossier	Chart export	Audit requis
5G	Phase ROI	Dévoilement dossier	Gouvernance stricte
M-BOOK	Manuel opérationnel Medora	Collection documentation FR	FR.1–FR.11
DME	Dossier médical électronique	Synonyme EMR/EHR en contexte FR	—
IDE	Infirmier(ère) diplômé(e) d'État	Titre Haïti	UI : Infirmier(ère) préféré
IPS	Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)	Provider avancé selon licence	Valider cadre local
MSPP	Ministère Santé Publique et Population (Haïti)	Modules épidémiologie	Distinct ED

Acronymes formation (Volume 9)

Sigle	Expansion	Notes
SU	Super-utilisateur	Niveau certification 3
P1 / P2	Priorité manuel go-live / post go-live	Inventaire workflows
Onboarding	Intégration initial	Parcours nouvel utilisateur

Acronymes anatomiques (documentation — sigles anglais acceptés)

Utilisés dans sous-groupes intelligence motif — **glossaire formation obligatoire** :

Sigle	Expansion
GU	Appareil génito-urinaire
MSK	Musculo-squelettique
ORL	Oto-rhino-laryngologie
CV	Cardio-vasculaire
GI	Gastro-intestinal

Règles d’usage manuel / UI

1. **Première occurrence** dans un chapitre formation : sigle + expansion FR entre parenthèses.
 2. **UI produit** : préférer termes français canon — voir registre risques pour fuites anglais.
 3. **Ne pas inventer** de traductions littérales dangereuses (« médicalement autorisé », « patient stable », « normal » pour résultats) — voir french-terminology-risks.md.
 4. **Haïti** : valider titres professionnels (médecin, IDE, IPS) avec direction clinique pilote.
-

Références

- Glossaire
 - Canon terminologique
-

Fin index acronymes — M-BOOK.FR.11

Volume 1 — Accueil, inscription et arrivée patient

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.2

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Personnel d'accueil, infirmier(ère) de triage, équipe urgences, superviseurs, administrateurs

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	1 — Accueil, inscription et arrivée
Routes principales	/app/registration, /app/patients, /app/emergency/triage, /app/emergency/trackboard, /app/trackboard
Rôles cibles	FRONT_DESK, RN, PROVIDER, ADMIN
Révision recommandée	Annuelle ou après changement majeur de parcours

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que Medora-S ?

Medora-S est un dossier médical électronique (DME) conçu pour des cliniques et services d'urgence en environnement à ressources limitées, avec une priorité de déploiement en **Haïti**. Il soutient l'accueil patient, la documentation clinique, les ordres, les résultats, la pharmacie, la facturation et la gouvernance — dans une interface **française** pour le personnel.

Medora-S **assiste** les workflows ; il ne remplace pas le jugement clinique ni la responsabilité du personnel.

1.2 Accueil et inscription : sens opérationnel

Dans ce manuel :

Terme	Signification opérationnelle
Accueil	Point d'entrée navigation (Accueil dans le menu) — orientation du patient et du personnel
Inscription	Création ou mise à jour de la fiche patient (identité, contact, assurances)
Intake (accueil clinique)	Ouverture d'une consultation (visite) et saisie du contexte d'arrivée
Triage	Évaluation initiale de gravité (ESI, signes vitaux, allergies) — souvent après l'ouverture de la consultation d'urgence

Note terminologique : le menu affiche **Accueil** ; la page principale affiche **Inscription**. Les deux désignent le même parcours d'entrée — voir risques terminologiques.

1.3 Rôle du personnel d'accueil

Le personnel d'accueil est le **gardien de l'identité patient** et du routage initial :

- Rechercher ou créer la fiche patient avec exactitude ;
- Orienter vers la bonne voie (clinique, soins urgents, urgences) selon protocole local ;
- Ne pas improviser de décisions cliniques ;
- Signaler immédiatement toute ambiguïté d'identité, doublon suspect ou patient critique.

1.4 Importance de la qualité d'inscription

Une inscription inexacte entraîne :

- Erreurs de dossier (mauvais patient) ;
- Retards de soins ;
- Problèmes de facturation et de continuité ;
- Risques médico-légaux.

Règle d'or : vérifier **nom**, **date de naissance** et **identifiant** à chaque transition majeure.

1.5 Philosophie opérationnelle : soins urgents vs urgences

Type (produit)	Libellé UI	Usage opérationnel
Consultation d'urgence (EMERGENCY)	Urgences	Parcours ED complet : accueil urgences, tableau des urgences, documentation ED
Soins urgents / intensifs (URGENT_CARE)	Soins urgents / intensifs	Consultation ouverte via dossier patient ; pas de parcours ED dédié identique aux urgences
Clinique (OUTPATIENT)	Clinique	Visites programmées ou ambulatoires

Medora distingue ces types pour la **facturation**, le **tableau de bord** et les **droits d'accès**. Le personnel d'accueil doit connaître le protocole local : **qui** ouvre quel type de consultation et **quand** escalader vers les urgences.

1.6 Responsabilité du personnel

Medora-S assiste les workflows. Le personnel reste responsable de l'**exactitude des données**, de la **vérification d'identité** et des **décisions opérationnelles**.

Le système peut suggérer des patients similaires ou afficher des rappels — il **ne bloque pas** automatiquement toutes les erreurs d'identité.

2. Définitions des rôles

2.1 Agent d'accueil / inscription

Aspect	Détail
Responsabilités	Recherche patient, création fiche, assurances, orientation, liens vers feuille de face et visite
Peut modifier	Données démographiques et administratives autorisées par RBAC ; assurances sur dossier

Aspect	Détail
Ne peut pas	Documenter clinique (HPI, triage complet, ordres, disposition médicale)
Attentes	Double vérification identité ; zéro supposition sur l'orthographe du nom
Escalade	Doublon non résolu, patient agressif, mineur non accompagné, identité inconnue, refus de consentement

Route typique : /app/registration (rôle FRONT_DESK).

2.2 Infirmier(ère) de triage

Aspect	Détail
Responsabilités	Accueil urgences (ouverture consultation urgence), salle, motif ; triage ESI et signes vitaux sur dossier actif
Peut modifier	Triage, signes vitaux, allergies documentées au triage
Ne peut pas	Décision d'orientation finale (médecin) ; facturation
Attentes	Re-vérifier identité à l'accueil urgences ; ESI cohérent avec protocole
Escalade	ESI 1-2, détresse, suspicion AVC, patient instable

Routes : /app/emergency/triage → /app/emergency/active/{id}.

2.3 Personnel urgences (ED)

Aspect	Détail
Responsabilités	Suivi tableau des urgences, assignation, réévaluation, coordination
Peut modifier	Selon rôle (IDE vs médecin) — voir volumes infirmier et médecin
Attentes	Consultations ouvertes visibles ; assignation claire médecin / infirmier

Route : /app/emergency/trackboard.

2.4 Personnel clinique (médecin / IPS)

Aspect	Détail
Responsabilités	Évaluation, ordres, documentation, orientation
Peut modifier	Documentation médicale, ordres, décision d'orientation
Ne peut pas	Contourner RBAC ; fusionner des dossiers patients (non disponible)
Escalade	Acuité croissante, transfert, LAMA, LWBS

2.5 Superviseur

Aspect	Détail
Responsabilités	Effectifs, flux, exceptions, conflits, boarding
Peut	Arbitrer routage, ouvrir voies parallèles en surcharge
Escalade vers admin	Problème compte, ROI, panne prolongée

2.6 Administrateur

Aspect	Détail
Responsabilités	Comptes, établissement, audit, configuration
Peut modifier	Utilisateurs, droits — pas le contenu clinique libre
Attentes	Tracer toute correction d'identité majeure avec processus local

3. Workflows d'arrivée patient

Chaque workflow ci-dessous décrit le **comportement Medora actuel** sauf mention « cible / futur ».

3.1 Nouvelle inscription patient

Flux opérationnel

Accueil (/app/registration)

- Nouveau patient (/app/patients?new=1)
- Saisie identité (nom, DOB, sexe, contact, NIR/identifiant national si disponible)
- Enregistrer
- Retour accueil ou ouverture dossier

Bonnes pratiques

1. Demander **pièce d'identité** ou témoin fiable si disponible.
2. Saisir le nom **exactement** comme sur la pièce.
3. Vérifier la **date de naissance** à voix haute avec le patient.
4. Si le formulaire signale **patients similaires** : STOP — comparer avant de continuer.

Points de contrôle sécurité

- ☐ Nom et prénom complets
- ☐ DOB confirmée
- ☐ Téléphone ou contact d'urgence
- ☐ Doublons examinés

Erreurs fréquentes

- Créer un doublon parce que le nom était mal orthographié à une visite antérieure.
- Ignorer l'alerte « patients similaires » (le système permet **Continuer quand même** — responsabilité staff).

Escalade

Doublon probable → superviseur ; impossible de confirmer identité → protocole patient non identifié (§7.4).
[CAPTURE D'ÉCRAN — Formulaire nouveau patient avec alerte doublons]

3.2 Recherche patient existant

Flux

Accueil → Recherche (nom, téléphone, MRN/NIR affiché)
→ Sélection patient
→ Espace d'inscription (résumé, assurances, liens dossier / feuille de face / visite)

Bonnes pratiques

- Rechercher par **téléphone** si nom incertain.
- Confirmer **deux identifiants** (nom + DOB ou MRN).
- Ne pas ouvrir le mauvais dossier par similarité de nom.

Escalade

Aucun résultat mais patient insiste avoir un dossier → recherche élargie, variantes orthographiques, superviseur.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Espace d'inscription avec patient actif]

3.3 Prévention des doublons

Comportement Medora

Mécanisme	Effet
Alerte patients similaires (création patient)	Avertissement — pas de blocage systématique
Unicité MRN par établissement	Empêche deux MRN identiques au même site
Une consultation ouverte par patient	Empêche deux consultations OPEN simultanées
Fusion de dossiers	Non disponible — processus manuel / admin futur

Checklist anti-doublon

- ☐ Recherche avant création

- ☐ Comparaison DOB + téléphone
 - ☐ Alerte similarité traitée
 - ☐ Superviseur informé si doute persistant
-

3.4 Patient walk-in — urgences (ED)

Flux

Recherche / inscription patient

- Accueil urgences (/app/emergency/triage)
- Sélection patient
- Salle (si applicable), motif de visite, médecin optionnel
- Ouvrir la consultation (type : consultation d'urgence)
- Redirection dossier actif urgences
- Triage complet (ESI, signes vitaux) sur dossier actif
- Visible sur Tableau des urgences

Bonnes pratiques

- Patient critique : **ne pas** retarder les soins pour la saisie — protocole local « soins d'abord » puis documentation.
- Motif saisi = aide au tableau, pas diagnostic.

Erreurs fréquentes

- Confondre **accueil urgences** (ouverture consultation) et **triage complet** (sur dossier actif).
- Oublier de changer de patient si plusieurs arrivées simultanées.

[DIAGRAMME — Walk-in ED : inscription → accueil urgences → triage → tableau]

3.5 Patient soins urgents (UC)

Flux actuel (produit)

Dossier patient → Consultations → Nouvelle consultation

- Type : Soins urgents / intensifs (URGENT_CARE)
- Documentation sur parcours consultation générique

Important : les consultations UC **n'apparaissent pas** sur le **Tableau des urgences** (filtre consultations d'urgence uniquement). Elles peuvent apparaître sur le **Tableau de bord des consultations** (/app/trackboard).

Bonnes pratiques

- Utiliser UC seulement si le protocole local le permet.
 - Surveiller l'évolution : si acuité augmente → §4 (conversion UC → urgence).
-

3.6 Patient clinique programmé

Flux

Dossier patient → Nouvelle consultation → Type Clinique (OUTPATIENT)
OU liste Consultations existante

Pas de passage obligatoire par accueil urgences.

3.7 Arrivée ambulance / EMS

État actuel

Medora-S **ne dispose pas** d'un module EMS/préhospitalier dédié.

Pratique opérationnelle recommandée

1. Inscription / identification patient (ou protocole non identifié).
2. Saisir le **mode d'arrivée** en texte libre lors de l'intake si le champ est disponible sur la consultation.
3. Documenter dans le motif / notes : « Arrivée ambulance — [service] — heure approximative ».
4. Procéder comme walk-in ED si consultation d'urgence requise.

Futur produit : champs structurés EMS — hors scope volume 1.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Champ mode d'arrivée (placeholder)]

3.8 Escalade patient critique

Signaux

- Détresse respiratoire, hémodynamique, altération majeure conscience
- ESI 1-2 au triage
- Suspicion AVC, sepsis, traumatisme grave (protocole local)

Actions

1. **Soins immédiats** selon protocole (ne pas attendre Medora).
2. Ouvrir ou compléter consultation d'urgence dès que possible.
3. Assigner médecin / infirmier sur tableau.
4. Alerter superviseur / responsable salle.

[CRITIQUE] Soins + appel équipe

↓

Documentation parallèle dans Medora

↓

Tableau des urgences : acuité Critique / Surveillance

3.9 Patient transféré entrant

Flux opérationnel

1. Inscription ou recherche patient.
2. Ouvrir **consultation d'urgence** ou reprendre consultation ouverte selon cas.
3. Documenter : établissement d'origine, raison transfert, documents reçus.
4. Motif et triage à jour.

Escalade

Refus de transfert, instabilité en route → médecin responsable + protocole réception.

3.10 Patient de retour (visite récente)

Flux

1. Recherche patient — **ne pas recréer** la fiche.
2. Vérifier consultation **encore ouverte** (une seule OPEN autorisée).
3. Si consultation précédente **terminée** : nouvelle consultation selon type (ED, UC, clinique).
4. Reprendre allergies et antécédents affichés ; confirmer avec patient.

Erreur fréquente

Tenter d'ouvrir une deuxième consultation ouverte → message d'erreur API — résoudre en clôturant ou reprenant la bonne consultation.

4. Workflow hybride UC → urgence (conversion)

Section prioritaire formation — distingue cible opérationnelle et capacités produit actuelles.

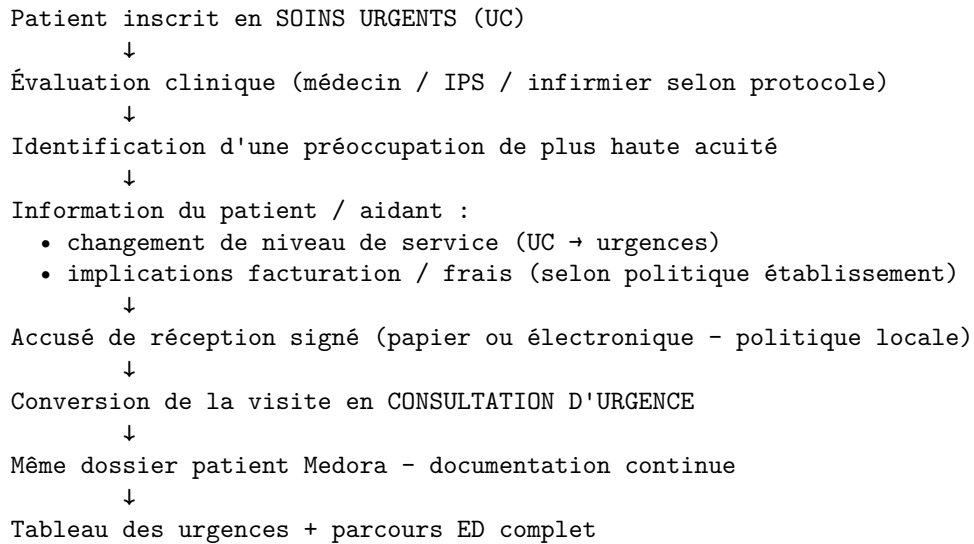
4.1 État actuel du produit Medora-S

Capacité	Statut
Créer consultation UC	Disponible
Créer consultation urgence	Disponible
Convertir automatiquement UC → urgence	Non disponible
Conversion manuelle type de consultation UC → EMERGENCY en un clic	Non disponible
Déclenchement auto par motif de consultation	Non — jamais

Conséquence aujourd'hui : si un patient UC devient une urgence, le protocole local doit définir comment **clôturer ou gérer** la consultation UC et **ouvrir une consultation d'urgence** (ou autre voie approuvée par direction), en documentant la continuité.

4.2 Workflow cible (orientation entreprise — évolution produit)

Workflow **conceptuel** pour déploiements hybrides clinique + urgences :



Principes non négociables

1. **Conversion initiée par le staff clinique** — jamais par le motif saisi seul.
2. **Accord / information patient** requis selon politique locale avant changement de classification facturation.
3. **Documentation** : qui a décidé, quand, ce qui a été expliqué au patient.
4. **Refus patient** : protocole local (LAMA partiel, retour UC, contre-avis documenté).

4.3 Exemples opérationnels

Douleur thoracique en UC

Étape	Action
1	Patient initialement en UC pour symptôme mineur ; douleur thoracique apparaît ou s'intensifie
2	Médecin évalue — ne pas attendre conversion système pour ECG / protocole local
3	Expliquer passage en consultation d'urgence et impact facturation
4	Signature / accord → conversion (cible) ou ouverture consultation urgence (aujourd'hui)
5	Documentation : HPI, ECG, troponine si indiqué — parcours ED

Douleur abdominale avec signes d'alarme

— Même schéma : décision clinique → information patient → escalade → documentation.

Motifs à haut risque (liste indicative formation)

- Douleur thoracique, dyspnée aiguë, déficit neurologique, hémorragie active, traumatisme majeur, suspicion sepsis.

Ne pas escalader automatiquement sans évaluation : simple rhinite en UC reste UC.

4.4 Quand ne pas convertir

- Symptômes stables compatibles avec protocole UC local.
- Patient refuse après information → voir §4.5.
- Ressources ED saturées **ne justifient pas** de rétrograder un patient qui remplit critères urgence — escalade superviseur.

4.5 Refus du patient

1. Documenter ce qui a été expliqué.
2. Documenter le refus.
3. Appliquer protocole **contre avis médical (LAMA)** ou sortie UC selon cas.
4. Superviseur informé si risque vital.

4.6 Implications facturation (orientation)

- La classification **UC vs urgence** affecte typically codes et tarification — **politique établissement**, pas Medora.
- Medora enregistre le **type de consultation** ; la caisse / facturation applique les règles locales.
- L'accusé de réception UC→ED doit être **archivé** selon politique (papier ou future capture Medora).

4.7 Attentes de documentation

- Motif de conversion et heure.
- Clinicien responsable.
- Résumé de l'information donnée au patient.
- Accusé de réception ou note de refus.
- Continuité des allergies et antécédents — **revérifier identité**.

[DIAGRAMME — Conversion consultation UC → urgence]

[CAPTURE D'ÉCRAN — Exemple accusé de réception UC→ED (placeholder)]

5. Introduction au tableau des urgences

5.1 Deux tableaux — ne pas confondre

Écran	Route	Contenu
Tableau des urgences	/app/emergency/trackboard	Consultations d'urgence ouvertes uniquement
Tableau de bord des consultations	/app/trackboard	Consultations ouvertes (clinique, UC, urgence, etc.)

Formation accueil / triage ED : focus **Tableau des urgences**.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Tableau des urgences]

5.2 Informations visibles (vue opérationnelle)

- **Patient** — nom, âge/sexe, MRN/NIR affiché
- **Motif** — motif de consultation
- **Arrivée** — heure d'ouverture
- **Durée** (LOS) — temps depuis ouverture ; codes couleur selon seuils
- **Acuité ESI** — pastilles Critique / Surveillance / Stable
- **Affectations** — médecin, infirmier(ère) ; « — — — » si non assigné
- **Orientation** — badges sortie, admission, observation, transfert, LAMA, LWBS, etc.

5.3 Assignation

- **M'assigner** — **médecin** / **M'assigner** — **infirmier(ère)** : prise en charge visible pour l'équipe.
- Erreur si consultation **terminée** ou rôle insuffisant.

5.4 États d'attente

- Médecin non assigné
- Disposition en attente
- Résultats en attente
- Réévaluation due

5.5 Réévaluation

Cycle infirmier / médecin : réévaluer patient, mettre à jour triage et documentation — visible via indicateurs ops et dossier actif.

5.6 Orientation (disposition)

- **Décision médicale** : enregistrer l'**orientation** (sortie, admission/observation, transfert, etc.).
- **Exécution infirmière** : sortie, instructions, impression — distinct de la décision.

Ne pas interpréter un badge seul comme « patient parti » sans vérifier exécution équipe.

6. Sécurité identité patient

6.1 Prévention mauvais patient

Moment	Action
Accueil	Nom + DOB + MRN/NIR
Accueil urgences	Re-confirmer avant ouverture consultation
Avant médicament / procédure	Protocole local double identifiant
Avant orientation	Confirmer dossier ouvert = bon patient

6.2 Doublons et dossiers multiples

- Traiter alerte similarité **avant** création.
- **Pas de fusion** Medora — escalade admin / processus papier pour rapprochement.

6.3 Orthographe et DOB

- Orthographe légale prioritaire.
- DOB : jour/mois/année confirmés verbalement.
- Corriger via **modification patient** autorisée — tracer selon politique.

6.4 Identifiant national / NIR

- Champ **identifiant national** si disponible.
- UI peut afficher **NIR** pour MRN établissement — former staff à la distinction.
- Pas d'interface registre national automatique (saisie manuelle).

6.5 Patient non identifié (urgence)

Protocole local recommandé :

1. Création temporaire avec identifiant établissement.
2. Nom placeholder approuvé (ex. « INCONNU — [date/heure] »).
3. Rattachement identité dès que possible.
4. Superviseur informé.

6.6 Allergies et antécédents

- Reprendre données existantes ; **confirmer avec patient ou aidant**.
- Ne pas supposer que le dossier est complet.

6.7 Reprise d'antécédents (carry-forward)

Lors du triage / documentation urgence, Medora peut **proposer** des éléments du triage — le clinicien **valide** ; pas d'application silencieuse sans revue.

7. Mobile et tablette

7.1 Alignement initiative 19M (responsive)

Medora a renforcé **urgences, documentation médecin, disposition, listes labo/radio** pour tablettes. L'**accueil / inscription** reste **partiellement** adapté — utilisable mais moins optimisé que le tableau des urgences.

7.2 Appareils recommandés

Zone	Recommandation
Accueil fixe	PC + écran ; tablette acceptable recherche patient
Triage / salle attente ED	Tablette ou PC — paysage pour saisie prolongée
Médecin au chevet	Tablette 10" paysage

7.3 Limitations mobile

- Petits écrans : risque d'erreur de tap — préférer PC pour création patient longue.
- Menu **Navigation** (drawer) : même entrées que desktop — former au geste hamburger.

7.4 Connectivité Haïti

- Bandeau **Hors ligne** / **Synchronisation** possible — ne pas créer patient complexe offline si évitable.
- Message : **vérification doublons limitée hors ligne** — resynchroniser dès que possible.
- Voir docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md pour procédures panne.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Menu navigation mobile]

8. Sécurité opérationnelle et escalade

8.1 Quand appeler le superviseur

- Boarding extrême / saturation salle
- Conflit identité ou doublon
- Refus de soins / agitation
- Demande exception RBAC
- Panne Medora > seuil local

8.2 Correction d'inscription

1. Ouvrir dossier patient → modifier champs autorisés.
2. Documenter correction (note locale / registre papier si requis).
3. Admin si erreur MRN / compte.

8.3 Panne système (haut niveau)

- Passer registre papier accueil.
- Après reprise : saisie **sans antider** champs système — heure papier en note structurée.
- Voir runbook downtime.

8.4 Barrière linguistique

- Interprète ou staff bilingue.
- Documenter langue utilisée et personne traduisant.
- Ne pas deviner consentement.

8.5 Patient agressif ou perturbateur

- Sécurité physique prioritaire — protocole établissement.
- Documentation ultérieure dans dossier si sécurité le permet.

8.6 Consentement et litiges paiement

- Consentement : protocole juridique local — admin / direction.
 - Paiement : **escalade administrative**, pas décision infirmière/médicale clinique.
-

9. Résumé opérationnel rapide

9.1 Checklist inscription

- ☐ Recherche effectuée avant création
- ☐ Nom légal + DOB confirmés
- ☐ Contact ou aidant
- ☐ Alerte doublon traitée
- ☐ Assurances si applicable

9.2 Checklist intake (accueil clinique)

- ☐ Bon patient sélectionné

- ☐ Type de consultation correct (clinique / UC / urgence)
- ☐ Motif saisi
- ☐ Salle / arrivée documentée si protocole
- ☐ Orientation vers triage ou clinicien

9.3 Checklist anti-doublon

- ☐ Similarités examinées
- ☐ Superviseur si doute
- ☐ Pas de nouvelle fiche si dossier existe

9.4 Checklist escalade UC → urgence

- ☐ Décision **clinique** documentée
- ☐ Patient informé (facturation / niveau de soins)
- ☐ Accusé ou refus documenté
- ☐ Consultation urgence ouverte / convertie selon protocole
- ☐ Identité re-vérifiée
- ☐ **Pas** de conversion auto par motif seul

9.5 Checklist anti mauvais patient

- ☐ Nom + DOB à l'accueil
- ☐ Re-vérification à accueil urgences
- ☐ MRN/NIR cohérent sur écran et bracelet local
- ☐ Antécédents / allergies confirmés

10. Gouvernance du manuel

10.1 Versionnement

Version	Date	Auteur	Changements
1.0.0-draft	M-BOOK.FR.2	Équipe Medora-S	Volume 1 initial

10.2 Maintenance

Rôle	Responsabilité
Direction clinique pilote	Validation contenu clinique/opérationnel
Administration Medora	Exactitude routes et RBAC
/ IT	
Référent terminologie	Alignement canon

10.3 Mises à jour

- Toute modification de parcours produit → révision du volume concerné.
- Lien obligatoire vers manifeste tests `frenchTerminologyCanonManifest.ts` pour labels UI cités.

10.4 Formation

- Intégration **obligatoire** pour tout nouveau staff accueil / triage ED.
- Quiz oral : UC vs urgence, doublons, mauvais patient.
- Révision **annuelle** minimum.

10.5 Révision annuelle

Vérifier : routes, rôles RBAC, workflow UC→ED (statut produit), terminologie, runbooks downtime.

Annexes

A. Routes et libellés UI (référence formation)

Route	Libellé menu / page
<code>/app/registration</code>	Accueil / Inscription
<code>/app/emergency/triage</code>	Accueil urgences
<code>/app/emergency/trackboard</code>	Urgences
<code>/app/trackboard</code>	Tableau de bord

B. Références internes

- Canon terminologique
- Inventaire workflows
- Risques terminologiques
- `docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md`
- `docs/OBSERVATION_POSITIONING.md`
- `docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md`

C. Placeholders visuels (production future)

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Tableau des urgences]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Accueil urgences — ouverture consultation]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Espace d'inscription — assurances]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Alerte patients similaires]
- [DIAGRAMME — Conversion consultation UC → urgence]
- [DIAGRAMME — Walk-in : inscription → triage → tableau]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Menu navigation mobile]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Exemple accusé de réception UC→ED]

Fin du Volume 1 — M-BOOK.FR.2

Volume 2 — Triage et intake clinique

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.3

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Infirmier(ère) de triage, infirmier(ère) aux urgences, personnel d'accueil, médecins, superviseurs

Prérequis : Volume 1 — Accueil, inscription et arrivée

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	2 — Triage et intake clinique
Routes principales	/app/emergency/triage, /app/emergency/active/{id}, /app/emergency/chart/{id}, /app/emergency/trackboard
Rôles cibles	RN, PROVIDER, FRONT_DESK (accueil urgences), ADMIN
Architecture liée	Carry-forward 19T.1–19T.3 · Responsive 19M
Révision recommandée	Annuelle ou après changement triage / carry-forward

1. Introduction au triage

1.1 Objectif du triage

Le **triage** est l'évaluation initiale structurée qui permet de :

- **Prioriser** les patients selon l'acuité perçue ;
- **Identifier rapidement** les signaux d'alerte (détresse, AVC, sepsis, etc.) ;
- **Documenter** signes vitaux, allergies, médicaments domicile et antécédents pertinents ;
- **Orienter** le patient vers la salle d'attente, le box ou une prise en charge immédiate selon protocole local.

1.2 Objectifs opérationnels

Objectif	Description
Sécurité	Réduire le risque de sous-triage en salle d'attente
Flux	Alimenter le tableau des urgences avec motif, ESI, affectations
Continuité	Reprendre et revoir les antécédents connus (carry-forward)
Traçabilité	Créer une base documentaire pour le médecin et les réévaluations infirmières

1.3 Triage vs évaluation médicale

Le triage soutient la priorisation et la sécurité. Il ne remplace pas l'évaluation et la décision du prestataire clinique.

Triage (infirmier)	Évaluation prestataire
ESI, signes vitaux, dépistages structurés	HPI, examen, MDM, orientation
Allergies / médicaments documentés	Prescription, ordres, diagnostic
Signaux d'alerte opérationnels	Plan thérapeutique

1.4 Intake clinique : urgences vs soins urgents

Parcours	Route / produit	Triage Medora
Consultation d'urgence	Accueil urgences → dossier actif urgences	Complet — panneau triage ED (EmergencyTriagePanel)
Soins urgents (UC)	Consultation via dossier patient	Pas le même parcours ED dédié ; triage selon protocole local sur consultation générique
Clinique	Consultation ambulatoire	Onglet signes vitaux simplifié possible — pas le panneau triage ED complet

Volume 1 couvre l'ouverture de consultation ; ce volume couvre la **documentation triage ED** après accueil urgences.

1.5 Importance de la réévaluation

L'état du patient **évolue**. Medora prévoit :

- **Modification de l'ESI** en rouvrant le triage (pas d'écran « réévaluation ESI » séparé) ;
- **Réévaluation infirmière** sur le dossier actif (document append-only) ;
- **Signes vitaux rapides** sur l'espace de travail actif.

La réévaluation est une **surveillance clinique continue**, pas un formulaire unique à la fin.

1.6 Responsabilité du personnel

Medora-S propose des rappels (allergies manquantes, signes vitaux incomplets, carry-forward en attente). Le personnel **vérifie, corrige et confirme** — les données reprises ne sont **pas** une vérité automatique.

2. Définitions des rôles

2.1 Infirmier(ère) de triage

Aspect	Détail
Responsabilités	Accueil urgences (si délégué), triage complet, ESI, dépistages AVC/sepsis, allergies/médicaments, revue carry-forward
Autorité d'escalade	ESI 1-2, détresse, suspicion AVC/sepsis → équipe + superviseur selon protocole
Réévaluation	Initie réévaluation infirmière si détérioration ; met à jour triage/ESI si protocole le permet
Documentation	Enregistrer triage avant de considérer le patient « trié » opérationnellement

2.2 Personnel d'accueil

Aspect	Détail
Responsabilités	Identité, orientation vers accueil urgences, pas de saisie triage clinique complète
Escalade	Patient instable → infirmier / médecin avant file d'attente prolongée
Documentation	Motif initial si saisi à l'accueil — le triage infirmier complète

2.3 Personnel urgences (ED)

Aspect	Détail
Responsabilités	Suivi tableau, assignation, coordination salle d'attente
Réévaluation	Soutenir réévaluations ; alerter si patient non revu selon délai local

2.4 Prestataire clinique (médecin / IPS)

Aspect	Détail
Responsabilités	Évaluation médicale, ordres, orientation ; peut consulter triage et carry-forward
Documentation	Ne pas supposer que le triage = diagnostic

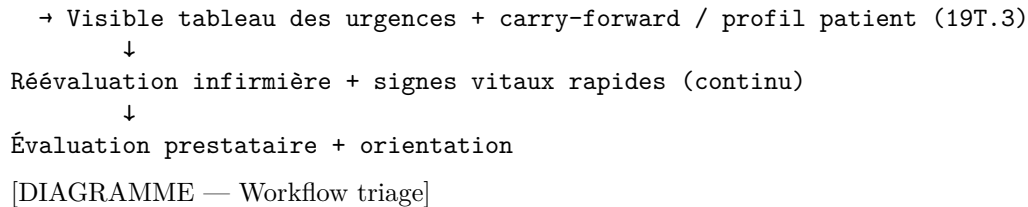
2.5 Superviseur clinique

Aspect	Détail
Responsabilités	Effectifs, saturation salle d'attente, exceptions protocole
Escalade	Boarding, conflit identité, incident sécurité, refus de soins

3. Vue d'ensemble du workflow triage

3.1 Séquence opérationnelle Medora (consultation d'urgence)

Volume 1 : Inscription / identité
↓
Accueil urgences (/app/emergency/triage)
→ Ouverture consultation d'urgence
↓
Dossier actif urgences (/app/emergency/active/{id})
→ Panneau Triage urgences (documentation complète)
↓
Enregistrement triage (PUT triage)



3.2 Étapes détaillées

#	Étape	Bonnes pratiques	Erreurs fréquentes
1	Arrivée patient	Confirmer identité (Volume 1)	Mauvais dossier ouvert
2	Confirmation identité	Nom + DOB + NIR/MRN	Supposer que la fiche est à jour
3	Motif de consultation	Phrase opérationnelle, pas de diagnostic	« Appendicite » au lieu de « douleur abdo »
4	Signes vitaux	Complets selon protocole ; unités cohérentes	Oublier TA ou SpO ₂ en dyspnée
5	ESI	Cohérent avec présentation ; réviser si évolution	ESI bas par défaut sans évaluation
6	Allergies	NKDA explicite ou allergies détaillées	Laisser vide sans « inconnu » documenté
7	Médicaments domicile	Recherche catalogue + lignes structurées	Copier carry-forward sans revue
8	Antécédents PMH/PSH/sociation	Revue carry-forward section par section	Confirmer tout d'un clic sans lire
9	Dépistages	AVC, sepsis si indiqué ; sécurité domicile si protocole	Ignorer champs structurés
10	Réévaluation	Planifier selon ESI et protocole salle d'attente	Aucun suivi après triage initial
11	Assignment / attente	Médecin/infirmier sur tableau si protocole	Patient ESI 1-2 en attente non surveillée
12	Escalade	Si changement → ESI, équipe, superviseur	Attendre le médecin sans alerter

Avertissements opérationnels

- **Une consultation ouverte** par patient — vérifier avant d'en créer une nouvelle.
- **Triage incomplet** peut déclencher rappels advisory — ne pas les ignorer systématiquement.
- **Deux interfaces triage** : panneau ED complet vs onglet signes vitaux consultation générique — former le staff sur la bonne voie.

Déclencheurs d'escalade (indicatifs)

- ESI 1-2 ou équivalent détresse
- Signes vitaux alarmants (selon protocole local)
- Dépistage AVC ou sepsis positif / alerte cochée

- Détérioration en salle d'attente
- Allergie médicamenteuse sévère non documentée auparavant

4. Workflow motif de consultation

4.1 Philosophie de saisie

Le **motif de consultation** décrit **pourquoi** le patient est là **dans ses mots ou les vôtres de manière neutre** — ce n'est **pas** le diagnostic final.

Motif de consultation diagnostic final.

4.2 Concis vs détaillé

Approche	Exemple acceptable	À éviter
Concis	« Douleur thoracique depuis 2 h »	« Infarctus »
Détaillé	« Dyspnée progressive, fièvre 38,5 °C, toux »	« Pneumonie confirmée »

Medora propose des **modèles de motifs** (clic pour préremplir) — le staff **adapte** et **vérifie** ; pas de diagnostic automatique.

4.3 Exemples opérationnels

Présentation	Motif recommandé	Signal d'alerte formation
Douleur thoracique	« Douleur rétrosternale soudaine »	ESI urgent, ECG selon protocole
Douleur abdominale	« Douleur abdo basse droite, nausées »	Réévaluation si aggravation
Dyspnée	« Essoufflement au repos »	SpO ₂ , ESI, surveillance
Faiblesse	« Faiblesse membre gauche depuis 1 h »	Dépistage AVC, LKW
Fièvre	« Fièvre + frissons, toux »	Dépistage sepsis si indiqué
Traumatisme	« Chute, douleur hanche, anticoagulant »	Critères traumatiques selon triage V1

4.4 Reconnaissance des motifs à haut risque

Former le staff à repérer les mots-clés et présentations nécessitant **ESI élevé, dépistage structuré** ou **prise en charge immédiate** — sans que Medora ne classe automatiquement le patient.

5. Workflow ESI

5.1 Rôle opérationnel de l'ESI

L'**Indice ESI** (1–5) est un outil de **priorisation opérationnelle** en salle d'urgence. Dans Medora :

- Saisie **manuelle** par l'infirmier(ère) (liste 1–5) ;

- Affichage sur le **tableau des urgences** avec pastilles **Critique** / **Surveillance** / **Stable** (dérivées de l'ESI) ;
- **Rappels** assistifs pour ESI 1–2 (CDS) — pas de décision automatique.

Ce manuel n'enseigne pas la propriété intellectuelle ni la certification ESI complète — seulement l'**usage opérationnel dans Medora** et les attentes de l'établissement pilote.

5.2 Libellés produit (référence formation)

Niveau	Libellé UI (FR)
1	Réanimation
2	Urgent
3	Urgent modéré
4	Moins urgent
5	Non urgent

5.3 Priorisation et salle d'attente

- ESI **1–2** : protocole local = **soins immédiats** ou surveillance rapprochée — ne pas laisser en attente non surveillée.
- ESI **3–5** : attente possible selon capacité — **réévaluation** selon délais locaux.

5.4 Réévaluation et modification de l'ESI

Comportement actuel Medora :

- Pour **changer l'ESI** : rouvrir le panneau triage et modifier la valeur, puis enregistrer.
- La **réévaluation infirmière** affiche l'ESI de triage en **lecture seule** — documenter l'évolution clinique même si l'ESI n'est pas ressaisi immédiatement.

Exemples de déclencheurs de réévaluation

- Douleur qui augmente en salle d'attente
- Nouvelle fièvre ou hypotension
- Vomissements, syncope, agitation
- Résultats en attente avec détérioration clinique

Exemples d'escalade d'acuité

Situation	Action opérationnelle
Patient ESI 4 → détresse respiratoire	Soins + ESI révisé + alerte équipe
Patient ESI 3 → déficit neurologique new	Dépistage AVC + médecin
Patient stable → syncope en attente	Signes vitaux répétés + réévaluation documentée

6. Allergies et conciliation médicamenteuse

6.1 Vérification des allergies

Workflow Medora (triage ED)

1. Lire la section **allergies** (texte libre + puces NKDA, aliment, latex, etc.).
2. Si **reprise d'antécédents** présente → **revoir** chaque ligne (voir §7).
3. Utiliser la **recherche médicament** pour allergies médicamenteuses structurées (réaction documentée).
4. Si aucune allergie connue → documenter « **Aucune allergie médicamenteuse connue** » (NKDA) explicitement si vérifié.
5. Si patient incertain → documenter **inconnu** / **non vérifié** selon protocole — ne pas laisser vide sans commentaire.

Le staff doit vérifier — ne pas supposer que les données antérieures sont à jour.

Médicaments à haut risque (exemples formation)

Anticoagulants, antiépileptiques, insuline, opioïdes, antibiotiques bêta-lactamines — confirmer allergies avant toute administration ultérieure.

6.2 Conciliation des médicaments domicile

Workflow

1. Demander au patient / aidant la **liste des médicaments actuels** (noms, doses si connues).
2. Saisir via **résumé médicaments domicile** + puces (aucun, inconnu, polymédication).
3. **Recherche catalogue** → modal médicament domicile → ligne formatée ajoutée.
4. Revue **carry-forward** si lignes reprises automatiquement.
5. Enregistrer triage → promotion vers **profil patient longitudinal** (19T.3) si réconciliation confirmée.

Limites produit (honnêteté formation)

Medora capture et synchronise la documentation — **ce n'est pas** un moteur entreprise de conciliation médicamenteuse (MedRec) avec validation pharmacien obligatoire intégrée. Appliquer les exigences locales au-delà du produit.

Scénarios d'incertitude patient

Situation	Action
« Je prends des pilules blanches »	Documenter incertitude ; ne pas inventer de molécule
Aidant absent	Noter source ; réévaluer quand aidant disponible
Conflit avec carry-forward	Modifier ou retirer la ligne reprise ; statut « modifié »

7. Reprise d'antécédents (carry-forward) — 19T.1–19T.3

Section prioritaire formation — comportement Medora documenté honnêtement.

7.1 Principe

Lors d'une **nouvelle consultation d'urgence** sans triage existant, Medora peut **proposer** des antécédents issus de :

1. **Profil longitudinal patient** (`clinicalHistoryProfile`) — priorité; ou
2. **Triage d'une consultation d'urgence antérieure.**

Ces données apparaissent comme **reprise d'antécédents** — **en attente de revue**. Elles **ne sont pas** auto-confirmées comme vérité clinique.

7.2 Sections concernées

Section	Contenu typique
Allergies	Texte allergies reprises
Médicaments domicile	Lignes médicaments
Antécédents (history)	PMH, PSH
Antécédents sociaux	Tabac, alcool, substances

Ne sont pas repris via ce mécanisme : ESI, signes vitaux, dépistages AVC/sepsis de la visite courante, motif — à saisir à chaque visite.

7.3 Statuts de revue

Statut (code)	Signification opérationnelle	Action staff
En attente de revue (<code>pending_review</code>)	Donnée reprise, non validée	Lire, confirmer, modifier ou retirer
Revu / confirmé (<code>reviewed</code>)	Staff a validé l'exactitude	Peut enregistrer triage
Modifié (<code>modified</code>)	Reprise corrigée	Documenter source si besoin
Retiré (<code>removed</code>)	Information reprise jugée non applicable	Ne pas réintroduire sans nouvelle source

7.4 Ancienneté (staleness)

Medora signale si la source est **ancienne** (> 6 mois) ou **très ancienne** (> 12 mois). Traiter comme **indice de prudence** — révéfier avec le patient.

7.5 Actions interface

— **Confirmer tout / Confirmer la section** — après lecture réelle.

- **Effacer la section** — si reprise non fiable.
- Édition manuelle → statut mis à jour automatiquement selon règles produit.

7.6 Réconciliation des écarts

Écart	Conduite
Patient nie une allergie reprise	Retirer ou modifier ; documenter dans le triage
Médicament arrêté depuis la dernière visite	Modifier la liste
Antécédent nouveau non dans le profil	Ajouter manuellement ; sauvegarde promeut le profil (19T.3)
Profil vs triage divergent après save	Lire bannière historique longitudinal ; réconcilier selon protocole

7.7 Pourquoi la revue est critique

- Erreur d'allergie → risque médicamenteux majeur.
- Médicament fantôme → ordonnance inappropriée.
- Antécédent manquant → sous-évaluation du risque.

Ne jamais cliquer « Confirmer tout » sans lecture par section.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Reprise d'antécédents]

8. Workflows de dépistage

8.1 Objectif opérationnel

Les dépistages structurés **aident** à documenter des préoccupations et à **déclencher l'escalade humaine**

- Medora **ne** lance **pas** d'ordres automatiques ni de diagnostic.

8.2 Dépistages disponibles dans le triage ED

Dépistage	Disponibilité Medora	Attentes
AVC (stroke screen)	Oui — formulaire structuré (face, bras, parole, LKW, alerte)	Alerte équipe si positif selon protocole
Sepsis	Oui — critères structurés + commentaires	Escalade si suspicion selon protocole
Sécurité domicile	Partiel — « Se sent en sécurité chez soi » O/N/Inconnu	Escalade sociale selon protocole établissement
Voyage / exposition	Oui — voyage hors pays 14 j	Contexte infectieux
Critère chute majeure (trauma)	Partiel — puce traumatologie	Compléter avec évaluation clinique

8.3 Non disponibles comme écran triage dédié (ne pas documenter comme existants)

Sujet	Statut produit
Dépistage suicide structuré au triage	Non — documentation provider / sortie ailleurs
Dépistage grossesse structuré au triage	Non — motif / procédures séparées
Échelle risque de chute complète au triage	Non — réévaluation infirmière (faible/modéré/élevé)
Instrument complet violence / IPV	Non — au-delà du champ sécurité domicile

Former le staff sur les **protocoles papier ou locaux** pour ces sujets si requis légalement.

8.4 Attentes documentation

- Cocher **alerte** ou commentaire quand le protocole l'exige.
- Ne pas interpréter un dépistage négatif comme « pathologie exclue ».
- Escalade **humaine** documentée (qui a été avisé, quand).

9. Workflow de réévaluation

9.1 Philosophie

La **réévaluation** est la **surveillance clinique continue** : l'état en salle d'attente ou en box peut changer. Medora fournit :

- **Réévaluation infirmière (urgences)** — événements append-only sur dossier actif ;
- **Signes vitaux rapides** — bandeau sur espace actif / chart ;
- **Modification triage / ESI** — via re-saisie triage.

9.2 Réévaluation salle d'attente

ESI	Attente opérationnelle (indicatif — protocole local prime)
1-2	Pas d'attente non surveillée ; réévaluation immédiate si en attente
3	Réévaluation selon délai établissement
4-5	Surveillance périodique ; réévaluation si symptôme change

9.3 Détérioration

1. Soins immédiats selon protocole.
2. Signes vitaux répétés → enregistrer dans Medora.
3. Document **réévaluation infirmière** (symptômes, intervention, notification médecin).
4. Réviser **ESI** dans triage si applicable.
5. Superviseur si ressources insuffisantes.

9.4 Réévaluation douleur

Documenter score / description selon protocole local ; répéter après analgésie si applicable — dans réévaluation infirmière ou notes triage selon workflow local.

9.5 Attentes documentation

Chaque réévaluation significative devrait laisser une trace : **qui, quand, changement observé, actions, qui a été notify**.

[DIAGRAMME — Réévaluation]

10. Mobile et tablette — triage

10.1 Alignement initiative 19M

Le panneau triage ED utilise une mise en page **responsive** (seuil ~960 px : colonne unique vs large). Documenté dans l'audit 19M comme **utilisable** sur tablette ; **priorité moindre** que le tableau des urgences pour optimisation layout.

10.2 Recommandations

Contexte	Appareil
Triage actif prolongé	Tablette paysage 10"
Accueil urgences (recherche patient)	Tablette ou PC
Téléphone	Possible pour tâches courtes — limité pour saisie triage complète

10.3 Workflow chevet / salle

- Signes vitaux rapides adaptés au chevet.
- Carry-forward : bannière utilisable sur viewport étroit (QA 19T.4).
- Éviter saisie longue antécédents sur petit écran si PC disponible.

10.4 Haïti — connectivité

- Bandeau **Hors ligne** : file d'attente possible — **reprise d'antécédents** et recherche catalogue peuvent être limitées.
- Synchroniser dès retour réseau ; revérifier allergies/médicaments après sync.
- Voir runbook downtime (Volume 1 §8.3).

[CAPTURE D'ÉCRAN — Triage Medora]

11. Sécurité opérationnelle

11.1 Mauvais patient

- Confirmer identité **avant** enregistrement triage.
- Vérifier nom sur bandeau dossier actif vs patient devant vous.

11.2 Doublons

- Volume 1 : alertes à la création patient.
- Au triage : si dossier incohérent → **stop** → superviseur.

11.3 Allergies

- Jamais administrer sans vérification ; NKDA = vérification active, pas supposition.

11.4 Échecs de réévaluation

- Si patient ESI élevé non revu dans le délai local → escalade superviseur.
- Utiliser indicateurs tableau (réévaluation due, durée élevée).

11.5 Détérioration salle d'attente

- Protocole local prioritaire ; Medora documente après/so pendant prise en charge.

11.6 Patient agressif / perturbateur

- Sécurité physique d'abord ; documentation quand sûr.

11.7 Barrière linguistique

- Interprète ; documenter langue et source de traduction.

11.8 Panne système

- Triage papier selon runbook ; ressaisie sans antiderater les champs système.

12. Résumé opérationnel rapide — checklists

12.1 Checklist intake triage

- ☐ Identité confirmée (nom, DOB, MRN/NIR)
- ☐ Motif neutre saisi
- ☐ Signes vitaux complets selon protocole
- ☐ ESI assigné et cohérent
- ☐ Dépistages pertinents complétés

- ☐ Triage enregistré

12.2 Checklist conciliation allergies

- ☐ Patient interrogé
- ☐ NKDA ou allergies détaillées
- ☐ Recherche médicament si allergie médicamenteuse
- ☐ Carry-forward allergies revu
- ☐ Statut revue mis à jour

12.3 Checklist revue carry-forward

- ☐ Chaque section lue
- ☐ Confirmé / modifié / retiré par section
- ☐ Ancienneté (> 6 / 12 mois) prise en compte
- ☐ Pas de « confirmer tout » sans lecture

12.4 Checklist réévaluation

- ☐ Délai local respecté pour ESI
- ☐ Signes vitaux répétés si changement
- ☐ Réévaluation infirmière documentée
- ☐ ESI triage mis à jour si protocole
- ☐ Médecin notify si indicatif

12.5 Checklist escalade

- ☐ Détresse → soins + équipe
- ☐ ESI 1-2 → pas d'attente non surveillée
- ☐ Dépistage positif → protocole activé
- ☐ Superviseur si ressources / conflit

12.6 Checklist sécurité salle d'attente

- ☐ Patients ESI 1-3 identifiés visuellement (protocole salle)
- ☐ Réévaluation planifiée
- ☐ Staff sait comment alerter
- ☐ Résultats critiques suivis (tableau)

13. Gouvernance du chapitre

13.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction infirmière urgences	Contenu triage, ESI, réévaluation
Référent terminologie	Alignement canon
Admin Medora / IT	Exactitude routes et RBAC

13.2 Mises à jour

- Toute évolution carry-forward (19T.x) ou panneau triage → révision chapitre.
- Lier aux tests `frenchHandbookTriageClinicalIntake19MBookFr3.test.ts`.

13.3 Révision annuelle

Recommandée avec **leadership triage** : protocoles locaux ESI, dépistages ajoutés, retour terrain Haïti.

13.4 Formation

- Obligatoire pour infirmiers triage ED avant autonomie.
- Exercice carry-forward : « confirmer vs modifier vs retirer ».
- Quiz : motif vs diagnostic ; triage vs évaluation médecin.

Annexes

A. Routes et libellés UI

Route	Libellé
<code>/app/emergency/triage</code>	Accueil urgences
Panneau triage	Triage urgences
<code>/app/emergency/active/{id}</code>	Dossier actif urgences
Réévaluation	Réévaluation infirmière (urgences)

B. Références

- Volume 1 — Accueil
- Canon terminologique
- `docs/clinical/longitudinal-history-production-validation-19T4.md`
- `docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md`
- `docs/ui/cross-device-qa-checklist-19M8.md`

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Triage Medora]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Reprise d'antécédents]
- [DIAGRAMME — Workflow triage]
- [DIAGRAMME — Réévaluation]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Tableau des urgences]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Dépistage AVC / sepsis]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Réévaluation infirmière]

Fin du Volume 2 — M-BOOK.FR.3

Volume 3 — Workflow prestataire et documentation clinique

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.4

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Médecins, IPS, résidents, superviseurs cliniques, formateurs

Prérequis : Volume 1 — Accueil · Volume 2 — Triage

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	3 — Workflow prestataire et documentation clinique
Routes principales	/app/provider, /app/emergency/active/{id}, /app/emergency/chart/{id}, /app/encounters/{id}
Composant documentation	Espace documentation prestataire (<code>ProviderDocumentationWorkspace</code>)
Architecture liée	Intelligence motif 19MDM · Responsive documentation 19M.5
Révision recommandée	Annuelle ou après évolution MDM / intelligence motif

1. Introduction au workflow prestataire

1.1 Rôle du prestataire dans Medora

Le **prestataire clinique** (médecin, IPS selon cadre local) est responsable de :

- L'**évaluation** clinique du patient ;
- La **synthèse** (HPI, ROS, examen, aide à la décision médicale — MDM) ;
- Les **ordres** et la revue des résultats (hors scope détaillé de ce volume — voir modules ordres/résultats) ;
- La **décision d'orientation** (sortie, observation, admission, transfert) ;
- La **communication** avec le patient / aidant et l'équipe.

1.2 Relation avec le triage

Triage (Volume 2)	Prestataire (ce volume)
ESI, signes vitaux, allergies, dépistages	HPI approfondi, examen, MDM
Reprise d'antécédents infirmière	Revue critique + diagnostic différentiel
Priorisation initiale	Plan thérapeutique et orientation

Le prestataire **s'appuie** sur le triage — il ne **remplace** pas la réévaluation infirmière ni ne suppose que le triage est complet ou exact.

1.3 Philosophie de documentation

La documentation Medora doit refléter :

- Le **raisonnement** du prestataire ;

- L'évolution clinique et les réévaluations ;
- Le risque spécifique au patient ;
- Les échanges avec patient, famille et consultants ;
- L'incertitude lorsqu'elle existe — sans langage de certitude artificielle.

La documentation sert la continuité des soins et la clarté opérationnelle — pas uniquement la facturation.

Medora propose des modèles, pastilles et intelligence motif pour accélérer la saisie. Le prestataire édite, complète ou supprime tout contenu inséré.

1.4 Objectifs opérationnels et sécurité patient

Objectif	Moyen Medora
Continuité	Dossier partagé, brouillon local, enregistrement serveur
Clarté équipe	Tableau des urgences, assignation, orientation enregistrée
Sécurité	Revue identité, carry-forward, pas de diagnostic auto
Traçabilité	Signature documentation prestataire (attestation) selon workflow

1.5 Responsabilité clinique

Medora-S assiste le workflow et la documentation. Il ne remplace pas le jugement clinique du prestataire.

Aucun modèle, pastille MDM ou bundle intelligence motif ne constitue un diagnostic, un ordre ou une orientation obligatoire.

2. Vue d'ensemble du workflow prestataire

2.1 Séquence opérationnelle (urgences)

```

Tableau des urgences - consultation assignée
↓
Ouverture dossier actif (/app/emergency/active/{id})
↓
Revue triage + antécédents + résultats en attente
↓
Évaluation initiale + documentation (HPI, ROS, examen, MDM)
↓
Ordres / revue données (module ordres)
↓
Réévaluations + mise à jour documentation
↓
Décision d'orientation (onglet Disposition) + texte dossier
↓
Signature / clôture selon protocole établissement

```

[DIAGRAMME — Workflow prestataire]

2.2 File prestataire vs documentation

Surface	Route	Usage
File médecin	<code>/app/provider</code>	Liste consultations ouvertes — pas la saisie documentation complète
Dossier actif urgences	<code>/app/emergency/active/{id}</code>	Documentation prestataire (onglet évaluation / MSE)
Chart urgences	<code>/app/emergency/chart/{id}</code>	Même espace documentation
Consultation observation	<code>/app/encounters/{id}</code>	Documentation mode observation

2.3 Détail par étape

#	Étape	Objectif	Bonnes pratiques	Erreurs fréquentes
1	Assignation	Responsabilité claire	S'assigner sur tableau si protocole	Évaluer patient non assigné sans coordination
2	Revue triage	Contexte acuité	Lire ESI, vitaux, allergies, dépistages	Ignorer carry-forward non revu par infirmier
3	Motif	Comprendre plainte	Motif diagnostic	Copier motif comme diagnostic
4	Historique longitudinal	Antécédents fiables	Revérifier allergies/médicaments	Supposer profil patient à jour
5	Évaluation initiale	Examen + synthèse	Documenter évolution depuis triage	Documentation générique non patient-spécifique
6	Ordres / résultats	Plan diagnostique/thérapeutique	Revue résultats dans MDM	Orientation avant résultats critiques revus
7	Réévaluation	Surveillance risque	Mettre à jour note si changement	Note initiale jamais actualisée
8	Complétude documentation	Dossier défendable	Checklist interne qualité	Pastilles insérées sans relecture
9	Orientation	Décision enregistrée	Onglet Disposition + cohérence texte	Texte sortie contradictoire avec orientation
10	Signature / clôture	Attestation	Signer après relecture	Signer dossier incomplet

Escalade

- Détérioration clinique → soins + réévaluation infirmière + superviseur
- Résultat critique → protocole local + documentation
- Conflit identité → stop documentation → superviseur

3. Workflow documentation clinique

3.1 HPI (histoire de la maladie)

- Décrire **chronologie**, **symptômes associés**, **facteurs aggravants/soulageants**, **traitements déjà reçus**.
- Utiliser modèles de motif actif si pertinent — **personnaliser**.
- Intelligence motif : pastilles HPI **optionnelles** (clic pour insérer).

3.2 ROS (revue des systèmes)

- Ciblée selon plainte — positifs **et** négatifs pertinents.
- Pastilles ROS importantes / signaux d'alerte via intelligence motif si utile.

3.3 Examen physique

- Sections par aire (général, cardio, abdomen, neuro, etc.).
- Pastilles examen du **modèle actif** + intelligence motif (ex. neuro, MSK).
- Réévaluation : section **examen de réévaluation** si évolution documentée.

3.4 MDM (aide à la décision médicale)

- Champs : évaluation de travail, données revues, raisonnement clinique, synthèse différentielle, plan, admission/observation/sortie.
- Voir §4 pour workflow détaillé.

3.5 Réévaluation (documentation prestataire)

- Documenter **intervalle**, **changement**, **réponse au traitement**, **résultats revus**.
- Distinct de la **réévaluation infirmière** (Volume 2) — les deux sont complémentaires.

3.6 Consultations évoquées

- Champ **Consultations évoquées** (mdmConsultsDiscussed) — texte libre.
- Pastilles intelligence motif peuvent suggérer « revoir si consultant indiqué » — **pas** de module bon de consulté intégré.

3.7 Justifications orientation / observation / admission

- **Texte dossier** : champs MDM admission/observation/sortie + pastilles.
- **Décision opérationnelle** : onglet **Disposition (urgences)** — enregistrer l'**orientation** (sortie, admission/observation, transfert, etc.).
- Les deux couches doivent être **cohérentes**; Medora **ne les fusionne pas** automatiquement.

3.8 Communication patient / famille

Documenter ce qui a été expliqué : plan, risques, consignes de retour, suivi — dans instructions de sortie et MDM, pas seulement dans pastilles génériques.

4. Workflow MDM

Section prioritaire formation prestataire.

4.1 Philosophie MDM dans Medora

L'aide à la décision médicale (MDM) documente la **complexité** et le **raisonnement** de la visite. Medora fournit :

- **Modèle actif** (ex. douleur thoracique, dyspnée) avec pastilles MDM suggérées ;
- **Menu MDM** multi-sélection avec prompts à **valeur élevée** et fragments du modèle ;
- **Intelligence motif** (bundles par plainte) — insertion par section.

Tout est **optionnel**, **modifiable** et **supprimable** (puces retirables).

4.2 Menu MDM multi-sélection

Comportement opérationnel

1. Ouvrir le **menu modèles MDM** sur le champ cible (ex. raisonnement clinique).
2. **Cocher** une ou plusieurs pastilles (multi-sélection).
3. **Appliquer** — fragments ajoutés au texte (séparés par ; si plusieurs).
4. **Éditer** le texte librement après insertion.
5. **Retirer** une puce pour enlever le fragment associé.

Le menu **reste ouvert** pour sélections multiples successives (comportement multi-select).

Prompts à valeur élevée (fixes)

Exemples de catégories : MDM standard, préoccupation patient, revue études diagnostiques, sevrage tabagique, PMP revu — insérés dans champs MDM appropriés. **Relire** — ne pas insérer si non pertinent.

4.3 Modèle actif vs intelligence motif

Source	Quand visible	Auto-insertion
Modèle actif (template picker)	Après choix modèle visite	Pastilles champs modèle au changement de modèle — pas intelligence motif
Intelligence motif	Pastilles par section HPI/ROS/MDM/etc.	Jamais — clic uniquement

4.4 Champs MDM typiques

Champ	Contenu attendu
Évaluation de travail	Impression clinique de travail
Données revues	Labs, imagerie, ECG, consultants — ce qui a été revu
Raisonnement clinique	Pourquoi ce plan
Synthèse différentielle	Diagnostics considérés — sans certitude inappropriée
Plan / actions	Traitement, réévaluation, consultation
Admission / observation / sortie	Justification orientation textuelle

4.5 Responsabilité finale

Le prestataire reste responsable de tout le contenu final enregistré et signé.

Medora n'attribue pas automatiquement un niveau de facturation E/M; la documentation doit soutenir le raisonnement clinique réel.

5. Workflow intelligence motif (19MDM)

5.1 Principes

L'intelligence motif fournit des **bundles de prompts** par type de plainte :

- **Insertion au clic uniquement** — jamais d'application automatique selon diagnostic ou motif saisi.
- **Aucun ordre, aucune ordonnance, aucune orientation** automatique.
- **Aucun diagnostic** imposé.

Chaque bundle peut inclure : HPI, ROS (+/-), signaux d'alerte, examen ciblé, différentiel/MDM, revue données, réévaluation, suivi/sortie.

5.2 Organisation en sous-groupes (picker)

Sous-groupe (FR)	Clé	Exemples de templates
Gastro-intestinal / abdominal	gi_abdominal	Douleur abdominale, nausées/vomissements, saignement GI...
Respiratoire / ORL	respiratory_text	Toux, dyspnée, asthme, pneumonie...
Cardiaque / vasculaire	cardiac_vascular	Douleur thoracique, palpitations, OAP...
GU / rénal	gu_renal	Dysurie, douleur flank, rétention...
MSK / traumatique	msk_trauma	Entorse, douleur dos, traumatisme...
Infectieux / ORL	infectious_ear	Fièvre, cellulite, mal de gorge infectieux...
Endocrinien / métabolique	endocrine_metabolic	Hypertension, hyperglycémie, hypoglycémie, thyroïde...
Neurologie avancée	neurology_expansion	Changement de conscience, vertige, faiblesse focale...

Des templates **legacy** (ex. `stroke_symptoms`, `headache`, `chest_pain`) existent en dehors des sous-groupes `*_complaint_v1` — même règles d'insertion manuelle.

5.3 Utilisation opérationnelle

1. Choisir le **modèle de visite** correspondant à la plainte (picker avec sous-groupes).

2. Dans chaque section (HPI, ROS, MDM...), cliquer les pastilles **intelligence motif** utiles.
3. **Personnaliser** le texte — prompts formulés « à documenter si pertinent », « évaluer », « revoir si... ».
4. **Retirer** les puces non applicables.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Intelligence motif]

5.4 Limitations et gouvernance (sécurité)

Ce que l'intelligence motif ne fait pas

- Ne **exclut** pas une pathologie (« exclu », « éliminé »).
- Ne déclare pas d'examens **normaux** ou **négatifs** (CT, MRI, labs, ECG « normal »).
- Ne certifie pas **sortie sûre, aptitude à conduire, patient stable**.
- N'**oblige** pas admission ou sortie.

Gouvernance produit (19MDM)

Règles de phrases interdites dans le **contenu des bundles** — contrôlées en **tests** de non-régression (CI). Le prestataire doit **éviter** d'ajouter manuellement ce langage après insertion.

Exemples de formulations **interdites** dans la documentation clinique (liste indicative formation) :

- « AVC exclu », « IDM exclu », « pneumonie exclue »
- « Scanner négatif », « bilan normal »
- « Sortie sans risque », « médicalement autorisé à conduire »
- « Doit être admis », « doit sortir »

Revue prestataire obligatoire

Traiter chaque pastille comme **aide-mémoire**, pas comme texte final. **Relire** avant enregistrement et **signature**.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Templates MDM]

6. Réévaluation et évolution clinique

6.1 Philosophie

La **réévaluation** est une **évaluation continue du risque** — pas un unique paragraphe en fin de visite.

6.2 Workflow répété

Déclencheur	Action documentation
Nouveaux symptômes	MAJ HPI + examen réévaluation
Résultat disponible	MDM « données revues » + plan

Déclencheur	Action documentation
Réponse traitement	Réévaluation douleur / symptômes
Séjour ED prolongé	Documenter intervalle et décision retard

6.3 Détérioration

1. Soins immédiats (protocole).
2. Coordination infirmière (réévaluation infirmière).
3. MAJ ESI via triage si délégué.
4. Documentation prestataire : évolution + plan + orientation si changée.

6.4 Séjour prolongé aux urgences

Documenter : raison attente, résultats en attente, réévaluations intervalle, discussion patient — pastilles **observation** / **réévaluation** ou modèle `observation_reassessment` si pertinent.

6.5 Mode observation

Sur `/app/encounters/{id}` en **observation et court séjour** : documentation prestataire avec titres/chips `observation` ; compléter orientation via disposition et protocole observation local (Volume 1 §11).

7. Consultations, observation et admission

7.1 Documentation consult

- **Consultations évoquées** : qui, quand, recommandations — texte libre.
- Pastilles : « revoir si consultation neurologie/cardio indiquée » — insérer puis **préciser** si consult réellement obtenu.

Limite produit : pas de suivi statut consult intégré (accepté/en attente) dans l'espace documentation.

7.2 Justification observation

Documenter : pourquoi surveillance prolongée, résultats en attente, réponse traitement incertaine, risque de décompensation.

7.3 Justification admission

Documenter : incapacité sortie sûre selon évaluation, besoin IV/oxygène/monitoring, social si pertinent au plan.

Décision : onglet Disposition → **Admission** / **observation (court séjour)** + dossier d'admission structuré.

7.4 Transfert

Motif transfert, acception, stabilité pour transport — disposition **Transfert** + texte MDM.

7.5 Incertitude clinique

Il est **acceptable** de documenter l'incertitude : « diagnostic en évolution », « réévaluation après résultats » — **éviter** fausse certitude.

8. Orientation et documentation de sortie

8.1 Deux niveaux (rappel)

Niveau	Où	Rôle
Narratif	Champs MDM + suivi/sortie + intelligence motif	Raisonnement, consignes textuelles
Opérationnel	Onglet Disposition (urgences)	Orientation enregistrée (domicile, observation, transfert, LAMA, etc.)

Libellé bouton : **Enregistrer la décision d'orientation.**

8.2 Workflow sortie

1. Réévaluation finale documentée.
2. Instructions compréhensibles (langue, littératie).
3. **Consignes de retour** / signes d'alarme.
4. Suivi planifié.
5. Enregistrer orientation **sortie à domicile** (ou autre) dans Disposition.
6. Exécution infirmière sortie (Volume 2 / équipe) — distinct de la décision médicale.

8.3 Planification partagée

Documenter ce que patient/aidant **a compris** — questions répondues. Pastilles « planification partagée » si modèle le prévoit.

8.4 Philosophie (sans détail gouvernance interne)

Les **modèles de sortie** et garde-fous produit existent pour encourager consignes sécuritaires — le prestataire **adapte** au cas. Ne pas exposer ici les règles d'implémentation internes ; suivre formation établissement sur modèles sortie approuvés.

La documentation de sortie doit refléter

- Réévaluation finale
- Compréhension patient
- Attentes de suivi

- Consignes de retour
- **Incertitude non résolue** si applicable

9. Historique longitudinal et carry-forward

9.1 Revue prestataire

Avant de prescrire ou d'orienter :

- **Allergies** — confirmer avec patient ; ne pas se fier au profil seul.
- **Médicaments domicile** — conciliation si changement depuis triage.
- **Antécédents** — compléter si nouvelle information.

9.2 Reprise d'antécédents (Volume 2)

Si infirmier n'a pas finalisé revue carry-forward, le prestataire doit **traiter** les sections en attente ou **documenter** la discordance.

9.3 Profil longitudinal (19T.3)

Après triage sauvegardé, le profil patient peut être **promu**. Écarts profil vs récit → **réconcilier** dans la note ou mettre à jour via workflow patient.

9.4 Risque données anciennes

Signaler mentalement l'**ancienneté** (> 6 / 12 mois) — revérifier allergies et médicaments actifs.

10. Mobile et tablette — prestataire

10.1 Initiative 19M.5 (documentation)

Largeur	Comportement
< 1024 px	Colonne unique, résumé repliable
1024–1279 px	Tablette 2 colonnes (aside étroit)
1280 px	Bureau 2 colonnes (aside sticky)

Cibles tactiles 44 px en mode empilé.

10.2 Recommandations

Usage	Appareil
Documentation prolongée complexe Chevet, réévaluation rapide, insertion pastilles	Bureau ou tablette grande paysage Tablette acceptable
Téléphone	Consultation courte — limité pour MDM long

10.3 Haïti — connectivité

- Brouillon **local** si réseau instable — resynchroniser et **relire** avant signature.
- Ne pas signer si statut « en attente synchronisation » sans confirmer enregistrement serveur.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Documentation prestataire]

11. Sécurité opérationnelle prestataire

Risque	Mesure
Mauvais patient	Vérifier bandeau identité à l'ouverture dossier
Abus carry-forward	Confirmer allergies/médicaments indépendamment
Surconfiance modèles	Personnaliser tout texte inséré
Copier-coller	Interdit entre patients ; pastilles autre dossier
Résultats en attente	Documenter attente ; ne pas orienter avant revue si protocole l'exige
Réévaluation omise	MAJ note si changement clinique
Orientation prématurée	Cohérence texte onglet Disposition
Barrière linguistique	Interprète ; documenter
Panne	Reporter signature ; saisie reprise selon runbook
Mobile	Relecture obligatoire sur petit écran

12. Résumé opérationnel rapide — checklists

12.1 Checklist intake prestataire

- ☐ Bon patient / bonne consultation
- ☐ Triage et vitaux revus
- ☐ Allergies / médicaments vérifiés
- ☐ Motif et HPI initiaux
- ☐ Résultats en attente identifiés

12.2 Checklist MDM

- ☐ Données revues documentées (ce qui a été **vu**, pas « tout normal »)
- ☐ Différentiel raisonnable
- ☐ Plan et réévaluation
- ☐ Pastilles relues et personnalisées
- ☐ Cohérence avec orientation

12.3 Checklist réévaluation

- ☐ Changement clinique documenté
- ☐ Nouveaux résultats intégrés
- ☐ Plan mis à jour si besoin

12.4 Checklist sortie

- ☐ Réévaluation finale
- ☐ Instructions + consignes retour
- ☐ Suivi
- ☐ Orientation enregistrée (Disposition)
- ☐ Compréhension patient documentée

12.5 Checklist observation / admission

- ☐ Justification clinique texte
- ☐ Dossier d'admission / niveau de soins si applicable
- ☐ Orientation **Admission** / **observation** enregistrée

12.6 Checklist sécurité intelligence motif

- ☐ Insertion **manuelle** uniquement
- ☐ Pas de langage « exclu / normal / sortie sûre »
- ☐ Texte édité pour le patient
- ☐ Pucés non pertinentes retirées

12.7 Checklist anti mauvais patient

- ☐ Identité bandeau = patient présent
 - ☐ MRN/NIR cohérent
 - ☐ Re-vérification avant signature
-

13. Gouvernance du chapitre

13.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction médicale urgences	Contenu clinique, MDM, orientation
Référent terminologie	Canon
Équipe produit Medora	Exactitude comportement UI (sans exposer implémentation interne aux cliniciens)

13.2 Revue leadership prestataire

Recommandée **annuellement** avec : lead MD ED, nursing lead, admin documentation, référent 19MDM.

13.3 Formation déploiement Haïti

- Atelier pratique : modèle + MDM multi-select + 1 bundle intelligence motif.
- Exercice : repérer langage interdit dans un brouillon.
- Lien Volume 1–2 pour continuité accueil → triage → médecin.

13.4 Mises à jour

Nouveau sous-groupe intelligence motif ou changement Disposition → révision chapitre + tests `frenchHandbookProviderWorkflow19MBookFr4.test.ts`.

Annexes

A. Enregistrement et brouillon (aperçu)

- **Enregistrement** : sauvegarde serveur (PATCH encounter metadata).
- **Autosauvegarde** : délai ~2 s après modification si contenu et droits OK.
- **Brouillon local** : restauration si plus récent — **relire** avant signature.
- **Signature** : attestation prestataire — protocole établissement.

B. Références

- Volume 1 · Volume 2
- Canon terminologique
- `docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md`
- Architecture intelligence motif : batches 19MDM.2–19MDM.9 (documentation interne)

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Documentation prestataire]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Templates MDM]

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Intelligence motif]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Réévaluation]
 - [DIAGRAMME — Workflow prestataire]
 - [DIAGRAMME — Admission / observation / congé]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Onglet Disposition (urgences)]
-

Fin du Volume 3 — M-BOOK.FR.4

Volume 4 — Workflow infirmier et exécution de sortie

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.5

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Infirmier(ère) aux urgences, infirmier(ère) de triage, IDE, superviseurs infirmiers, formateurs

Prérequis : Volume 1 — Accueil · Volume 2 — Triage · Volume 3 — Prestataire

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	4 — Workflow infirmier et exécution de sortie
Routes principales	/app/nursing, /app/emergency/active/{id}, /app/emergency/chart/{id}, /app/emergency/trackboard, /app/encounters/{id}
Composants clés	Réévaluation infirmière (EmergencyNursingReassessmentPanel), MAR (MedicationAdministrationTab), exécution sortie (NursingDischargeExecutionSection)
Architecture liée	Carry-forward 19T.1–19T.3 · Responsive disposition / sortie 19M.6
Révision recommandée	Annuelle ou après évolution sortie / MAR / réévaluation

1. Introduction au workflow infirmier

1.1 Rôle infirmier dans Medora

L'infirmier(ère) clinique aux urgences est responsable de :

- La **surveillance continue** et la **réévaluation** du patient ;
- La **documentation infirmière** structurée (soins, ABC, réponse au traitement, sécurité au chevet) ;
- La **coordination** avec le prestataire, le laboratoire, l'imagerie et la pharmacie selon protocole ;
- Le **suivi des ordres** actifs et la **documentation des administrations** de médicament (MAR) ;
- L'**exécution de sortie** lorsque le prestataire a enregistré l'orientation — distincte de la décision médicale ;
- L'**éducation patient** et la vérification de la compréhension avant départ.

1.2 Relation avec triage et documentation prestataire

Volume / rôle	Contribution
Volume 2 — Triage	ESI, signes vitaux initiaux, allergies, dépistages, carry-forward infirmier
Volume 3 — Prestataire	HPI, examen, MDM, ordres, décision d'orientation (onglet Disposition)
Volume 4 — Infirmier (ce volume)	Réévaluation, MAR, suivi ordres/résultats, exécution sortie , enseignement

L'infirmier **s'appuie** sur le triage et la documentation prestataire — il ne **remplace** pas l'évaluation médicale ni ne modifie la décision d'orientation du prestataire.

1.3 Responsabilité documentaire infirmière

La documentation infirmière Medora doit refléter :

- L'**état actuel** du patient et son **évolution** ;
- Les **interventions** réalisées et la **réponse au traitement** ;
- Les **signaux d'alerte** identifiés et les **escalades** effectuées ;
- La **continuité** entre réévaluations (append-only, horodatées).

1.4 Réévaluation continue

La réévaluation infirmière est une **surveillance clinique continue du risque patient** — pas un formulaire unique en fin de séjour. Medora permet plusieurs séances de réévaluation sur le même dossier.

1.5 Suivi médicament et ordres

L'infirmier est responsable de **connaître les ordres actifs**, d'**administrer et documenter** selon protocole établissement, et de **signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement** tout changement clinique ou résultat critique — sans interpréter les résultats au-delà de son champ de pratique et des politiques locales.

1.6 Exécution de sortie

L'infirmier **n'établit pas** la décision clinique de sortie du prestataire. Il **vérifie, enseigne, documente et exécute** le processus opérationnel de sortie une fois l'orientation enregistrée.

1.7 Responsabilité clinique et politique institutionnelle

Medora-S soutient le workflow infirmier et la documentation. Il ne remplace pas le jugement clinique infirmier ni les politiques institutionnelles (MAR, protocoles médicament, protocoles de sortie).

Medora n'est **pas** un registre légal de médicament (MAR papier ou système institutionnel) ; il **documente** les administrations dans le dossier consultation selon les droits et workflows produit.

2. Vue d'ensemble du workflow infirmier

2.1 Séquence opérationnelle (urgences)

Volume 2 : Triage enregistré → visible tableau des urgences
↓
Patient reçu / assigné (box, salle d'attente, voie rapide)
↓
Évaluation infirmière initiale + documentation soins
↓
Suivi ordres actifs + administrations médicament (MAR)
↓
Réévaluations continues + signes vitaux
↓
Éducation patient + préparation sortie / admission / transfert
↓

Vérification orientation prestataire (Disposition)
 ↓
 Exécution sortie infirmière OU handoff admission/transfert
 ↓
 Documentation infirmière finale
 [DIAGRAMME — Workflow infirmier]

2.2 Surfaces Medora

Surface	Route	Usage infirmier
File soins infirmiers	/app/nursing	Liste consultations ouvertes — médicaments en attente, accès rapide dossier
Tableau des urgences	/app/emergency/trackboard	Vue opérationnelle, assignation, priorités
Dossier actif urgences	/app/emergency/active/flight	Orbits : soins infirmiers, MAR, ordres, résultats, disposition
Chart urgences	/app/emergency/chart/meds	Médicaments contenu — navigation chart
Consultation observation	/app/encounters/{id}	Soins infirmiers, MAR, sortie observation

[CAPTURE D'ÉCRAN — Workflow infirmier]

2.3 Détail par étape

#	Étape	Objectif	Bonnes pratiques	Erreurs fréquentes	Escalade	Documentation
1	Réception depuis triage / tableau	Continuité sécuritaire	Lire ESI, vitaux, allergies, motif	Ignorer carry-forward non revu	ESI 1-2 non pris en charge → superviseur	Reprendre contexte triage
2	Affectation / rooming	Localisation claire	Box ou zone cohérente avec acuité	Patient haute acuité en attente non surveillée	Saturation salle d'attente → charge infirmière	Mettre à jour si protocole local
3	Évaluation infirmière initiale	Baseline soins	ABC, douleur, sécurité chevet	Documentation générique	Détresse → équipe + prestataire	Grille documentation infirmière
4	Conscience ordres actifs	Plan thérapeutique connu	Revue onglet Ordres / MAR	Ordre oublié en attente	Résultat critique → prestataire selon protocole	Noter interventions prévues
5	Administration médicament	Action sécuritaire documenté	Vérifier patient, allergie, ordre	Mauvais patient / mauvais médicament	Réaction → protocole urgence + documentation	MAR — heure, voie, refus si applicable

#	Étape	Objectif	Bonnes pratiques	Erreurs fréquentes	Escalade	Documentation
6	Réévaluation	Surveillance continue	Vitaux, douleur, réponse traitement	Aucune réévaluation après changement	Détérioration → prestataire immédiat	Nouvelle séance réévaluation horodatée
7	Éducation patient	Compréhension sécuritaire	Enseignement ciblé, langage adapté	Sortie sans revue consignes	Non-compréhension → prestataire / interprète	Cases enseignement exécution sortie
8	Vérification pré-sortie	Prêt opérationnel	Orientation prestataire enregistrée	Sortie sans Disposition	Orientation absente → prestataire	Lire décision en lecture seule
9	Exécution sortie	Départ tracé	Identité, destination, heure, état	Sortie avant décision médicale	Refus soins / LAMA → protocole	Exécution sortie infirmière (section dédiée)
10	Documentation finale	Complétude dossier	Note de clôture infirmière si protocole	Dossier incomplet avant clôture	—	Handoff si admission/transfert

3. Documentation infirmière aux urgences

3.1 Panneau réévaluation infirmière

Sur le dossier actif urgences, l'onglet **Soins infirmiers** héberge le panneau de **réévaluation infirmière** structurée :

- Grille multi-domaines (ABC, soins/surveillance, réponse au traitement, tendance, interventions, sécurité chevet) ;
- **Nouvelle séance** horodatée — documentation append-only ;
- Signes vitaux rapides liés au triage / dossier ;
- Champs sécurité triage ED (`ErTriageV1NursingCareSafetyFieldsBlock`) si applicable.

3.2 Brouillon local (aperçu)

Medora peut conserver un **brouillon local** de réévaluation infirmière (session navigateur) en cas de rafraîchissement accidentel. **Relire et enregistrer** sur le serveur avant de considérer la documentation définitive — surtout si connectivité instable (Haïti).

3.3 Distinction triage vs soins infirmiers

Triage (Volume 2)	Soins infirmiers (ce volume)
Évaluation initiale structurée, ESI	Réévaluations ultérieures, évolution
Allergies / médicaments domicile documentés	Vérification continue, administrations
Dépistages structurés initiaux	Surveillance continue, réponse traitement

Ne pas confondre **triage enregistré une fois** avec **suivi infirmier continu**.

4. Workflow réévaluation

4.1 Philosophie

La réévaluation infirmière est une évaluation continue du risque patient.

Elle vise à détecter précocement la détérioration, documenter la réponse au traitement et alimenter le prestataire avec des observations factuelles.

4.2 Réévaluation douleur

- Révérer l'échelle de douleur selon protocole local ;
- Documenter avant/après analgésie si administrée ;
- Escalade si douleur non contrôlée malgré protocole — **signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement.**

4.3 Signes vitaux répétés

- Utiliser saisie rapide vitaux sur dossier actif ;
- Comparer avec triage et réévaluations antérieures ;
- Documenter tendance (amélioration, stable, détérioration) dans la grille infirmière.

4.4 Détérioration clinique

Signal	Action opérationnelle
ABC compromis	Équipe + prestataire immédiat ; documentation contemporaine
Vitaux hors cible protocole	Réévaluation ; notification selon seuils locaux
Changement neurologique	Escalade urgente ; ne pas retarder pour documentation

4.5 Réévaluation salle d'attente

Patients en attente restent sous **responsabilité infirmière** selon protocole :

- Délais de réévaluation selon ESI et politique salle d'attente ;
- Mise à jour ESI via **réouverture triage** (Volume 2) si protocole le permet ;
- Documentation réévaluation si changement d'état.

4.6 Réponse au traitement

Documenter objectivement : douleur, symptômes, tolérance IV/oxygène, effets indésirables observés — faits, pas diagnostic médical.

4.7 Séjour prolongé aux urgences

Pour séjour > seuil local :

- Réévaluations planifiées ;
- Revue ordres en attente et résultats non lus ;
- Communication avec prestataire si stagnation ou boarding.

4.8 Notification prestataire

Medora **ne remplace pas** l'appel verbal ou le protocole d'alerte local. Documenter ce qui a été **signalé au prestataire selon le protocole de l'établissement** lorsque pertinent.

4.9 Mode observation

Sur `/app/encounters/{id}` (observation / court séjour), les mêmes principes de réévaluation s'appliquent avec documentation adaptée au contexte hospitalier de courte durée.

5. Suivi des ordres et résultats

5.1 Conscience des ordres actifs

- Consulter l'onglet **Ordres** sur le dossier actif ;
- Identifier : en attente, en cours, complétés, résultats disponibles ;
- La **file infirmière** (`/app/nursing`) peut afficher le volume de médicaments en attente par consultation.

5.2 Coordination labo / imagerie / pharmacie

Type	Rôle infirmier (opérationnel)
Laboratoire	Prélèvement si protocole ; suivi statut ; pas d'interprétation médicale
Imagerie	Accompagnement patient ; suivi statut
Pharmacie	Coordination délivrance si workflow local ; administration documentée au MAR

5.3 Ordres en attente

- Vérifier régulièrement les ordres non exécutés ;
- Documenter retard si impact clinique (ex. analgésie en attente) ;
- Escalade selon protocole — **signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement**.

5.4 Ordres complétés et résultats

- Résultats disponibles : s'assurer que le prestataire en a **connaissance** selon protocole ;
- Accusé de réception résultat (si droits RN) : action produit — ne remplace pas notification clinique locale ;
- **Ne pas interpréter** les résultats au-delà du scope infirmier et des politiques de l'établissement.

5.5 Changements critiques

Tout résultat ou changement clinique critique → **signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement** (appel, alerte, page) **en plus** de toute documentation Medora.

5.6 Attentes documentaires

Documenter : prélèvements effectués, administrations, réévaluations post-traitement, escalades — faits observables et actions infirmières.

6. Administration de médicament

6.1 Conscience des ordres médicament

- Onglet **MAR** (administration de médicament) sur dossier actif urgences, chart ou consultation observation ;
- Liste des lignes médicament en attente d'administration ;
- Alertes sécurité (allergies, médicaments à haut risque) — **lire et accuser** selon workflow produit ; ne remplace pas vérification infirmière indépendante.

6.2 Documentation d'administration

Pour chaque administration :

- Confirmer **bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment** (protocole local + Medora) ;
- Enregistrer heure effective ; ajuster avec justification si protocole et produit le permettent ;
- Documenter site injection IM si requis par le produit.

6.3 Refus patient

- Documenter le refus sans forcer l'administration ;
- **Signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement** si impact sur le plan thérapeutique.

6.4 Médicament retenu (held)

- Documenter la raison (NPO, procédure, indisponibilité, ordre prestataire) ;
- Révérifier avant administration ultérieure.

6.5 Réaction / événement indésirable

- Protocole urgence institutionnel en premier ;
- Documentation contemporaine dans le dossier ;
- Notification prestataire / pharmacie selon protocole.

6.6 Réévaluation après médicament

- Surtout analgésie, sédation, vasopresseurs, insuline : réévaluer douleur, vitaux, niveau de conscience selon protocole ;
- Documenter réponse dans réévaluation infirmière.

6.7 Analgésie et réévaluation douleur

Après opioïde ou analgésie majeure : réévaluation douleur et surveillance respiratoire selon protocole — documenter.

6.8 Médicaments à haut risque

Medora peut afficher des avertissements pour médicaments à haut risque. L'infirmier **reste responsable** de la vérification indépendante selon politique MAR institutionnelle.

Medora documente les administrations ; il ne remplace pas le MAR légal ni les politiques médicament de l'établissement.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Administration médicament]

7. Exécution de sortie infirmière

7.1 Distinction fondamentale

Niveau	Responsable	Contenu Medora
Documentation de sortie prestataire	Prestataire clinique	MDM, instructions, consignes, onglet Disposition (urgences) — décision d'orientation
Exécution de sortie infirmière	Infirmier(ère)	Vérification, enseignement, destination, heure, état — sans créer la décision médicale

L'infirmier ne crée pas la décision clinique de sortie du prestataire ; il confirme et exécute le processus opérationnel de sortie.

Le prestataire enregistre l'**orientation** (sortie à domicile, observation, admission, transfert, LAMA, etc.) dans l'onglet Disposition. L'infirmier **lit** cette décision et **exécute** la sortie infirmière.

7.2 Workflow exécution sortie (sortie à domicile)

1. **Vérifier** que le prestataire a enregistré l'orientation de sortie (Disposition) ;
2. **Vérifier l'identité** du patient (bandeau, nom, DOB) ;
3. **Revoir** les instructions de sortie prestataire (dossier partagé) ;
4. **Revoir** médicaments / ordonnances si applicables ;
5. **Revoir** suivi et **consignes de retour** ;
6. **Enseigner** et documenter les points revus (cases enseignement) ;
7. **Documenter** la compréhension patient / famille (ou interprète) ;
8. **Documenter** l'état du patient à la sortie ;
9. **Documenter** destination / transport ;
10. **Enregistrer** heure de sortie ;
11. **Compléter** l'exécution sortie infirmière (enregistrement unique — relecture après sauvegarde).

Section produit : **Exécution sortie infirmière** (NursingDischargeExecutionSection) — persistée dans l'évaluation infirmière du dossier.

7.3 Champs typiques exécution sortie

Champ	Objectif
Destination	Domicile, famille, transfert, etc.
Heure de sortie	Traçabilité opérationnelle
Enseignement revu	Cases : médicaments, suivi, consignes retour, plaie, etc.
État à la sortie	Stable, amélioré, ambulatoire, fauteuil, etc.
Note infirmière	Contexte, barrière linguistique, transport

7.4 Handoff infirmier (panneau complémentaire)

Le panneau **handoff infirmier urgences** (EmergencyErNursingHandoffPanel) soutient la suite opérationnelle : lecture dossier partagé, synthèse, impression sortie — **après** décision médicale.

7.5 Erreurs critiques à éviter

Erreur	Risque
Exécution sortie sans orientation prestataire	Sortie non médicalement autorisée dans le dossier
Mauvais patient	Événement sentinelle
Enseignement non documenté	Responsabilité continuité soins
Instructions non comprises	Retour précoce, non-observance

[CAPTURE D'ÉCRAN — Exécution de sortie] [DIAGRAMME — Workflow sortie infirmière]

8. Éducation patient et enseignement

8.1 Médicaments

- Expliquer nom, dose, fréquence, effets secondaires à surveiller ;
- Vérifier compréhension (répétition, teach-back si protocole) ;
- Cocher **Instructions médicaments / Ordonnance** dans exécution sortie.

8.2 Suivi

- Date, lieu, raison du prochain rendez-vous ;
- Cocher **Suivi revu** ; documenter si incertitude.

8.3 Consignes de retour

- Reprendre les consignes prestataire ; **ne pas inventer** de critères de retour ;
- Cocher **Consignes de retour** ; adapter langage au patient.

8.4 Soins de plaie / appareils

Si applicable : cocher **Soins de plaie, Utilisation équipement, Restrictions d'activité**.

8.5 Communication famille / aidant

- Impliquer aidant si autorisation ;
- Cocher **Famille a verbalisé la compréhension** si pertinent.

8.6 Barrière linguistique

- Interprète qualifié si disponible ;
- Cocher **Interprète utilisé** ;
- Documenter dans note infirmière.

8.7 Refus ou non-compréhension

- Ne pas autoriser le départ silencieux si enseignement critique incompris ;
 - **Signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement** ;
 - Documenter refus ou limitation de l'enseignement.
-

9. Admission, transfert et observation — workflow infirmier

9.1 Préparation admission

- Vérifier décision prestataire : Disposition **Admission** / **observation** + dossier admission si applicable ;
- Belongings, identité, allergies, médicaments ;
- Handoff verbal à unité receveuse selon protocole.

9.2 Préparation transfert

- Stabilisation selon protocole transport ;
- Documentation résumé infirmier ;
- Ordres et résultats en attente communiqués.

9.3 Responsabilités infirmières en observation

Sur consultation observation (/app/encounters/{id}) :

- Réévaluation selon protocole unité ;
- MAR et ordres ;
- Notes sortie observation infirmières (puces rapides si disponibles) ;
- Coordination avec prestataire pour clôture.

9.4 Handoff

Documenter : état actuel, interventions, résultats en attente, préoccupations sécurité, éducation déjà faite.

9.5 Effets personnels et documentation

- Vérifier effets personnels restitués ou accompagnés ;
- Copies instructions / ordonnances remises si protocole.

9.6 Transport

- Documenter mode de transport (ambulatoire, fauteuil, brancard, ambulance) ;
- Attente transport prolongée → réévaluation continue.

[DIAGRAMME — Admission / transfert / observation infirmière]

10. Historique longitudinal et carry-forward

10.1 Revue infirmière du carry-forward

Aligné **19T.1–19T.3** (Volume 2) :

- Allergies et médicaments repris du profil patient : **revérifier** avec le patient ;
- Statuts carry-forward : en attente de revue, revu, modifié, retiré — ne pas supposer « revu » sans lecture.

10.2 Médicaments domicile

- Confirmer liste actuelle ; signaler discordance au prestataire ;
- Risque : médicament arrêté ou nouveau non documenté.

10.3 Données anciennes (stale)

- Antécédents datés ou contradictoires → mise à jour ou note de discordance ;
- **Ne pas se fier au profil seul** — confirmation au chevet.

10.4 Profil longitudinal (19T.3)

Le profil patient aide le workflow ; l’infirmier **revérifie** au contact patient, surtout allergies et médicaments à risque.

10.5 Discordances infirmier / prestataire

Documenter et communiquer (verbal + note) : allergie oubliée, médicament non déclaré, antécédent corrigé.

11. Mobile et tablette — infirmier

11.1 Initiative responsive (19M)

Medora améliore progressivement l’usage tablette / mobile. Surfaces **relativement adaptées** au chevet :

- Réévaluation infirmière (empilement < 960 px) ;
- Exécution sortie infirmière (19M.6 — champs empilés, cibles tactiles) ;
- Disposition / sortie (lecture décision prestataire).

Surfaces **limitées** sur téléphone :

- Tableau des urgences dense ;
- MAR complexe (multiples colonnes) ;
- Documentation prolongée multi-sections.

11.2 Recommandations

Usage	Appareil
Chevet, réévaluation, vitaux rapides, exécution sortie	Tablette acceptable
Revue rapide file infirmière	Téléphone — consultation courte
Documentation longue, MAR multiples, handoff complexe	Poste fixe / bureau préféré

11.3 Haïti — connectivité

- Enregistrer réévaluation et exécution sortie **sur serveur** dès connexion stable ;
 - Brouillon local réévaluation : **relire** après reconnexion ;
 - Ne pas considérer sortie complète si enregistrement serveur échoué — retry ou protocole papier de secours institutionnel.
-

12. Sécurité opérationnelle infirmière

Risque	Mesure
Mauvais patient — documentation	Bandeau identité à chaque ouverture dossier ; re-vérification avant MAR et sortie
Risque administration médicament	Cinq bonnes vérifications ; allergies ; haut risque
Ordres en attente cachés	Revue régulière onglet Ordres / file infirmière
Réévaluation manquée	Planifier selon ESI ; documenter changements
Enseignement sortie omis	Checklist exécution sortie obligatoire opérationnellement
Sortie sans disposition prestataire	Interdit — obtenir orientation enregistrée d’abord
Barrière linguistique	Interprète ; ne pas deviner le consentement
Panne / downtime	Protocole papier institutionnel ; resaisie quand système disponible
Patient agressif / perturbateur	Sécurité équipe ; documentation factuelle ; escalade
Risque chute / mobilité	Aide au transfert ; chaises ; documentation sécurité chevet
Surconfiance carry-forward	Revérifier allergies et médicaments au chevet
Interprétation résultats hors scope	Signaler au prestataire selon protocole — ne pas diagnostiquer

13. Résumé opérationnel rapide — checklists

13.1 Checklist intake infirmier

- ☐ Bon patient / bonne consultation
- ☐ Triage et ESI revus
- ☐ Allergies / médicaments vérifiés (carry-forward revu)
- ☐ ABC initial documenté
- ☐ Ordres actifs identifiés

13.2 Checklist réévaluation

- ☐ Vitaux / douleur selon protocole
- ☐ Tendance documentée
- ☐ Réponse au traitement
- ☐ Escalade si détérioration
- ☐ Nouvelle séance enregistrée

13.3 Checklist administration médicament

- ☐ Bon patient
- ☐ Ordre actif vérifié

- ☐ Allergies revues
- ☐ Administration documentée (heure, voie)
- ☐ Réévaluation post-médicament si requis

13.4 Checklist suivi ordres

- ☐ Ordres en attente revus
- ☐ Prélèvements / imagerie coordonnés
- ☐ Résultats : prestataire informé selon protocole
- ☐ Pas d'interprétation hors scope

13.5 Checklist exécution sortie

- ☐ Orientation prestataire enregistrée (Disposition)
- ☐ Identité patient confirmée
- ☐ Instructions prestataire revues
- ☐ Médicaments / ordonnances revus
- ☐ Suivi et consignes de retour enseignés
- ☐ Compréhension documentée
- ☐ État et destination à la sortie
- ☐ Heure sortie enregistrée
- ☐ Exécution sortie infirmière complétée

13.6 Checklist enseignement patient

- ☐ Médicaments expliqués
- ☐ Suivi expliqué
- ☐ Consignes de retour repassées
- ☐ Aidant impliqué si applicable
- ☐ Interprète si barrière linguistique
- ☐ Instructions écrites remises si protocole

13.7 Checklist handoff admission / transfert

- ☐ Décision prestataire confirmée

- ☐ État actuel résumé
- ☐ Résultats en attente communiqués
- ☐ Effets personnels
- ☐ Transport organisé

13.8 Checklist anti mauvais patient

- ☐ Bandeau = patient présent
- ☐ MRN / NIR cohérent
- ☐ Re-vérification avant MAR
- ☐ Re-vérification avant exécution sortie

14. Gouvernance du chapitre

14.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction infirmière urgences	Contenu workflow infirmier, exécution sortie, enseignement
Référent terminologie	Canon
Équipe produit Medora	Exactitude surfaces UI (sans exposer implémentation interne aux cliniciens)

14.2 Revue leadership infirmier

Recommandée **annuellement** avec : lead infirmier ED, direction médicale, admin documentation, référent sortie.

14.3 Lien gouvernance terminologique

Termes officiels : **Exécution sortie**, **Administration de médicament**, **Réévaluation**, **Signaler au prestataire selon le protocole de l'établissement** — voir canon.

14.4 Formation déploiement Haïti

- Atelier : réévaluation → MAR → exécution sortie sur dossier test ;
- Exercice : distinguer décision prestataire vs exécution infirmière ;
- Lien Volumes 1–3 pour continuité accueil → triage → prestataire → infirmier.

14.5 Mises à jour

Changement MAR, exécution sortie ou carry-forward → révision chapitre + tests **frenchHandbookNursingDischargeExecuti**

14.6 Révision annuelle

Vérifier alignement routes, checklists, et initiative 19M responsive.

Annexes

A. Enregistrement (aperçu)

- **Réévaluation infirmière** : PATCH consultation (`nursingAssessment`) — séances append-only ;
- **MAR** : enregistrement administration par ligne ordre ;
- **Exécution sortie** : enregistrement unique dans évaluation infirmière — relecture après sauvegarde ;
- **Brouillon local réévaluation** : session navigateur — ne remplace pas enregistrement serveur.

B. Références

- Volume 1 · Volume 2 · Volume 3
- Canon terminologique
- `docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md`
- Carry-forward : architecture 19T.1–19T.3

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Workflow infirmier]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Réévaluation infirmière]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Administration médicament]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Exécution de sortie]
 - [DIAGRAMME — Workflow sortie infirmière]
 - [DIAGRAMME — Admission / transfert / observation infirmière]
-

Fin du Volume 4 — M-BOOK.FR.5

Volume 5 — Pharmacie, laboratoire et imagerie

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.6

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Pharmacien, technicien de laboratoire, technicien en imagerie, superviseurs auxiliaires, formateurs

Prérequis : Volume 1 · Volume 2 · Volume 3 · Volume 4

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	5 — Pharmacie, laboratoire et imagerie
Routes principales	/app/pharmacy-worklist, /app/lab-worklist, /app/rad-worklist, /app/pharmacy (hub inventaire)
Détail commande	/app/pharmacy-worklist/commande/{orderId}, /app/lab-worklist/commande/{orderId}, /app/rad-worklist/commande/{orderId}
Rôles cibles	PHARMACY, LAB, RADIOLOGY, ADMIN
Architecture liée	Files auxiliaires MedoraCard · Responsive 19M.7 · Synchronisation en attente (connectivité)
Révision recommandée	Annuelle ou après évolution files / résultats

1. Introduction aux workflows auxiliaires

1.1 Rôle des services auxiliaires dans Medora

Les **services auxiliaires** (pharmacie, laboratoire, imagerie) assurent dans Medora :

- La **visibilité opérationnelle** des ordres prescrits par le prestataire ;
- Le **suivi de statut** (accusé de réception, en cours, complété, résultat disponible) ;
- La **coordination** avec infirmier(ère) et prestataire pour exécution et résultats ;
- La **documentation** des actes auxiliaires dans le périmètre produit (dispensation enregistrée, saisie résultat).

1.2 Relation avec prestataire et infirmier

Rôle	Contribution
Prestataire (Volume 3)	Prescription / demande, interprétation clinique, décision thérapeutique
Infirmier (Volume 4)	Prélèvement, transport, administration, signalement résultats selon protocole
Auxiliaire (ce volume)	File de travail, exécution départementale, saisie résultat, dispensation documentée

1.3 Coordination opérationnelle

Medora relie ordres et résultats au **dossier consultation** — les auxiliaires voient les identifiants patient **limités** sur les files (nom, MRN/NIR, date de naissance, sexe selon rôle) pour protéger la confidentialité tout

en permettant l'identification sécuritaire.

1.4 Cycle ordre / résultat (aperçu)

Prestataire signe l'ordre

↓

Visible sur file département (pharmacie / labo / imagerie)

↓

Accusé de réception → En cours → Complété

↓

(Labo / imagerie) Résultat saisi → Accusé de lecture clinique (RN / prestataire selon droits)

↓

(Pharmacie) Dispensation enregistrée → Administration infirmière (MAR, Volume 4)

1.5 Objectifs sécurité patient

Objectif	Moyen Medora
Traçabilité	Statuts ordre, horodatages, audit des actions file
Identification	Identifiants limités + confirmation au détail commande
Visibilité	Files avec priorité, parcours (ED vs soins urgents), badges opérationnels
Escalade	Communication selon politique établissement — pas de décision clinique auto

1.6 Attentes de communication

Les auxiliaires **communiquent** avec infirmier et prestataire selon protocole local (verbal, téléphone, page) — Medora **documente** le statut ; il ne remplace pas les canaux d'urgence institutionnels.

1.7 Responsabilité et politiques institutionnelles

Medora-S soutient la coordination opérationnelle. Il ne remplace pas les politiques institutionnelles, la pharmacie clinique, les normes de laboratoire ni la gouvernance radiologique de l'établissement.

Medora n'est **pas** un système pharmacie hospitalier complet (ERP stock national, robot dispense, contrôle substances, etc.). Le périmètre actuel couvre : **files de travail, workflow statut ordre, enregistrement dispensation, saisie résultats, inventaire pharmacie de base** — selon modules déployés.

2. Workflow pharmacie — vue d'ensemble

2.1 Périmètre opérationnel honnête

Inclus (MVP Medora)	Hors périmètre / limité
File pharmacie (/app/pharmacy-worklist)	ERP pharmacie entreprise
Accusé / démarrage / complétion ligne ordre	Robotisation dispense
Enregistrement dispensation par ligne	Politique pharmacie institutionnelle complète
Hub inventaire (/app/pharmacy) — stock, alertes	Intégration grossiste / NDC national
Impression ordonnance (Rx) si workflow local	Substitution automatique médicament

File canonique : préférer `/app/pharmacy-worklist` (cartes MedoraCard, responsive 19M.7) plutôt que le hub legacy pour la gestion de file.

2.2 Séquence opérationnelle

Ordre médicament signé (prestataire)
↓
Apparition file pharmacie (+ lignes synchronisation en attente si réseau instable)
↓
Revue file : priorité, parcours ED/UC, médicament à haut risque
↓
Accusé de réception → Démarrage → Complétion (workflow statut)
↓
Détail commande → Enregistrer dispensation
↓
Infirmier administre (MAR, Volume 4) - distinct de la dispensation pharmacie
[DIAGRAMME — Workflow pharmacie]

2.3 File pharmacie — concepts

Concept	Description
File de travail	Liste ordonnée des lignes médicament en attente d'action pharmacie
Priorité	Urgent / routine — badge visuel sur carte
Parcours	Urgences vs soins urgents vs ambulatoire (pathway)
Statut ligne	Accusé, en cours, complété, annulé
Dispensé	Ligne avec enregistrement dispensation — relecture avant doublon
Synchronisation en attente	Ordre créé localement, pas encore confirmé serveur — traiter avec prudence

2.4 Priorisation file

1. Priorité **urgente** et patients haute acuité (ESI bas si visible) ;
2. Médicaments à **haut risque** (alerte produit) ;
3. Ordres anciens non traités (retard) ;
4. Routine.

2.5 ED vs soins urgents (UC)

Contexte	Considération opérationnelle
Urgences	Délais courts ; coordination infirmier box ; disponibilité stock ED
Soins urgents	Parcours ambulatoire ; patient peut attendre en salle ; ordonnance sortie possible

2.6 Disponibilité médicament

- Vérifier inventaire hub si module actif ;

- Documenter indisponibilité et **communiquer** avec prestataire / infirmier selon protocole ;
- Ne pas marquer complété sans dispensation réelle ou décision documentée.

2.7 Workflow synchronisation en attente

Lorsque la connectivité est faible (Haïti) :

- Les cartes **synchronisation en attente** signalent des ordres non encore confirmés serveur ;
- **Attendre confirmation** ou vérifier avec prescripteur avant dispensation définitive ;
- Ne pas supposer qu'un ordre pending sync est valide cliniquement.

2.8 Communication pharmacie équipe soignante

Situation	Action
Médicament indisponible	Informé prestataire / infirmier
Dose / voie ambiguë	Clarification avant dispense
Allergie signalée produit	Ne pas dispenser ; escalade
Doublon suspect	Revue ordres actifs

2.9 Escalade

- Médicament contrôlé / haut risque sans protocole local clair ;
- Discordance identité patient ;
- Ordre annulé encore visible — vérifier statut avant action.

[CAPTURE D'ÉCRAN — File pharmacie]

3. Workflow laboratoire — vue d'ensemble

3.1 Séquence opérationnelle

```

Ordre labo signé
    ↓
Visible file laboratoire (/app/lab-worklist)
    ↓
Coordination prélèvement (infirmier / labo selon protocole)
    ↓
Accusé de réception → En cours → Complété
    ↓
Saisie résultat (détail commande)
    ↓
Marquage critique si applicable (labo) + notification selon politique établissement
    ↓
Accusé de lecture clinique (prestataire / infirmier selon droits)

```

[DIAGRAMME — Workflow laboratoire]

3.2 File laboratoire — concepts

Concept	Description
File de travail	Lignes analyses en attente
Barre résumé	Compteurs opérationnels (en attente, en cours, résultats non lus)
Filtres / tri	Priorité, retard, statut — outils barre opérationnelle
Badges opérationnels	Retard, résultat disponible non accusé, etc.
Synchronisation en attente	Résultat ou ordre local non synchronisé

3.3 Coordination prélèvement

- L’infirmier ou le technicien prélève selon protocole ;
- **Étiquetage échantillon** : identité patient — risque sentinelle si erreur ;
- Medora documente l’ordre — l’étiquette physique reste responsabilité terrain.

3.4 États opérationnels

Voir section 5 (cycle de vie). Sur la file : statut lisible en français via libellés produit.

3.5 Workflow résultat

1. Ouvrir **Voir le détail** → page commande ;
2. Saisir résultat (texte / données structurées selon type) ;
3. Indiquer valeur **critique** si protocole labo et produit le permettent ;
4. Enregistrer — résultat visible dossier consultation ;
5. **Notification clinique** selon politique établissement (verbal / protocole critique).

3.6 Délais (turnaround)

- Surveiller badges **retard** sur file ;
- Escalade opérationnelle si délai impacte soins urgents — communication infirmier / prestataire.

3.7 Analyses répétées / additionnelles

- Nouvel ordre prestataire = nouvelle ligne file ;
- Ne pas modifier un résultat finalisé sans protocole correction institutionnelle.

3.8 Attentes documentaires

- Statuts ordre à jour ;
- Résultat saisi complet ;
- Critique signalé + trace communication si protocole l’exige.

4. Workflow imagerie — vue d'ensemble

4.1 Séquence opérationnelle

Ordre imagerie signé
↓
Visible file imagerie (/app/rad-worklist)
↓
Coordination examen (transport patient, priorité ED)
↓
Accusé de réception → En cours → Complété
↓
Saisie compte-rendu / résultat
↓
Disponibilité résultat dossier → accusé lecture clinique

[DIAGRAMME — Workflow imagerie]

4.2 File imagerie — concepts

Même architecture que laboratoire : cartes MedoraCard, filtres, badges opérationnels, résumé file, responsive 19M.7.

4.3 Priorisation et débit urgences

Facteur	Priorité
Statut urgent / ESI bas	Examen rapide
Suspicion pathologie aiguë (clinique)	Coordination verbal prestataire
Patient instable	Stabilisation avant transport si protocole

4.4 Coordination transport

- Infirmier / brancardiers selon site ;
- Documenter retards prolongés — communication prestataire si impact plan thérapeutique.

4.5 Imagerie en attente vs complétée

- **En attente** : patient pas encore examiné ou examen non démarré ;
- **En cours** : examen réalisé partiellement ou en lecture ;
- **Complété / résultat** : compte-rendu disponible ou saisi.

4.6 Escalade imagerie haute acuité

- Retard prolongé sur CT / US urgent ;
- Résultat préliminaire oral si protocole radiologie ;

- Toujours **selon la politique de l'établissement** — Medora ne page pas automatiquement le prestataire.

[CAPTURE D'ÉCRAN — File imagerie]

5. Cycle de vie ordre / résultat

5.1 Concepts opérationnels Medora

Statut (concept)	Signification opérationnelle
Brouillon	Ordre créé, non signé — invisible auxiliaires
Signé	Prescription active — apparaît sur files
Accusé de réception	Département a pris connaissance
En cours	Travail démarré (prélèvement, examen, préparation)
Complété	Acte auxiliaire terminé côté département
Résultat disponible	Labo / imagerie : résultat saisi
Accusé de lecture	Clinicien a accusé réception du résultat
Annulé	Ordre annulé — ne pas exécuter
Synchronisation en attente	Donnée locale non confirmée serveur
Ordre répété	Nouvelle ligne — traiter indépendamment

5.2 Rôle des auxiliaires

Les auxiliaires **coordonnent la visibilité et l'exécution** :

- Mettre à jour statuts honnêtement ;
- Saisir résultats complets ;
- Enregistrer dispensation ;
- Signaler retards et discordances.

5.3 Interprétation clinique — limitation explicite

L'interprétation clinique et la décision thérapeutique finale restent des responsabilités du prestataire clinique, selon la politique de l'établissement.

Les techniciens et pharmaciens **ne substituent pas** le jugement médical dans Medora — ils exécutent et documentent dans leur scope professionnel et institutionnel.

5.4 Coordination inter-départements

Lien	Coordination
Pharmacie → Infirmier	Médicament prêt / indisponible
Labo → Infirmier	Prélèvement, résultat disponible
Imagerie → Infirmier	Transport, examen terminé
Tous → Prestataire	Résultat critique, retard majeur, question ordre

[CAPTURE D'ÉCRAN — Ordres en attente]

6. Résultats critiques et sensibilisation à l'escalade

6.1 Sensibilisation (pas de politique institutionnelle)

Ce chapitre **ne définit pas** la politique de résultats critiques de l'établissement. Il rappelle les attentes opérationnelles Medora :

- Le labo peut marquer une valeur **critique** (produit) ;
- L'imagerie documente résultats significatifs via saisie standard ;
- **Notification urgente** au prestataire : **selon la politique de l'établissement** (appel, double lecture, protocole oral).

6.2 Communication urgente

Étape	Attente
Identification	Confirmer bon patient, bon résultat
Notification	Contact prestataire / infirmier selon protocole — ne pas se limiter à la saisie Medora
Documentation	Trace dans dossier + note communication si protocole
Suivi	Vérifier accusé de lecture clinique

6.3 Résultat retardé

- Badge retard sur file labo / imagerie ;
- Escalade si impact soins — communication prestataire et infirmier ;
- Documenter cause opérationnelle (volume, panne analyseur, transport).

6.4 Panne / downtime

- Protocole papier ou téléphone institutionnel ;
- Resaisie Medora quand système disponible ;
- Vérifier doublons à la reconnexion.

6.5 Attentes documentaires

- Résultat saisi ;
- Flag critique si applicable ;
- Communication critique tracée **selon protocole local** (hors détail implémentation Medora).

7. Sécurité dispensation et résultats

7.1 Pharmacie

Risque	Mesure
Dispensation mauvais patient	Vérifier nom, MRN/NIR, DOB au détail commande
Discordance médicament	Comparer ordre, étiquette, dispense enregistrée
Allergie	Alertes produit — vérification indépendante
Médicament haut risque	Double vérification selon protocole pharmacie
Ordres en attente cachés	Revue file complète ; pending sync
Doublon ordre	Rechercher lignes similaires actives avant dispense

7.2 Laboratoire

Risque	Mesure
Échantillon mauvais patient	Deux identifiants minimum à l'étiquetage
Résultat retardé	Badges retard ; communication clinique
Doublon analyse	Revue ordres actifs
Étiquetage	Protocole local — Medora ne remplace pas l'étiquette tube

7.3 Imagerie

Risque	Mesure
Examen mauvais patient	Confirmation identité avant examen
Doublon imaging	Revue ordres récents
Retard transport	Suivi patient ED ; réévaluation infirmière
Imagerie en attente	File + communication si boarding prolongé

8. Mobile et tablette — workflows auxiliaires

8.1 Initiative 19M.7 (files auxiliaires)

Largeur	Comportement files
< 768 px	Cartes empilées, cibles tactiles 44 px
768–1023 px	Grille 2 colonnes labo / imagerie ; pharmacie cartes
1024 px	Disposition dense bureau

Files labo et imagerie : barre filtres empilée mobile ; actions **Voir le détail** accessibles au toucher.

8.2 Recommandations appareil

Usage	Appareil
Revue file, accusé, démarrage rapide	Tablette acceptable
Revue file urgente au téléphone	Téléphone — consultation courte
Saisie résultat longue, dispense détaillée, inventaire	Bureau préféré
Coordination prolongée multi-commandes	Poste fixe

Tablette acceptable pour revue de file ; bureau préféré pour coordination opérationnelle prolongée.

8.3 Haïti — connectivité

- Files auto-rafraîchies (~10 s) — vérifier statut après reconnexion ;
 - Lignes **synchronisation en attente** : ne pas clôturer sans confirmation ;
 - En panne : protocole auxiliaire papier puis resaisie.
-

9. Communication opérationnelle

9.1 Avec le prestataire

- Question ordre ambigu, médicament indisponible, résultat critique, retard majeur ;
- Medora montre statut — **l'appel verbal reste souvent requis** pour l'urgence.

9.2 Avec l'infirmier

- Médicament prêt à administrer ;
- Prélèvement nécessaire ;
- Transport imagerie ;
- Résultat disponible impactant soins immédiats.

9.3 Handoff et relève

- Relève de quart : revue file, pending sync, résultats non accusés ;
- Brief oral : patients ED haute priorité, retards critiques.

9.4 Résultats en attente côté clinique

- Auxiliaire saisit résultat → infirmier / prestataire **accusent lecture** selon droits ;
- Badge résultat non accusé sur tableau urgences (visibilité clinique) — auxiliaire peut rappeler selon protocole.

9.5 Observation / admission

- Ordres actifs suivent le patient en observation ;
- Coordination avec Volume 4 pour continuité MAR et prélèvements.

Focus : **communication workflow**, pas architecture messagerie interne cachée.

10. Résumé opérationnel rapide — checklists

10.1 Checklist file pharmacie

- ☐ File canonique `/app/pharmacy-worklist` ouverte
- ☐ Priorité et parcours revus
- ☐ Pending sync identifié
- ☐ Haut risque / allergie vérifiés
- ☐ Statuts mis à jour
- ☐ Dispensation enregistrée avant « complété » si protocole

10.2 Checklist workflow laboratoire

- ☐ Bon patient / bon ordre
- ☐ Accusé de réception
- ☐ Prélèvement étiqueté selon protocole
- ☐ Statut en cours honnête
- ☐ Résultat saisi complet
- ☐ Critique signalé + notification selon politique établissement

10.3 Checklist workflow imagerie

- ☐ Priorité ED revue
- ☐ Transport coordonné
- ☐ Identité confirmée avant examen
- ☐ Statuts à jour
- ☐ Compte-rendu saisi
- ☐ Retard escaladé si nécessaire

10.4 Checklist résultats en attente

- ☐ Résultats saisis non laissés en brouillon
- ☐ Accusé lecture clinique suivi
- ☐ Pending sync résolu
- ☐ Doublons vérifiés

10.5 Checklist escalade résultat critique

- ☐ Bon patient / bon résultat
- ☐ Flag critique si produit labo
- ☐ Prestataire / infirmier contacté **selon la politique de l'établissement**
- ☐ Communication documentée si protocole
- ☐ Accusé de lecture obtenu

10.6 Checklist anti mauvais patient

- ☐ Nom + identifiant cohérents
- ☐ DOB vérifiée au détail
- ☐ Re-vérification avant dispense / prélèvement / examen

10.7 Checklist auxiliaire — downtime

- ☐ Protocole papier activé
 - ☐ Communication verbale trace
 - ☐ Resaisie sans doublon à reconnexion
 - ☐ Pending sync revu
-

11. Gouvernance du chapitre

11.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction pharmacie	Contenu dispensation, sécurité médicament
Direction laboratoire / imagerie	Workflow résultats, escalade
Référent terminologie	Canon — File pharmacie, Liste laboratoire / imagerie
Équipe produit Medora	Exactitude routes et statuts UI

11.2 Revue leadership auxiliaire

Recommandée **annuellement** : pharmacien chef, chef labo, chef imagerie, direction médicale, admin exploitation.

11.3 Lien terminologie

Harmonisation progressive : **File** pour queues opérationnelles (cf. M-BOOK.FR.1). Clés : `nav.pharmacyQueue`, `nav.labWorklist`, `nav.radWorklist`.

11.4 Formation déploiement Haïti

- Atelier : parcourir les 3 files sur dossier test ;
- Exercice pending sync + reconnexion ;
- Rappel : Medora ERP pharmacie complet ; protocoles locaux prime.

11.5 Adaptation Haïti

- Connectivité intermittente : pending sync, rafraîchissement file, protocole papier ;
- Effectifs réduits : priorisation file, communication verbal explicite ;
- Stock limité : hub inventaire + communication indisponibilité.

11.6 Révision annuelle

Mettre à jour si changement statuts ordre, 19M.7, ou périmètre dispensation.

Annexes

A. Actions file (aperçu)

- `POST /orders/items/:id/acknowledge` — Accusé de réception
- `POST /orders/items/:id/start` — Démarrage
- `POST /orders/items/:id/complete` — Complétion
- Pharmacie dispense : enregistrement via détail commande
- Labo / imagerie résultat : saisie via détail commande

B. RBAC (aperçu)

Rôle	Accès typique
PHARMACY	File pharmacie, hub pharmacie
LAB	File laboratoire
RADIOLOGY	File imagerie
ADMIN	Toutes files

Identifiants patient **limités** sur files pour rôles auxiliaires.

C. Références

- Volumes 1–4
- `docs/ui/cross-device-qa-checklist-19M8.md` (19M.7)
- `docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md`
- Inventaire workflows

D. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — File pharmacie]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — File laboratoire]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — File imagerie]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Ordres en attente]
- [DIAGRAMME — Workflow pharmacie]
- [DIAGRAMME — Workflow laboratoire]
- [DIAGRAMME — Workflow imagerie]

Fin du Volume 5 — M-BOOK.FR.6

Volume 6 — Orientation, admission, transfert et dévoilement de dossier

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.7

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Prestataires, infirmiers, administrateurs, dossiers médicaux, formateurs

Prérequis : Volumes 1–5 (accueil → auxiliaires)

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	6 — Orientation, admission, transfert et dévoilement de dossier
Routes principales	Dossier actif urgences (onglet Disposition), <code>/app/encounters/{id}</code> , <code>/app/hospitalisation</code> , <code>/app/admin/roi</code>
Composants clés	Panneau Disposition (<code>EmergencyDispositionPanel</code>), exécution sortie infirmière, dossier admission, ROI admin
Architecture liée	Responsive disposition 19M.6 · Export dossier (Phase 5F) · ROI (Phase 5G)
Révision recommandée	Annuelle ou après évolution disposition / ROI / observation

Distinction terminologique canonique

Terme	Signification Medora
Orientation	Décision clinique d'issue — domicile, observation, admission, transfert, LAMA, LWBS, etc.
Disposition	Workflow opérationnel / panneau dossier — zone où l'orientation est enregistrée, instructions, planification partagée, clôture

Orientation = décision clinique. **Disposition** = panneau et workflow opérationnel associés.

Ne pas utiliser « disposition » seul lorsque l'on parle de la **décision médicale** — préférer **orientation**.

1. Introduction au workflow disposition

1.1 Objectif opérationnel

Les workflows **orientation** / **disposition** Medora permettent de :

- Documenter la **décision d'issue** du patient (orientation) ;

- Coordonner **sortie, observation, admission** ou **transfert** ;
- Assurer **continuité des soins**, communication et traçabilité ;
- Lier documentation prestataire, exécution infirmière et clôture consultation.

1.2 Rôles

Rôle	Responsabilité
Prestataire	Réévaluation, orientation clinique, documentation MDM / instructions, enregistrement panneau Disposition
Infirmier(ère)	Réévaluation, exécution sortie, handoff admission/transfert, enseignement patient
Administration / dossiers	ROI (dévoilement dossier), export figé, surveillance conformité
Accueil	Départ patient, rendez-vous, orientation logistique selon protocole local

1.3 Réévaluation avant orientation

Aucune orientation ne devrait être enregistrée sans **réévaluation clinique** proportionnée à l'acuité — documentée par prestataire et/ou infirmier (Volumes 3–4).

1.4 Continuité des soins

L'orientation doit être **cohérente** avec :

- Le texte du dossier (MDM, consignes) ;
- Les résultats disponibles ou explicitement en attente ;
- La compréhension patient / aidant ;
- Le handoff vers observation, admission ou établissement receveur.

1.5 Attentes documentation / communication

Documenter : raisonnement, incertitude résiduelle, suivi, consignes de retour, planification partagée. Communiquer verbalement selon protocole pour cas critiques, refus, transfert instable.

1.6 Responsabilité et politiques institutionnelles

Medora-S soutient le workflow et la documentation. Il ne remplace pas le jugement du prestataire, la politique d'admission institutionnelle ni la politique de transfert de l'établissement.

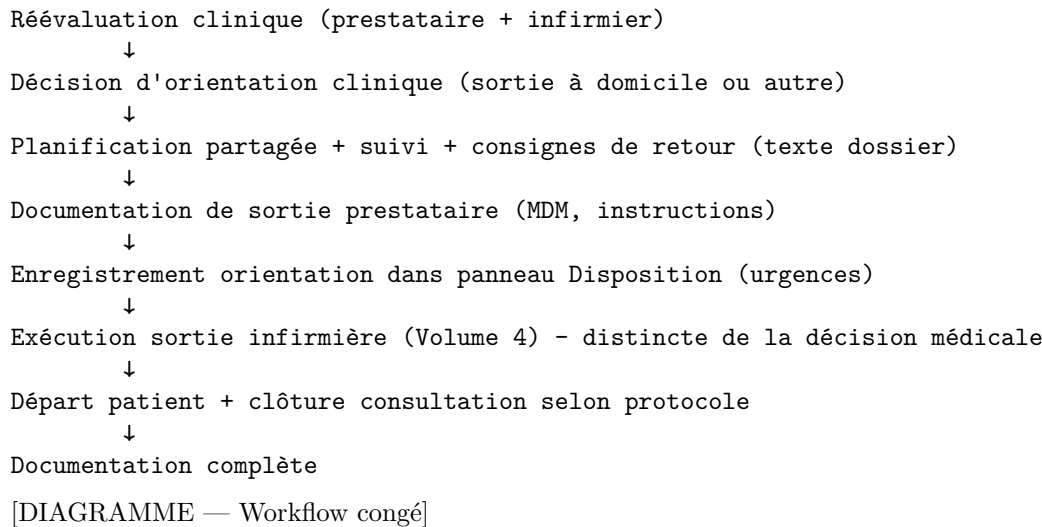
2. Workflow congé et sortie

2.1 Philosophie de sortie

La sortie doit refléter :

- **Réévaluation finale** ;
- **Compréhension patient** (ou aidant / interprète) ;
- **Suivi planifié** et **consignes de retour** ;
- **Incertitude non résolue** lorsque applicable — sans fausse certitude.

2.2 Séquence opérationnelle



2.3 Distinction fondamentale

Niveau	Responsable	Medora
Orientation / documentation sortie prestataire	Prestataire	MDM, instructions, Enregistrer la décision d'orientation (Disposition)
Exécution sortie infirmière	Infirmier(ère)	Vérification, enseignement, destination, heure — sans créer la décision médicale

L'infirmier ne crée pas la décision clinique de sortie du prestataire ; il confirme et exécute le processus opérationnel de sortie.

2.4 Planification partagée et famille

Documenter ce qui a été **explié** et **compris** — pas seulement ce qui a été dicté. Impliquer aidant si autorisation et protocole.

2.5 Résultats en attente

Si résultats critiques ou décisionnels manquent :

- Documenter l'**attente** et le plan ;
- Ne pas présenter une sortie comme « tout résolu » si incertitude persiste ;
- Communication **selon la politique de l'établissement**.

2.6 Refus, LAMA, LWBS

Situation	Orientation opérationnelle
LAMA / contre avis médical	Orientation enregistrée ; documentation risques expliqués

Situation	Orientation opérationnelle
LWBS / parti sans être vu	Protocole local ; traçabilité tableau / dossier
Refus soins partiel	Documenter portée du refus ; réévaluation si changement

2.7 Deux niveaux dans Medora (rappel)

Niveau	Où
Narratif	Champs MDM, instructions, intelligence motif (Volume 3)
Opérationnel	Onglet Disposition (urgences) — orientation enregistrée

[CAPTURE D'ÉCRAN — Workflow disposition] [CAPTURE D'ÉCRAN — Exécution de sortie]

3. Workflow observation

3.1 Objectif opérationnel

Observation et court séjour (type consultation **INPATIENT** en UI : « Observation et court séjour ») permet une **surveillance prolongée** sans équivaloir automatiquement à une admission hospitalière complète.

Observation admission automatique.

3.2 Décision et documentation

- Prestataire documente **justification d'observation** (texte MDM) ;
- Orientation **Admission / observation (court séjour)** dans panneau Disposition ;
- Dossier admission structuré sur consultation si workflow admission activé (prestataire).

3.3 Réévaluation en observation

- Réévaluations prestataire et infirmière selon protocole unité ;
- Signes vitaux, douleur, réponse traitement ;
- Badges séjour prolongé / vitaux anciens sur chrome observation si applicable.

3.4 Séjour prolongé aux urgences vs observation

Contexte	Attention
Boarding ED	Patient orienté observation mais lit non disponible — documenter délai, réévaluer
Unité observation	Suivi MAR, ordres, sortie observation

3.5 Résultats en attente

Coordonner avec Volume 5 (labo/imagerie) — ne pas clôturer observation sans plan pour résultats décisionnels si protocole l'exige.

3.6 Transition

Depuis observation : **sortie**, **admission** (si escalade), ou **transfert** — nouvelle orientation documentée.

Routes : /app/encounters/{id}, tableau /app/hospitalisation.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Observation]

4. Workflow admission

4.1 Séquence opérationnelle

Décision d'admission (orientation clinique)

↓

Documentation justification + dossier admission (prestataire)

↓

Enregistrement orientation Admission / observation (Disposition)

↓

Communication service receveur / lit

↓

Coordination placement (box → unité)

↓

Handoff infirmier + résultats en attente

↓

Transition de soins

[DIAGRAMME — Workflow admission/transfert]

4.2 Philosophie justification admission

Documenter **pourquoi** le patient ne peut être sorti en sécurité : incapacité sortie sûre, besoin monitoring/IV, social si pertinent au plan clinique — **incertitude acceptable**.

4.3 Coordination lit / placement

Medora documente la décision — l'**attribution lit** reste opération hospitalière locale. Documenter **boarding** et délais si impact soins.

4.4 Handoff infirmier

- État actuel, interventions, allergies, médicaments ;
- Résultats en attente ;
- Enseignement déjà réalisé ;
- Effets personnels.

4.5 Escalade

- Détérioration avant placement ;
- Refus lit / saturation unité ;
- Discordance identité ou dossier incomplet.

4.6 Résultats en attente

Communiquer au service receveur les analyses/imagerie en cours — **selon protocole handoff**.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Admission]

5. Workflow transfert

5.1 Objectif opérationnel

Transférer le patient vers **un autre établissement** ou niveau de soins avec documentation, stabilité et acceptation selon protocole local.

5.2 Séquence

Décision transfert + justification (prestataire)
↓
Communication établissement / prestataire receveur
↓
Documentation transfert (texte + orientation Transfert)
↓
Coordination transport + équipe
↓
Handoff + dossier / synthèse disponible
↓
Départ documenté

5.3 Sensibilisation EMTALA (sans conseil juridique)

Dans certains contextes réglementaires (ex. États-Unis), des règles **EMTALA** encadrent transfert et stabilisation. **Ce manuel ne fournit pas de conseil juridique.** Suivre **politique institutionnelle** et conseil local. Medora peut héberger champs complémentaires EMTALA selon déploiement — formation locale requise.

5.4 Dossier / paquet transfert

- Synthèse consultation, résultats, imagerie pertinente ;
- Export ou impression selon protocole — voir section export (consultation **clôturée** pour instantané figé).

5.5 Patient instable

Escalade immédiate — ne pas transférer sans stabilisation si protocole l'interdit. Documentation contemporaine.

5.6 Retards transport

Réévaluation infirmière continue ; communication prestataire si délai prolongé.

5.7 Résultats en attente

Documenter ce qui est **connu** vs **en attente** pour l'établissement receveur.

6. Dévoilement de dossier (ROI)

6.1 Définition et objectif

ROI = Dévoilement de dossier (ROI) — workflow **administratif** pour demander, examiner, approuver et **exécuter** la communication contrôlée de dossier patient à un destinataire autorisé.

Route principale : `/app/admin/roi` (réservé **ADMIN** établissement).

6.2 Périmètre Medora (honnête)

Inclus	Limité / absent
Création demande (patient, consultation liée, type, objet)	Envoi automatique courriel / fax externe
Approbation, refus, annulation	Portail patient self-service complet
Exécution liée à instantané export consultation clôturée	Remplacement counsel juridique
Audit des actions (métadonnées sans PHI inutile)	Politique ROI locale — établissement responsable

Les workflows ROI suivent la politique institutionnelle et juridique de l'établissement.
Medora fournit traçabilité et outils — pas l'interprétation légale.

6.3 Types de demande (produit)

- Demande patient ;
- Assurance ;
- Juridique / tribunal ;
- Régulateur / MSPP ;
- Audit interne.

6.4 Cycle de vie demande ROI

Création demande (ADMIN)

↓

Examen / approbation ou refus

↓

(Si approuvée) Exécution - liaison instantané export consultation clôturée

↓

Statut Exécutée - aperçu HTML parcours ROI

↓

Remise au destinataire selon protocole hors produit (courrier, remise sécurisée, etc.)

Statuts visibles : Approuvée, Exécutée, Refusée, Annulée (selon workflow).

6.5 Rôles

Acteur	Action
Admin établissement	Créer, approuver, refuser, annuler, exécuter
Personnel clinique	Ne gère pas ROI — orienter vers admin / dossiers médicaux
Opérateur plateforme	Surveillance agrégée (<code>/app/admin/roi-monitoring</code>) — compteurs sans PHI

6.6 Gouvernance et audit (aperçu)

- Actions ROI journalisées ;
- Métadonnées audit **sans** noms/MRN/texte clinique dans logs ROI ;
- En panne audit / intégrité : **ne pas exécuter** ROI jusqu'à résolution (runbook exploitation).

6.7 Demandes externes

Vérifier **identité demandeur, autorisation, périmètre minimum nécessaire** — selon politique **institutionnelle**. Medora enregistre l'objet interne ; la validation légale reste humaine.

[CAPTURE D'ÉCRAN — ROI] [DIAGRAMME — Workflow ROI]

7. Export dossier et instantané — sensibilisation

7.1 Objectif opérationnel (Phase 5F)

L'**export dossier** Medora produit un **instantané figé** d'une consultation **clôturée** — support pour continuité, transfert, conformité et exécution ROI.

7.2 Philosophie instantané immuable

- L'instantané **ne change pas** après création ;
- Reflète l'état du dossier **au moment de la clôture / export** ;
- Les modifications ultérieures du dossier live **ne mettent pas à jour** l'instantané existant.

7.3 Formats opérationnels

- **JSON** — échange structuré ;
- **HTML** — lecture humaine, aperçu ROI ;
- Impression / PDF selon navigateur et protocole local.

7.4 Vérification opérationnelle

Avant remise ou exécution ROI :

- Confirmer **bon patient, bonne consultation** ;
- Consultation **clôturée** ;
- Relire aperçu HTML — sections attendues présentes ;
- Résultats encore en attente au moment clôture : **visibles comme tels** dans l'instantané ou documentés en amont.

7.5 Ce que ce chapitre n'expose pas

Pas de détail sur : empreintes cryptographiques, schémas internes, métadonnées audit techniques, clés de signature — réservés exploitation / conformité IT.

7.6 Panne durée / intégrité

Si création instantané ou exécution ROI échoue : **stop**, protocole papier institutionnel, incident IT — ne pas contourner les garde-fous.

8. Sécurité opérationnelle disposition et ROI

8.1 Disposition / sortie / admission / transfert

Risque	Mesure
Sortie avant réévaluation	Checklist réévaluation ; cohérence texte orientation
Résultats en attente ignorés	Documenter attente ; plan suivi
Suivi flou	Date, lieu, raison du RDV dans instructions
Barrière linguistique	Interprète ; exécution sortie infirmière
Sortie patient instable	Escalade ; ne pas enregistrer domicile si protocole interdit
Handoff incomplet	Checklist admission/transfert
Retard transfert	Réévaluation ; communication
Boarding prolongé	Documentation ; escalade charge infirmière

8.2 ROI / confidentialité

Risque	Mesure
Dévoilement mauvais patient	Vérifier UUID patient + consultation
Dévoilement non autorisé	Approbation ADMIN ; refus documenté
Revue demande incomplète	Objet / type / destinataire renseignés
Attentes audit	Actions tracées ; pas de contournement
Divulgateion excessive	Principe minimum nécessaire — politique locale
Panne système	Pas d'exécution ROI « informelle » sans trace

9. Mobile et tablette — disposition

9.1 Initiative 19M.6

Le panneau **Disposition (urgences)** et l'**exécution sortie infirmière** s'empilent en **colonne unique** sur mobile/tablette :

- Décision prestataire, planification partagée, aperçu repliable ;
- Champs exécution sortie pleine largeur ;
- Cibles tactiles 44 px.

9.2 Recommandations

Usage	Appareil
Orientation active, exécution sortie au chevet	Tablette acceptable
Documentation MDM / sortie prolongée	Bureau ou tablette paysage
Revue ROI, approbation, exécution instantané	Bureau préféré
Téléphone	Consultation statut orientation — limité pour saisie longue

Tablette acceptable pour workflow sortie actif ; bureau préféré pour documentation prolongée et revue ROI.

9.3 Haïti — connectivité

- Enregistrer orientation sur serveur avant départ patient ;
 - Brouillon local prestataire : relire avant signature (Volume 3) ;
 - ROI / instantané : **ne pas exécuter** si synchronisation ou audit en échec — protocole admin local.
-

10. Communication opérationnelle et handoffs

10.1 Prestataire infirmier

- Orientation enregistrée avant exécution sortie ;
- Changement plan après réévaluation — mettre à jour texte **et** Disposition ;
- Résultats critiques : verbal + documentation.

10.2 Handoff admission

Verbal + note structurée ; résultats pending ; allergies ; plan thérapeutique.

10.3 Handoff transfert

Acceptation receveur ; stabilité ; mode transport ; dossier disponible.

10.4 Observation

Communication équipe observation ; passage consignes ; MAR et ordres actifs.

10.5 Aidants

Impliquer si autorisation ; documenter dans exécution sortie ou note.

10.6 Relève de quart

Revue orientations en attente, patients boarding, ROI approuvées non exécutées (admin).

Focus : **communication workflow** — pas messagerie interne cachée.

11. Résumé opérationnel rapide — checklists

11.1 Checklist sortie

- ☐ Réévaluation documentée
- ☐ Orientation clinique cohérente avec dossier
- ☐ Consignes de retour + suivi
- ☐ Compréhension patient
- ☐ Orientation enregistrée (Disposition)
- ☐ Exécution sortie infirmière complétée

- ☐ Résultats en attente gérés

11.2 Checklist observation

- ☐ Justification observation texte
- ☐ Orientation observation enregistrée
- ☐ Plan réévaluation
- ☐ Résultats pending identifiés
- ☐ Transition sortie/admission/transfert planifiée

11.3 Checklist admission

- ☐ Décision prestataire + dossier admission
- ☐ Communication service receveur
- ☐ Handoff infirmier
- ☐ Résultats en attente communiqués
- ☐ Boarding documenté si délai lit

11.4 Checklist transfert

- ☐ Acceptation receveur (selon protocole)
- ☐ Stabilité patient
- ☐ Documentation + orientation Transfert
- ☐ Transport coordonné
- ☐ Paquet / synthèse disponible

11.5 Checklist demande ROI

- ☐ Bon patient / bonne consultation
- ☐ Type et objet renseignés
- ☐ Autorisation vérifiée (politique locale)
- ☐ Approbation ADMIN
- ☐ Consultation clôturée avant instantané
- ☐ Exécution + remise selon protocole hors produit

11.6 Checklist résultats en attente

- ☐ Liste résultats manquants documentée
- ☐ Plan suivi / rappel
- ☐ Patient informé si applicable
- ☐ Handoff mentionne pending

11.7 Checklist anti mauvais patient

- ☐ Bandeau identité
- ☐ Orientation patient présent
- ☐ ROI : UUID patient vérifié
- ☐ Export : consultation clôturée correcte

11.8 Checklist communication sortie

- ☐ Consignes de retour verbalisées
 - ☐ Médicaments / suivi expliqués
 - ☐ Questions répondues
 - ☐ Interprète si besoin
 - ☐ Refus / LAMA documentés
-

12. Gouvernance du chapitre

12.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction médicale urgences	Orientation, admission, transfert
Direction infirmière	Exécution sortie, handoffs
Administration / conformité	ROI, export, audit
Référent terminologie	Canon — Orientation vs Disposition

12.2 Revue leadership

Recommandée **annuellement** : lead MD, lead infirmier, admin dossiers, référent ROI, exploitation IT.

12.3 Lien gouvernance ROI (Phase 5G)

Formation admin sur cycle demande → approbation → exécution instantané. Surveillance plateforme sans PHI.

12.4 Lien export dossier (Phase 5F)

Formation : instantané = figé, consultation clôturée, vérification avant remise.

12.5 Déploiement Haïti

- Atelier orientation vs Disposition + exécution sortie ;
- Protocole papier si panne ROI/export ;
- Effectifs réduits : checklists courtes affichées au poste.

12.6 Formation

- Prestataires : panneau Disposition 19M.6 ;
- Infirmiers : Volume 4 exécution sortie ;
- Admins : ROI + export une fois par trimestre (exercice table).

12.7 Révision annuelle

Mettre à jour si nouvelles orientations UI, observation, ou règles ROI export.

Annexes

A. Orientations produit (urgences — aperçu)

Domicile, Admission / observation (court séjour), Transfert, LAMA, LWBS, Décès, Autre — libellés UI français ; enregistrement via panneau Disposition.

B. Références

- Volume 3 — Prestataire
- Volume 4 — Infirmier
- Observation — positionnement
- docs/ui/cross-device-qa-checklist-19M8.md (19M.6)
- docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md (ROI / export en panne)

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Workflow disposition]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Exécution de sortie]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Observation]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Admission]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — ROI]

- [DIAGRAMME — Workflow congé]
 - [DIAGRAMME — Workflow admission/transfert]
 - [DIAGRAMME — Workflow ROI]
-

Fin du Volume 6 — M-BOOK.FR.7

Volume 7 — Administration, gouvernance et opérations plateforme

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.8

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Administrateurs établissement, responsables conformité, support opérationnel, direction, formateurs

Prérequis : Volumes 1–6 (parcours clinique complet)

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	7 — Administration, gouvernance et opérations plateforme
Routes principales	/app/admin, /app/admin/users, /app/admin/audit, /app/admin/roi, /app/admin/system-health
Architecture liée	ROI Phase 5G · Export dossier Phase 5F · Responsive 19M · Journal d'audit
Révision recommandée	Annuelle ou après changement RBAC / ROI / déploiement

1. Introduction à la gouvernance plateforme

1.1 Rôle opérationnel de l'administration

L'administration Medora assure :

- La **gestion des accès** (comptes, rôles, établissements) ;
- La **traçabilité** (journal d'audit) ;
- La **conformité opérationnelle** (ROI, exports, sauvegardes) ;
- La **surveillance plateforme** (santé système, continuité) ;
- Le **soutien au déploiement** et à la formation.

1.2 Philosophie de gouvernance

Principe	Application
Moindre privilège	Chaque utilisateur n'accède qu'au nécessaire pour son poste
Traçabilité	Actions sensibles journalisées
Responsabilité humaine	Medora assiste — la direction reste responsable des politiques
Séparation clinique / admin	Accès administratif accès clinique automatique
Continuité honnête	Medora est dépendant du cloud — protocoles papier en panne

1.3 Responsabilités sécurité

- Comptes **personnels** — pas de comptes partagés ;

- Postes **verrouillés** en absence ;
- **Confidentialité patient** sur tous les écrans ;
- Escalade incidents sécurité / confidentialité.

1.4 Continuité des opérations

Planifier : formation, relève admin, runbook panne, vérification post-reconnexion (synchronisation en attente, réconciliation papier).

1.5 Attentes audit

Le **journal d'audit** soutient la relecture opérationnelle et la responsabilité — pas le remplacement d'une politique de conformité locale.

1.6 Comptes utilisateurs

Chaque membre du personnel reçoit un **compte nominatif**. L'administrateur provisionne, assigne rôles par **établissement**, désactive à la sortie.

1.7 Intendance des données

Les données patient appartiennent à l'**établissement** — Medora fournit l'infrastructure et les garde-fous ; la gouvernance locale prime.

1.8 Responsabilité institutionnelle

Medora-S soutient les workflows de gouvernance. La direction institutionnelle reste responsable de la politique opérationnelle, de la conformité et de la formation du personnel.

2. Définitions des rôles administratifs

2.1 Administrateur plateforme / établissement

Aspect	Détail
Responsabilités	Utilisateurs, rôles, établissement, ROI, audit, exports, santé système
Escalade	Incident plateforme → support opérationnel / opérateur Medora
Workflow	/app/admin/* selon droits ADMIN établissement
Gouvernance	Revue trimestrielle accès ; pas d'auto-promotion abusive

2.2 Superviseur clinique

Aspect	Détail
Responsabilités	Qualité workflow clinique, escalade sécurité patient — hors admin système par défaut
Escalade	Détresse opérationnelle, saturation, exceptions protocole

Aspect	Détail
Gouvernance	Signale erreurs workflow ; ne contourne pas RBAC

2.3 Responsable ROI

Aspect	Détail
Responsabilités	Examen demandes dévoilement dossier, approbation, exécution (Volume 6)
Escalade	Demande juridique complexe → counsel / direction
Gouvernance	Minimum nécessaire ; audit des actions ROI

2.4 Responsable conformité

Aspect	Détail
Responsabilités	Politique confidentialité, formation, revue incidents audit/ROI
Escalade	Fuite présumée, accès non autorisé
Gouvernance	Lien avec journal d'audit et surveillance ROI agrégée

2.5 Support opérationnel

Aspect	Détail
Responsabilités	Premier niveau : accès, formation, panne, confusion workflow
Escalade	Bug produit, panne infrastructure → opérateur technique
Gouvernance	Pas de partage identifiants ; documentation incidents

2.6 Gestionnaire établissement

Aspect	Détail
Responsabilités	Effectifs, horaires, coordination déploiement pilote
Escalade	Ressources insuffisantes, connectivité Haïti
Gouvernance	Alignement formation modules actifs

2.7 Responsable formation

Aspect	Détail
Responsabilités	Onboarding Volumes 1–7, recyclage, nouveaux rôles
Escalade	Échec adoption workflow → révision procédure
Gouvernance	Checklists par rôle ; pas de contournement « informel »

3. Établissement et gestion utilisateurs

3.1 Concept établissement (facility)

Medora isole les données par **établissement** :

- Sélecteur d'établissement dans l'en-tête application ;
- Rôles assignés **par établissement** ;
- Données cliniques limitées à l'établissement actif.

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs établissements — vérifier le **bon contexte** avant toute action admin ou clinique.

3.2 Provisionnement utilisateur

Route : `/app/admin/users`

Séquence typique :

Création compte (identité, courriel)
↓
Assignation rôle(s) pour l'établissement
↓
Activation accès établissement
↓
Mot de passe initial / réinitialisation selon protocole
↓
Formation onboarding (Volume adapté au rôle)
↓
Vérification page d'accueil (landing) correcte

3.3 Activation / désactivation

- **Désactiver** le compte ou l'accès établissement à la **sortie** du personnel — immédiat ;
- Ne pas laisser comptes orphelins actifs ;
- Revue périodique liste utilisateurs.

3.4 Mot de passe et sécurité

- Mots de passe **forts** ; pas de partage ;
- MFA si activé par déploiement — suivre procédure locale ;
- Réinitialisation via admin selon politique établissement.

3.5 Assignation rôles — sensibilisation

Rôles produit courants (Haïti pilote) :

Rôle	Usage opérationnel
ADMIN	Administration établissement
PROVIDER	Prestataire clinique
RN	Infirmier(ère)
FRONT_DESK	Accueil
LAB	Laboratoire
RADIOLOGY	Imagerie
PHARMACY	Pharmacie
BILLING	Facturation

Assigner le **minimum** de rôles nécessaires.

3.6 Onboarding / offboarding

Phase	Actions admin
Entrée	Compte + rôles + formation + checklist rôle
Changement poste	Ajuster rôles ; retirer accès obsolètes
Sortie	Désactivation ; revue actions récentes si incident

3.7 Escalade superviseur

Confusion d'accès → admin ; besoin clinique urgent → superviseur clinique — **pas** partage de compte ADMIN.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Gestion utilisateurs]

4. RBAC et gouvernance des accès

4.1 Contrôle d'accès par rôle (RBAC)

Medora filtre :

- **Navigation** (menus visibles) ;
- **API** (actions autorisées côté serveur).

L'interface et le serveur doivent **concorder** — ne pas supposer qu'un menu caché suffit à protéger une action (le serveur refuse aussi).

4.2 Philosophie du moindre privilège

Le personnel ne doit accéder qu'aux informations requises pour ses fonctions opérationnelles.

Exemples :

- Technicien labo : file laboratoire — **pas** dossier clinique complet ;
- Pharmacien : file pharmacie + hub pharmacie — identifiants patient **limités** sur file ;
- Accueil : inscription — **pas** documentation prestataire complète.

4.3 Accès clinique vs administratif

Type	Exemples
Clinique	Triage, documentation, MAR, disposition
Administratif	Utilisateurs, audit, ROI, exports, santé système

ADMIN établissement a accès admin — **formation distincte** de la pratique clinique.

4.4 Auditabilité

Les accès sensibles laissent une trace dans le **journal d'audit** — relecture périodique recommandée.

4.5 Interdiction des comptes partagés

Les comptes partagés sont interdits. Chaque action doit être attribuable à une personne.

Pas de « compte infirmière », « compte médecin du jour », « compte accueil » partagé.

4.6 Poste de travail

- Verrouiller session en quittant le poste ;
- Écran orienté pour **confidentialité** (pas visible salle d'attente) ;
- Déconnexion fin de quart si poste partagé — **compte personnel** tout de même.

4.7 Accès mobile

- Téléphone / tablette : même RBAC ;
- **Limitations ergonomiques** (19M) — pas une exemption confidentialité ;
- Appareil perdu → désactivation compte + incident.

4.8 Ce que ce chapitre n'expose pas

Pas de détail sur : schémas permissions internes, matrices JWT, architecture admin cachée — réservé documentation technique exploitation.

[DIAGRAMME — Gouvernance accès]

5. Audit et workflows de gouvernance

5.1 Philosophie audit

Le **journal d'audit** (/app/admin/audit) enregistre des **actions sensibles** pour :

- Relecture opérationnelle ;
- Responsabilité en cas d'incident ;
- Soutien conformité locale.

5.2 Traçabilité opérationnelle

Exemples d'événements (aperçu, sans métadonnées internes) :

- Ouverture dossier ;
- Enregistrement triage ;
- Accusé / complétion ordre ;
- Export dossier ;
- Actions ROI ;
- Échecs intégrité export (surveillance).

5.3 Responsabilité

Les utilisateurs sont responsables des actions sous **leur compte**. Admin ne doit pas utiliser compte personnel d'un clinicien.

5.4 Surveillance workflow

Revue périodique :

- ROI approuvées non exécutées ;

- Exports échoués (surveillance exports admin);
- Comptes inactifs encore actifs.

5.5 Gouvernance disposition (aperçu)

Volume 6 — orientation enregistrée, cohérence documentation. **Pas** de règles d'implémentation gouvernance sortie exposées ici.

5.6 Gouvernance carry-forward (aperçu)

Volume 2 — reprise antécédents **revue**, pas auto-confirmée. Admin forme le personnel sur statuts revue.

5.7 Gouvernance export dossier (Phase 5F)

Instantané **figé**, consultation **clôturée** — admin vérifie processus remise. Pas de détail schéma / empreintes.

5.8 Métadonnées audit

Les logs ROI/export évitent PHI inutile dans métadonnées — exploitation IT pour détail technique.

6. Administration ROI et surveillance

6.1 Workflow admin ROI (Phase 5G)

Route : `/app/admin/roi` (ADMIN établissement)

Rappel Volume 6 :

Demande → Approbation / Refus / Annulation → Exécution (instantané export)

Politique ROI = institution — Medora trace, n'impose pas le cadre juridique haïtien ou autre.

6.2 Revue demande

Vérifier : bon patient, type demande, objet, autorisation externe selon **politique locale**.

6.3 Surveillance ROI agrégée

Route : `/app/admin/roi-monitoring` (opérateur plateforme / super-admin selon déploiement)

- Compteurs par statut / établissement;
- **Sans** PHI affichée;
- Repérer files APPROVED non exécutées.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Surveillance ROI]

6.4 Confidentialité et minimum nécessaire

Ne divulguer via ROI que le **strict nécessaire** au destinataire autorisé.

6.5 Escalade

Demande juridique ambiguë → conseil; panne exécution → stop + runbook panne.

[DIAGRAMME — Workflow ROI]

7. Opérations plateforme et déploiement

7.1 Philosophie déploiement

Medora-S pilote Haïti : déploiement **progressif**, formation par module, **vérification** avant promotion production.

7.2 Environnements (aperçu opérationnel)

Environnement	Usage
Formation / staging	Exercices, nouveaux admins, tests workflow
Production	Soins patients réels — seul environnement clinique officiel

Ne pas mélanger données réelles et exercices. Former d’abord sur staging si disponible.

7.3 Planification mise à jour

- Fenêtre hors pointe si possible ;
- Annoncer personnel (French notice) ;
- Vérifier post-déploiement : connexion, file, export, ROI si touché ;
- Référence : `docs/DEPLOYMENT_RUNBOOK.md` (exploitation).

7.4 Coordination formation

Toute mise à jour UI workflow → brief superviseurs + fiche delta manuel.

7.5 Pilote Haïti

- Modules P1 d’abord (accueil, triage, tableau, documentation, soins, disposition) ;
- P2 ensuite (pharmacie, labo, imagerie, ROI, admin) ;
- Effectifs réduits : prioriser checklists courtes.

7.6 Connectivité

- Connexion internet **requis** pour usage normal ;
- Lignes **synchronisation en attente** possibles — protocole reconnexion ;
- **Medora est dépendant du cloud** — pas de mode hors-ligne complet aujourd’hui.

7.7 Escalade opérationnelle

Niveau	Contact
1	Support opérationnel local / super-utilisateur
2	Administrateur établissement
3	Opérateur Medora / exploitation
Clinique urgent	Superviseur clinique + papier si panne

[CAPTURE D’ÉCRAN — Tableau de bord plateforme]

8. Panne et continuité d'activité

8.1 Position honnête

Medora-S est un système en ligne, dépendant du cloud et de la connectivité. Il n'offre pas aujourd'hui de mode hors-ligne complet ni de synchronisation offline-first.

Ne pas promettre continuité numérique sans internet.

8.2 Interruption internet

1. Superviseur déclare **protocole papier** ;
2. Accueil : registre papier ;
3. Clinique : triage / MAR / notes papier selon runbook ;
4. Noter heures début / fin panne ;
5. **Reconciliation** après retour — ne pas backdater abusivement.

8.3 Connectivité dégradée

- Saisie locale possible sur certains brouillons — **relire** après sync ;
- Cartes **synchronisation en attente** sur files ordres ;
- Éviter signatures / ROI / export instantané tant que serveur incertain.

8.4 Panne plateforme (API / hébergement)

- Basculer papier immédiatement si login impossible site entier ;
- Admin informe opérateur ;
- **Ne pas** exécuter ROI ni export légalement significatif pendant panne audit/intégrité.

8.5 Vérification reprise

Après reconnexion :

- Connexion fraîche par poste ;
- Smoke test : ouverture dossier, enregistrement test, file ;
- Revue pending sync ;
- Réconciliation papier → saisie avec horodatage honnête en note.

8.6 Communication panne

- Message staff **en français** ;
- Qui décide papier ; qui contacte support ;
- Horaire reprise estimée si connu.

Référence exploitation : docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md.

[DIAGRAMME — Continuité activité]

9. Mobile et tablette — gouvernance

9.1 Initiative 19M (rappel)

Medora supporte progressivement téléphone / tablette :

- Navigation tiroir mobile ;
- Tableau des urgences empilé ;

- Documentation / disposition empilées ;
- Fiches auxiliaires cartes tactiles.

9.2 Recommandations appareils

Usage	Appareil
Production clinique dense	Poste fixe 1280px+
Chevet, files, revue rapide	Tablette
Consultation courte	Téléphone — limité

9.3 Appareil partagé

- Compte **personnel** même sur tablette partagée ;
- Déconnexion obligatoire ;
- Pas de mémorisation mot de passe sur appareil commun non supervisé.

9.4 Confidentialité écran

- Filtre confidentialité si possible ;
- Ne pas photographier écran patient ;
- Volume sonore notifications.

9.5 Limitations téléphone

Documentation longue, ROI admin, gestion utilisateurs : **bureau préféré**.

9.6 Haïti

Connectivité intermittente : privilégier postes filaires pour admin ; tablettes cliniques avec plan papier de secours.

10. Sécurité et confidentialité

Risque	Mesure
Identifiants partagés	Interdiction ; compte nominatif
Poste non verrouillé	Verrouillage ; timeout session
Mauvais utilisateur	Déconnexion ; bon compte
ROI non autorisé	Workflow approbation ; audit
Capture écran / photo	Interdit sans autorisation
Wi-Fi public	Éviter accès dossier ; VPN si politique
Hygiène mot de passe	Fort ; unique ; pas sur post-it
Confidentialité patient	Minimum nécessaire à l'écran
Perte vol appareil	Désactivation compte ; incident
Hameçonnage	Ne pas cliquer liens ; vérifier URL login

11. Support opérationnel

11.1 Escalade incident

Utilisateur → super-utilisateur / support local

↓

Administrateur établissement

↓

Opérateur plateforme (panne, bug)

↓

Direction + conformité (confidentialité)

[DIAGRAMME — Escalade opérationnelle]

11.2 Dépannage opérationnel (premier niveau)

Symptôme	Action
Menu manquant	Vérifier rôle + établissement sélectionné
Erreur enregistrement	Réessayer ; noter heure ; pending sync ?
Mauvais patient	Stop ; superviser
Confusion workflow	Renvoyer Volume manuel ; formation

11.3 Communication panne

Modèle affichage : « Medora indisponible — protocole papier actif — heure début ».

11.4 Escalade formation

Workflow non compris → responsable formation ; **pas** contournement RBAC.

11.5 Urgence opérationnelle clinique

La **sécurité patient** prime sur l'enregistrement numérique — papier puis reconciliation.

Focus : **workflow opérationnel** — pas outillage engineering interne.

12. Résumé opérationnel rapide — checklists

12.1 Checklist onboarding administrateur

- ☐ Accès ADMIN établissement confirmé
- ☐ Runbook panne lu
- ☐ /app/admin/users maîtrisé
- ☐ ROI + audit visités
- ☐ Santé système / sauvegarde consultés
- ☐ Contact opérateur noté

12.2 Checklist provisionnement utilisateur

- ☐ Identité vérifiée
- ☐ Rôles minimum nécessaires
- ☐ Bon établissement
- ☐ Formation Volume assigné
- ☐ Compte actif testé
- ☐ Offboarding planifié si temporaire

12.3 Checklist revue RBAC

- ☐ Comptes inactifs désactivés
- ☐ Rôles alignés postes actuels
- ☐ Pas de comptes partagés
- ☐ ADMIN limité aux personnes de confiance
- ☐ Revue trimestrielle datée

12.4 Checklist gouvernance ROI

- ☐ Demande complète
- ☐ Autorisation locale vérifiée
- ☐ Approbation tracée
- ☐ Consultation clôturée avant instantané
- ☐ Remise hors produit selon protocole

12.5 Checklist panne

- ☐ Papier activé
- ☐ Heure début notée
- ☐ Staff informé (FR)
- ☐ ROI/export légaux suspendus si requis
- ☐ Reconciliation planifiée

12.6 Checklist sécurité / confidentialité

- ☐ Postes verrouillés

- ☐ Comptes personnels
- ☐ Écrans orientés
- ☐ Pas de photos dossier
- ☐ Incident confidentialité escaladé

12.7 Checklist déploiement Haïti

- ☐ Modules P1 formés
- ☐ Connectivité testée
- ☐ Papier secours imprimé
- ☐ Admin + support identifiés
- ☐ Staging exercice si disponible
- ☐ Fenêtre mise à jour communiquée

12.8 Checklist escalade opérationnelle

- ☐ Symptôme documenté (heure, écran, action)
- ☐ Niveau 1 contacté
- ☐ Sécurité patient assurée
- ☐ Direction informée si SEV critique

13. Gouvernance du chapitre

13.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction établissement	Politique gouvernance, conformité
Administrateur principal	Exactitude procédures admin
Référent terminologie	Canon
Opérateur Medora	Runbooks exploitation (hors manuel clinique)

13.2 Revue leadership

Annuelle : RBAC, ROI, panne, formation, 19M device policy.

13.3 Lien gouvernance ROI / export

Volumes 6–7 + Phase 5F/5G — formation admin obligatoire avant autonomie ROI.

13.4 Revue déploiement Haïti

Semestrielle : connectivité, effectifs, modules actifs, checklists papier.

13.5 Gouvernance formation

Matrice rôle → Volume manuel ; attestation lecture pour ADMIN et ROI.

13.6 Mises à jour

Changement RBAC UI, nouvelle route admin, runbook panne → révision chapitre + tests frenchHandbookAdministrationGov

Annexes

A. Routes admin (aperçu)

Route	Usage
/app/admin	Hub administration
/app/admin/users	Utilisateurs et rôles
/app/admin/audit	Journal d'audit
/app/admin/roi	Dévoilement dossier
/app/admin/roi-monitoring	Surveillance ROI agrégée
/app/admin/system-health	Santé système
/app/admin/backup-readiness	Préparation sauvegarde
/app/admin/exports	Surveillance exports
/app/admin/compliance	Conformité (selon déploiement)
/app/admin/go-live	Checklist go-live

B. Références exploitation

- Volume 6 — ROI
- docs/DEPLOYMENT_RUNBOOK.md
- docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md
- docs/HAITI_MVP_PILOT.md
- docs/ui/cross-device-qa-checklist-19M8.md

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Administration Medora]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Surveillance ROI]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Gestion utilisateurs]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Tableau de bord plateforme]
- [DIAGRAMME — Gouvernance accès]

- [DIAGRAMME — Workflow ROI]
 - [DIAGRAMME — Escalade opérationnelle]
 - [DIAGRAMME — Continuité activité]
-

Fin du Volume 7 — M-BOOK.FR.8

Volume 8 — Mobile, tablette et opérations de déploiement Haïti

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.9

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Cliniciens, infirmiers, auxiliaires, administrateurs, formateurs, direction pilote Haïti

Prérequis : Volumes 1–7 · Volume 7 — Admin

Terminologie : Canon terminologique · Guide de style

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	8 — Mobile, tablette et opérations de déploiement Haïti
Initiative liée	Responsive 19M.1–19M.9
Références techniques	docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md · docs/ui/cross-device-qa-checklist-19M8.md
Pilote	Haïti — connectivité variable, tablettes, protocole papier
Révision recommandée	Annuelle ou après phase 19M / changement déploiement

1. Introduction aux opérations mobile et tablette

1.1 Pourquoi Medora supporte mobile / tablette

Les urgences et soins urgents exigent de la **mobilité** :

- Triage au poste d'accueil ou au box ;
- Documentation au **chevet** ;
- Revue file / tableau en déplacement ;
- Exécution sortie au lit du patient.

Medora a été rendu **responsive** (initiative **19M**) pour que les workflows fréquents restent utilisables sur tablette et, dans une mesure limitée, sur téléphone.

1.2 Mobilité opérationnelle aux urgences

Objectif	Moyen
Réactivité	Ouvrir dossier depuis tableau sans retour bureau fixe
Sécurité	Identité patient visible sur cartes / bandeau avant action
Continuité	Même dossier cloud sur tous les appareils autorisés

1.3 Philosophie chevet

La **tablette au chevet** convient aux workflows **actifs** : triage, réévaluation, vitaux, exécution sortie, revue rapide. La documentation **longue et complexe** reste plus sûre sur **poste fixe ou portable**.

1.4 Concepts tablette-first (sans exagération)

- **Triage et réévaluation infirmière** : empilement < 960 px — champs atteignables ;
- **Disposition / sortie** : colonne unique mobile (19M.6) ;
- **Files auxiliaires** : cartes MedoraCard tactiles (19M.7).

1.5 Limitations téléphone

Le **téléphone** convient à : navigation, coup d’œil tableau, accusé file, revue courte. **Non recommandé** pour : documentation prestataire prolongée, MDM dense, gestion admin, ROI.

1.6 Objectifs responsive Medora

- Pas de barre latérale permanente < 1024 px (menu tiroir) ;
- Cibles tactiles 44 px sur contrôles mobile refactorés ;
- Disposition bureau dense préservée 1024 px ;
- Honnêteté sur **lacunes résiduelles** (section 3.4).

1.7 Position produit

Medora est responsive et utilisable sur tablette et téléphone pour de nombreux workflows. Le poste fixe ou portable reste préféré pour la documentation clinique prolongée et complexe.

Medora est dépendant du cloud — pas de mode hors-ligne complet aujourd’hui (Volume 7).

[CAPTURE D’ÉCRAN — Navigation mobile]

2. Vue d’ensemble des workflows responsive

2.1 Initiative 19M.1–19M.9 — résultats

Phase	Focus	Résultat opérationnel
19M.1	Audit	Cartographie écarts mobile (shell, tableau, documentation, pharmacie)
19M.2	Shell application	Menu tiroir mobile ; barre latérale bureau 1024 px
19M.3	Tableau urgences	Cartes empilées téléphone ; grille 2 col. tablette
19M.4	Dossier actif / chart	Rail puces horizontal ; grille 10 tuiles bureau seulement
19M.5	Documentation prestataire	Colonne unique + résumé repliable ; MDM tactile
19M.6	Disposition / sortie	Empilement mobile ; exécution sortie pleine largeur
19M.7	Files auxiliaires	Pharmacie / labo / imagerie en cartes MedoraCard
19M.8	QA / régression	Checklist cross-device ; tests source-level
19M.9	Diagnostics / ordres	Cartes diagnostic mobile ; durcissement tableaux ordres ED

[DIAGRAMME — Architecture responsive Medora]

2.2 Classes d’appareils supportées

Classe	Largeur typique	Usage prévu
Téléphone portrait	360–430 px	Revue rapide, navigation, files
Téléphone paysage	667–932 px	Formulaires améliorés — tablette préférée si long
Tablette portrait	768–834 px	Documentation active, disposition, files 2 col.
Tablette paysage	1024–1194 px	Proche bureau ; barre latérale visible
Portable	1024–1280 px	Workflow clinique complet
Poste hospitalier	1280–1920 px	Cible production principale
Grand écran	1920 px+	Densité tableau, revue multi-panneaux

2.3 Attentes tablette

Appareil **par défaut recommandé** pour médecins et infirmiers en encounter complet au pilote Haïti.

2.4 Limitations téléphone

Éditions légères, revue, accusés — pas remplacement poste fixe pour charting prolongé.

2.5 Attentes poste de travail

Densité, lisibilité, ordres/diagnostics en mode dense (19M.9 desktop 1024 px).

2.6 Lacunes connues (honnêteté 19M)

Lacune	Impact	Atténuation opérationnelle
Hub pharmacie legacy (/app/pharmacy)	Tableaux larges	Utiliser /app/pharmacy-worklist
Filtres labo/imagerie denses	Hauteur téléphone	Tablette ou bureau pour revue prolongée
Charting multi-heures	Fatigue petit écran	Poste fixe
Pas de E2E navigateur automatisé	QA manuelle	Checklist 19M.8 avant déploiement

3. Guide par classe d'appareil

3.1 Poste de travail hospitalier (desktop)

Aspect	Détail
Meilleurs workflows	Tableau dense, documentation longue, ordres, diagnostics, admin
Limitations	Mobilité chevet

Aspect	Détail
Recommandation	Au moins un poste fixe par zone clinique
Sécurité	Écran orienté ; verrouillage session

3.2 Portable (laptop)

Aspect	Détail
Meilleurs workflows	Équivalent bureau si 1280 px ; déplacement salle de staff
Limitations	Clavier/souris requis pour productivité
Recommandation	Acceptable prestataire si pas de poste fixe
Sécurité	Ne pas laisser ouvert en salle d'attente

3.3 Tablette portrait

Aspect	Détail
Meilleurs workflows	Triage, réévaluation, disposition, exécution sortie, files
Limitations	Documentation MDM très longue
Recommandation	Appareil par défaut chevet pilote Haïti
Sécurité	Compte personnel ; déconnexion ; filtre confidentialité

3.4 Tablette paysage

Aspect	Détail
Meilleurs workflows	Proche bureau ; barre latérale ; 2 col. files
Limitations	Clavier virtuel lent pour texte long
Recommandation	Support médecin en box
Sécurité	Idem portrait

3.5 Téléphone

Aspect	Détail
Meilleurs workflows	Menu tiroir, tableau cartes, accusé file, revue statut
Limitations	MDM, admin, ROI, charting prolongé
Recommandation	Superviseur / charge infirmière — pas seul outil médecin
Sécurité	Risque mauvais patient si bandeau non lu ; zoom fatigue

4. Triage et workflows tablette au chevet

4.1 Triage sur tablette

- Panneau triage ED empile sous **960 px** ;
- Signes vitaux, ESI, allergies atteignables ;
- Volume 2 — carry-forward : revue section par section.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Triage tablette]

4.2 Soins infirmiers chevet

- Réévaluation infirmière : grille documentation empilée ;
- Vitaux rapides sur dossier actif ;
- Nouvelle séance horodatée.

4.3 Réévaluation rapide

Workflow **room-to-room** :

1. Ouvrir dossier depuis tableau (carte patient) ;
2. Vérifier bandeau identité ;
3. Vitaux / douleur / note réévaluation ;
4. Enregistrer serveur si connectivité OK.

4.4 Exécution sortie chevet

- Exécution sortie infirmière empilée (19M.6) ;
- Enseignement cases cochables au lit ;
- Vérifier orientation prestataire enregistrée avant départ.

4.5 Revue carry-forward tablette

- Reprise antécédents : lire avant confirmer — pas de clic global sans revue ;
- Allergies / médicaments : confirmation patient au chevet.

4.6 Prestataire box à box

- Revue chart, insertion pastilles MDM **courtes** acceptable ;
- Orientation + disposition : tablette OK ;
- Note complexe multi-sections : reporter au poste fixe si possible.

La tablette est l'appareil préféré pour les workflows actifs au chevet (triage, réévaluation, sortie).

5. Workflow mobile prestataire

5.1 Revue dossier

- Chart view : navigation par saut de section mobile ;
- Bandeau patient toujours visible avant prescription.

5.2 Réévaluation prestataire

- Mises à jour ciblées MDM / HPI sur tablette ;
- Réévaluation après résultats : privilégier clarté vs volume.

5.3 MDM sur tablette

- Menu multi-sélection scrollable ; pastilles tactiles ;
- Insertion intelligence motif **au clic** — relire sur petit écran.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Documentation prestataire tablette]

5.4 Intelligence motif sur tablette

- Bundles par sous-groupe ; édition pastilles obligatoire ;
- Éviter sessions longues MDM sur téléphone.

5.5 Disposition sur tablette

- Panneau Disposition empilé ; aperçu repliable ;
- **Enregistrer la décision d'orientation** reachable sans scroll horizontal.

[CAPTURE D'ÉCRAN — Workflow disposition mobile]

5.6 Documentation prolongée — limitation

La documentation clinique prolongée et complexe reste plus sûre et plus efficace sur poste fixe ou portable (1280 px).

Téléphone : éditions légères uniquement.

6. Tableau des urgences et flux ED mobile

6.1 Comportement responsive tableau

Largeur	Affichage
Téléphone	Cartes patient empilées — ESI, chambre, statut, action ouvrir
Tablette	Grille 2 colonnes
Bureau	Lignes denses MedoraCard

6.2 Navigation sections dossier actif

- < **bureau** : rail **puces** horizontal (triage, ordres, MAR, soins, disposition...) ;
- **Bureau** : grille 10 tuiles — ne pas former le staff à chercher tuiles sur téléphone.

6.3 Assignation et visibilité

- Assignation médecin / infirmier visible sur cartes ;
- Revue salle d'attente : cartes triées — pas remplacement surveillance clinique.

6.4 Revue file rapide

Le tableau mobile soutient la **conscience situationnelle** — pas toujours la documentation complète.

6.5 Limitation

Le tableau mobile soutient la prise de conscience opérationnelle ; il ne remplace pas toujours une revue complète au poste de travail (ordres larges, diagnostics denses).

7. Workflows mobile auxiliaires

7.1 Alignement 19M.7

Files pharmacie, laboratoire, imagerie :

- Cartes MedoraCard ;
- Cibles tactiles 44 px ;
- Tablette : grille 2 colonnes labo/imagerie ;
- Téléphone : cartes empilées.

[CAPTURE D'ÉCRAN — File pharmacie mobile]

7.2 Pharmacie

- Route `/app/pharmacy-worklist` — pas hub legacy sur mobile ;
- Voir le détail → dispense empilée.

7.3 Laboratoire / imagerie

- Filtres opérationnels empilés — hauteur téléphone ;
- Accusé / démarrage / complétion accessibles au toucher.

7.4 Revue file en déplacement

Accusé rapide et statut — saisie résultat longue : tablette ou bureau.

8. Opérations de déploiement Haïti

8.1 Réalités opérationnelles

Facteur	Implication
Connectivité variable	Latence, coupures, synchronisation en attente
Appareils partagés	Comptes nominatifs + déconnexion
Peu de postes fixes	Tablettes chevet par défaut
Coupures courant	Chargeurs ; UPS postes critiques si possible
Effectifs limités	Déploiement phasé ; super-utilisateurs
Protocole papier	Obligatoire en panne — Volume 7

8.2 Dépendance cloud — position honnête

Medora est dépendant du cloud et de l'internet. Il n'offre pas aujourd'hui de fonctionnalité hors-ligne complète ni d'architecture de synchronisation locale autonome.

Ne pas promettre continuité numérique sans réseau.

8.3 Stratégie déploiement phasé

Phase	Modules	Public
1	Accueil, triage, tableau, documentation base, soins	Cœur ED
2	Disposition, observation, files labo/rad/pharmacie	Semaine 2-4
3	Admin, ROI, facturation, santé publique	Selon maturité

Référence : docs/HAITI_MVP_PILOT.md.

8.4 Supervision opérationnelle

- Revue **quotidienne** 15 min : connectivité, pending sync, incidents ;
- Super-utilisateur par discipline ;
- Escalade admin (Volume 7).

8.5 Formation

- Un Volume manuel par rôle ;
- Exercice tablette chevet + exercice panne papier ;
- Checklist 19M.8 sur 1 téléphone + 1 tablette + 1 bureau avant go-live.

8.6 Inventaire matériel recommandé

Élément	Quantité indicative (petite clinique ED)
Tablettes chevet	1-2 par zone + 1 triage
Poste fixe / portable	1 médecin + 1 admin
Routeur / Wi-Fi stable	Couverture box + triage
Chargeurs / câbles	100 % tablettes en service
Copies runbook papier	Accueil + charge infirmière

[DIAGRAMME — Déploiement Haïti]

9. Connectivité dégradée

9.1 Synchronisation en attente

- Ordres / résultats / MAR peuvent afficher **synchronisation en attente** ;
- **Ne pas considérer** action définitive tant que serveur non confirmé ;
- Cartes file surlignées pending sync (Volume 5).

9.2 Mises à jour retardées

- Files auto-rafraîchies (~10 s) — peut sembler « figé » si réseau lent ;
- Actualiser manuellement ; vérifier heure dernière action.

9.3 Après reconnexion

Checklist :

1. Connexion fraîche ;
2. Ouvrir dossier touché pendant panne ;
3. Vérifier enregistrements vs papier ;
4. Résoudre pending sync ;
5. **Confirmer** orientation, sortie, MAR critiques enregistrés serveur.

9.4 Escalade connectivité dégradée

- Charge infirmière → admin → opérateur ;
- Message staff français : « Réseau instable — vérifier enregistrements avant sortie patient ».

9.5 Protocole papier temporaire

Volume 7 — activer si login impossible ou enregistrement critique échoue répétitivement.

9.6 Communication

Afficher heure début / fin dégradation ; plan reconciliation.

Le personnel doit vérifier la complétion des workflows critiques après reconnexion
(orientation, sortie, MAR, résultats saisis).

[DIAGRAMME — Workflow connectivité dégradée]

10. Appareils partagés et confidentialité

Risque	Mesure
Tablette partagée	Compte personnel ; déconnexion fin de quart
Confidentialité écran	Filtre ; angle ; pas en salle d'attente
Appareil sans surveillance	Verrouillage auto ; ne pas laisser dossier ouvert
Visibilité patient	Ne pas montrer écran à tiers non autorisés
Mauvais utilisateur	Login nominatif — pas de compte « tablette salle 3 »
Vol / perte	Signaler admin ; désactivation compte
Wi-Fi public	Éviter dossier patient ; réseau clinique privé
Charge / coupure courant	UPS ; ne pas perdre saisie — attendre sync avant sortie

11. Sécurité opérationnelle mobile

Risque	Mesure
Petit écran	Relire identité ; ne pas sur-taper texte générique
Documentation prolongée fatigue	Pauses ; passer au bureau si note longue

Risque	Mesure
Overflow / scroll caché	Vérifier boutons Enregistrer visibles ; scroll complet disposition
Résultats pending	Ne pas orienter sans revue si protocole l'exige
Revue ordres	Tableau ordres ED : scroll horizontal possible téléphone — tablette préférée
Mauvais patient mobile	Bandeau + NIR avant toute action
Distraction workflow	Pas de documentation mobile en marchant sans vérification

Aligné lacunes 19M restantes — formation sur **limites**, pas sur promesse desktop identique.

12. Déploiement et formation — recommandations

12.1 Go-live phasé

- Semaine 1 : accueil + triage + tableau ;
- Semaine 2 : documentation + soins ;
- Semaine 3+ : disposition, files, admin.

12.2 Super-utilisateurs

- 1 infirmier, 1 médecin, 1 admin, 1 accueil — formés Volumes 1–8.

12.3 Revue opérationnelle quotidienne (15 min)

- Incidents connectivité ;
- Pending sync non résolus ;
- Confusion workflow → rappel formation.

12.4 Inventaire appareils

- Numéro série, affectation zone, responsable charge ;
- Test Wi-Fi à chaque poste.

12.5 Évaluation réseau

- Débit minimal stable aux box et triage ;
- Plan B papier si coupure > 30 min (seuil local ajustable).

12.6 Onboarding

- Nouveau staff : Volume rôle + 30 min tablette supervisée ;
- Signature checklist sécurité mobile.

13. Résumé opérationnel rapide — checklists

13.1 Checklist déploiement tablette

- ☐ Wi-Fi testé zone box + triage
- ☐ Comptes nominatifs créés
- ☐ Menu tiroir démontré
- ☐ Triage + réévaluation testés
- ☐ Enregistrement serveur confirmé
- ☐ Chargeurs étiquetés

13.2 Checklist workflow chevet

- ☐ Identité bandeau vérifiée
- ☐ Bon dossier ouvert
- ☐ Action enregistrée serveur
- ☐ Pending sync absent ou résolu
- ☐ Écran orienté confidentialité

13.3 Checklist déploiement Haïti

- ☐ Phase 1 modules formés
- ☐ Runbook papier imprimé
- ☐ Super-utilisateurs identifiés
- ☐ Admin + support contactés
- ☐ 19M.8 exécuté (1 phone + 1 tablet + 1 desktop)
- ☐ Dépendance cloud expliquée au staff

13.4 Checklist connectivité dégradée

- ☐ Staff informé (FR)
- ☐ Pas de sortie sans vérif enregistrement
- ☐ Pending sync revu
- ☐ Papier si panne totale
- ☐ Reconciliation planifiée

13.5 Checklist appareil partagé

- ☐ Login personnel
- ☐ Déconnexion fin quart
- ☐ Pas mot de passe mémorisé public
- ☐ Vol/perte : procédure connue

13.6 Checklist sécurité mobile

- ☐ Pas photo écran dossier
- ☐ Boutons save visibles
- ☐ Documentation longue → bureau si possible
- ☐ Résultats pending revus

13.7 Checklist préparation opérationnelle quotidienne

- ☐ Tablettes chargées
 - ☐ Wi-Fi OK
 - ☐ Tableau urgences accessible
 - ☐ Papier secours disponible
 - ☐ Super-utilisateur de garde nommé
-

14. Gouvernance du chapitre

14.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction clinique	Politique appareil par rôle
Admin établissement	Inventaire, comptes, déploiement
Référent 19M / produit	Exactitude comportement responsive
Référent terminologie	Canon

14.2 Lien initiative responsive

Toute phase 19M future → mise à jour chapitre + tests `frenchHandbookMobileTabletHaiti19MBookFr9.test.ts`.

14.3 Revue annuelle

Appareils, lacunes 19M, politique téléphone vs tablette.

14.4 Revue déploiement Haïti

Semestrielle : connectivité, papier, adoption tablette, incidents mauvais patient.

14.5 Gouvernance formation

Matrice appareil recommandé par rôle affichée au poste.

14.6 Politique appareils

Document local : qui peut utiliser téléphone seul ; exigence tablette chevet ; interdiction comptes partagés.

Annexes

A. Seuils responsive (aperçu staff)

Seuil	Comportement
< 768 px	Mobile cartes
768–1023 px	Tablette
1024 px	Bureau dense + sidebar

B. Références

- Volume 7 — Panne / cloud
- docs/ui/mobile-tablet-responsiveness-audit-19M1.md
- docs/ui/cross-device-qa-checklist-19M8.md
- docs/HAITI_MVP_PILOT.md
- docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Navigation mobile]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Triage tablette]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Documentation prestataire tablette]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — File pharmacie mobile]
 - [CAPTURE D'ÉCRAN — Workflow disposition mobile]
 - [DIAGRAMME — Déploiement Haïti]
 - [DIAGRAMME — Workflow connectivité dégradée]
 - [DIAGRAMME — Architecture responsive Medora]
-

Volume 9 — Formation, intégration et certification opérationnelle

Manuel d'orientation opérationnel Medora-S (français)

Phase : M-BOOK.FR.10

Version : 1.0.0-draft

Statut : Contenu formation / exploitation — ne modifie pas le comportement produit

Public : Formateurs, responsables formation, superviseurs, administrateurs, direction pilote Haïti

Prérequis : Volumes 1–8 · Canon terminologique

Guide rédaction : Guide de style manuel

Métadonnées du volume

Champ	Valeur
Volume	9 — Formation, intégration et certification opérationnelle
Rôle	Capstone — orchestration formation sur la collection M-BOOK.FR
Volumes liés	1 Accueil · 2 Triage · 3 Prestataire · 4 Infirmier · 5 Auxiliaires · 6 Orientation/ROI · 7 Admin · 8 Mobile/Haïti
Révision recommandée	Annuelle ou après changement majeur produit / déploiement

1. Introduction à la formation Medora-S

1.1 Objectif de ce volume

Ce volume **ne remplace pas** les chapitres métier (Volumes 1–8). Il définit :

- **Qui** forme **qui**, **quand**, et **sur quels chapitres** ;
- Le parcours **d'intégration** (onboarding) par rôle ;
- La **certification opérationnelle interne** (attestation de compétence Medora à l'établissement) ;
- La gouvernance formation pour le **pilote Haïti**.

1.2 Philosophie formation

Principe	Application
Sécurité patient d'abord	Formation sur identité patient, escalade, panne
Par rôle	Moindre privilège — ne former que les modules nécessaires
Pratique	Exercices sur dossier test avant autonomie réelle
Honnêteté produit	Cloud-dépendant ; limites mobile ; pas de diagnostic auto
Français UI	Tout le personnel voit l'interface en français

1.3 Certification opérationnelle — définition

La certification opérationnelle Medora = attestation interne que le personnel a suivi la formation requise, réussi les vérifications pratiques définies par l'établissement, et peut utiliser Medora **en autonomie supervisée puis en autonomie** pour son rôle.

Ce n'est pas :

- Une licence professionnelle (médecine, infirmier, pharmacie) ;
- Une certification ESI internationale complète ;
- Une accréditation juridique ROI ou conformité nationale.

La direction de l'établissement **définit** le niveau d'autonomie après attestation.

1.4 Responsabilité institutionnelle

Medora-S fournit la documentation et les workflows. La direction et les responsables formation restent responsables du programme de formation, de la conformité locale et de la supervision clinique.

2. Cartographie des volumes par rôle

2.1 Matrice curriculum (référence)

Rôle	Volumes obligatoires	Volumes recommandés	Durée indicative
Accueil / FRONT DESK	1	8 (mobile), 7 (aperçu)	0,5–1 j
Infirmier(ère) / triage / ED	2, 4, 8	6 (aperçu sortie), 5 (aperçu)	2–3 j
Prestataire (médecin / IPS)	1, 2, 3, 6, 8	4 (coordination), 5	2–4 j
Infirmier(ère) / soins (sans triage)	2, 8	2 (aperçu), 6	1,5–2 j
Pharmacien	5, 8	1 (identité), 7 (aperçu)	1 j
Laboratoire	5, 8	1 (identité)	0,5–1 j
Imagerie	5, 8	1 (identité)	0,5–1 j
Administration (ROI), Super-utilisateur	1–8	1–3 (aperçu flux)	2–3 j
Direction / for- mateur	1–8 + ce Volume 9	—	5 j + mentorer
			Continu

2.2 Priorité P1 vs P2 (formation go-live)

Priorité	Contenu	Quand
P1	Accueil, triage, tableau, doc prestataire, soins, disposition, mobile base	Semaine 1–2 pilote

Priorité	Contenu	Quand
P2	Auxiliaires, ROI, admin avancé, carry-forward approfondi	Semaine 3+

Référence : Inventaire workflows.

2.3 Parcours patient type (fil conducteur formation)

Volume 1 Accueil → Volume 2 Triage → Tableau urgences
 → Volume 3 Prestataire → Volume 5 Ordres/résultats
 → Volume 4 Soins / réévaluation
 → Volume 6 Orientation + exécution sortie

Tous les rôles doivent **comprendre** ce fil, même s'ils ne maîtrisent qu'une étape.

[DIAGRAMME — Parcours formation par rôle]

3. Intégration (onboarding) — workflow standard

3.1 Avant le premier jour

Étape	Responsable
Compte créé + rôles assignés (Volume 7)	Admin
Appareil assigné (tablette / poste)	Admin + IT local
Accès dossier formation ou environnement test	Admin
Liste volumes à lire / parcours assigné	Formateur

3.2 Jour 1 — Fondations

1. Connexion, sélecteur établissement, menu navigation (Volume 8) ;
2. **Identité patient** — ne jamais documenter sans vérifier (Volume 1) ;
3. Parcours rôle : chapitres obligatoires Volume(s) métier ;
4. Exercice guidé 1 : ouvrir dossier test, **sans** données réelles si possible.

3.3 Semaine 1 — Supervision

- Binôme avec super-utilisateur ou formateur ;
- Checklist quotidienne (section 12) ;
- Questions escaladées en debrief 15 min (Volume 8).

3.4 Semaine 2–4 — Montée autonomie

- Exercices scénarisés (section 8) ;
- Certification niveau 1 (section 6) ;
- Réduction supervision progressive selon politique locale.

3.5 Offboarding

- Désactivation compte jour de départ (Volume 7) ;
- Pas de transfert identifiants.

4. Niveaux de certification opérationnelle

4.1 Niveau 0 — Observation

- Assisté uniquement ; pas d'enregistrement autonome sur patient réel.

4.2 Niveau 1 — Autonomie supervisée

- Enregistrements sur patient réel **avec** super-utilisateur disponible ;
- Erreurs corrigées en debrief ;
- Attestation formateur après checklist niveau 1.

4.3 Niveau 2 — Autonomie routine

- Workflow complet du rôle sans supervision constante ;
- Escalade si cas complexe / panne / ROI ;
- Recertification annuelle (section 9).

4.4 Niveau 3 — Super-utilisateur / formateur

- Certifié niveau 2 + formation Volumes transverses ;
- Peut former et attester niveau 1 ;
- Point de contact escalade niveau 1.

4.5 Registre d'attestation (recommandé)

Champ	Exemple
Nom	...
Rôle	RN, PROVIDER, ...
Volumes complétés	1, 2, 4, 8
Niveau certifié	1 ou 2
Date	...
Formateur	...
Prochaine recertification	+12 mois

Registre **papier ou outil local** — hors produit Medora MVP.

4.6 Limites explicites

La certification Medora **n'accorde pas** de droits cliniques au-delà du permis / cadre professionnel local.

5. Guide du formateur / facilitateur

5.1 Rôle formateur

- Adapter volumes 1-8 au contexte local ;
- Animer exercices pratiques ;

- Attester niveaux 1–2 ;
- Remonter ambiguïtés produit / documentation.

5.2 Préparation session

- ☐ Objectifs écrits (3 max) ;
- ☐ Dossier test prêt ;
- ☐ Appareils chargés + Wi-Fi testé ;
- ☐ Checklist sécurité rappelée (identité, déconnexion) ;
- ☐ Volume(s) PDF ou imprimés disponibles.

5.3 Méthodes pédagogiques

Méthode	Usage
Démonstration	Navigation, enregistrement triage
Pratique guidée	Apprenant clique, formateur observe
Scénario	Cas standard + cas piège (mauvais patient)
Debrief	Erreurs sans blame — focus processus

5.4 Pièges formation fréquents

- Former tout le monde sur tout (surcharge) ;
- Ignorer protocole papier (Volume 7–8) ;
- Promettre hors-ligne complet ;
- Oublier distinction orientation vs disposition (Volume 6) ;
- Oublier distinction décision prestataire vs exécution infirmière sortie (Volumes 3–4).

5.5 Évaluation formateur

Auto-évaluation après chaque session : objectifs atteints ? temps ? questions non résolues ?

6. Programme pilote Haïti

6.1 Contexte

- Effectifs réduits ;
- Connectivité variable ;
- Tablettes chevet ;
- Protocole papier obligatoire en parallèle.

6.2 Calendrier type (4 semaines)

Semaine	Focus	Public
1	Accueil, triage, tableau, mobile, panne papier	Accueil + triage + super-users
2	Prestataire + infirmier soins + disposition base	Médecins + IDE
3	Auxiliaires + observation + files	Pharma, labo, rad

Semaine	Focus	Public
4	Admin, ROI, recertification, debrief direction	Admin + leads

6.3 Super-utilisateurs Haïti (minimum)

Discipline	Nombre min.
Infirmier	2
Médecin	1
Accueil	1
Admin	1

6.4 Matériel formation

- 1 tablette formation + 1 poste fixe ;
- Runbook panne imprimé (français) ;
- Registre attestations ;
- Liste contacts support.

6.5 Critères go-live formation

- ☐ 80 % personnel P1 niveau 1 minimum ;
- ☐ 100 % super-utilisateurs niveau 3 ;
- ☐ Exercice panne papier réalisé ;
- ☐ Checklist 19M.8 exécutée (Volume 8).

Référence : docs/HAITI_MVP_PILOT.md.

[DIAGRAMME — Déploiement formation Haïti]

7. Programme super-utilisateur

7.1 Mission

- Premier niveau support ;
- Formation niveau 1 ;
- Escalade admin / opérateur ;
- Gardien des checklists.

7.2 Curriculum super-utilisateur

Volumes 1–8 complets + ce Volume 9 + runbooks panne/déploiement.

7.3 Compétences attendues

- Résoudre confusion navigation / rôle ;
- Identifier pending sync ;
- Activer protocole papier ;
- **Ne pas** modifier RBAC sans admin.

7.4 Relève

Documenter backup super-user par discipline — pas de point unique de défaillance.

8. Exercices pratiques et scénarios

8.1 Scénarios transverses (tous rôles)

#	Scénario	Compétence
T1	Mauvais patient — stop avant enregistrement	Identité
T2	Réseau coupé — protocole papier	Continuité
T3	Pending sync après reconnexion	Vérification

8.2 Accueil

#	Scénario	Volume
A1	Nouveau patient + ouverture consultation urgence	1
A2	Doublon suspect — escalade	1

8.3 Triage

#	Scénario	Volume
TR1	Triage complet + ESI + allergies	2
TR2	Carry-forward revu section par section	2
TR3	Réévaluation ESI — patient qui empire	2

8.4 Prestataire

#	Scénario	Volume
P1	HPI + MDM + pastille (édition obligatoire)	3
P2	Orientation enregistrée + cohérence texte	3, 6
P3	Intelligence motif — insertion manuelle seulement	3

8.5 Infirmier

#	Scénario	Volume
N1	Réévaluation + MAR	4
N2	Exécution sortie après orientation prestataire	4, 6

8.6 Auxiliaires

#	Scénario	Volume
X1	File pharmacie — dispense + haut risque	5

#	Scénario	Volume
X2	Résultat labo + escalade selon protocole	5

8.7 Admin

#	Scénario	Volume
AD1	Création compte + rôles minimum	7
AD2	ROI demande → approbation → exercice sans exécution prod si test	6, 7

9. Recertification et revue annuelle

9.1 Fréquence

- **Annuelle** niveau 2 ;
- **Immédiate** après changement majeur UI (19M, disposition, ROI) ;
- **À l'embauche** pour nouveaux — parcours complet onboarding.

9.2 Contenu recertification (light)

- 30 min rappel sécurité (identité, mobile, panne) ;
- 1 scénario pratique rôle ;
- Signature registre attestation.

9.3 Changements produit

Formateur communique delta ; session micro-formation 15 min avant prise de poste.

9.4 Échec recertification

Retour niveau 1 supervisé — pas de sanction automatique dans ce manuel ; politique RH locale.

10. Formation transversale obligatoire

10.1 Sécurité patient (tous)

- Identité patient ;
- Moindre privilège ;
- Comptes nominatifs interdits partagés ;
- Confidentialité écran (Volume 8).

10.2 Connectivité (tous)

- Medora dépendant du cloud ;
- Pending sync ;
- Vérification post-reconnexion ;
- Papier si panne.

10.3 Mobile (clinique)

- Tablette chevet vs bureau documentation longue (Volume 8).

10.4 Gouvernance sortie / ROI (cibles)

- Prestataire + infirmier : orientation vs exécution (Volumes 3–4–6);
 - Admin : ROI Phase 5G (Volumes 6–7).
-

11. Évaluation des compétences

11.1 Modalités

Modalité	Quand
Observation directe	Certification niveau 1
Scénario simulé	Certification niveau 2
Checklist cochée	Tous niveaux
Debrief oral	Complément

Pas d'examen écrit long — **compétence opérationnelle** prime.

11.2 Critères minimum niveau 1 (exemple infirmier triage)

- ☐ Ouvre bon dossier;
- ☐ Triage enregistré sans champ critique vide;
- ☐ Carry-forward revu;
- ☐ Identité vérifiée verbalement;
- ☐ Sait escalader détresse.

11.3 Critères minimum niveau 2 (exemple prestataire)

- ☐ Documentation cohérente patient;
- ☐ MDM personnalisé (pas texte brut template);
- ☐ Orientation enregistrée alignée texte;
- ☐ Gère pending sync / panne selon protocole.

11.4 Traçabilité

Registre papier ou feuille locale — **attestation** signée formateur + apprenant.

12. Résumé opérationnel rapide — checklists

12.1 Checklist onboarding administrateur formation

- ☐ Registre attestations créé
- ☐ Super-utilisateurs nommés
- ☐ Dossier test disponible

- ☐ Volumes 1–8 accessibles
- ☐ Calendrier Haïti publié

12.2 Checklist onboarding nouvel utilisateur

- ☐ Compte actif + bon établissement
- ☐ Volumes assignés lus
- ☐ Jour 1 exercice guidé
- ☐ Checklist sécurité signée
- ☐ Niveau 1 planifié

12.3 Checklist session formateur

- ☐ Objectifs + scénario
- ☐ Wi-Fi / appareils
- ☐ Debrief prévu
- ☐ Attestations mises à jour

12.4 Checklist certification niveau 1

- ☐ Scénarios rôle réussis
- ☐ Identité patient maîtrisée
- ☐ Panne / papier expliqué
- ☐ Registre signé

12.5 Checklist certification niveau 2

- ☐ Autonomie semaine complète sans incident majeur
- ☐ Recertification date notée
- ☐ Super-user backup identifié

12.6 Checklist recertification annuelle

- ☐ Rappel sécurité 30 min
- ☐ 1 scénario
- ☐ Delta produit communiqué
- ☐ Registre à jour

12.7 Checklist formation Haïti go-live

- ☐ Semaine 1–4 exécutée ou adaptée
- ☐ Papier testé
- ☐ 19M.8 passé
- ☐ Direction debrief

12.8 Checklist escalade formation

- ☐ Question documentée
 - ☐ Volume concerné identifié
 - ☐ Super-user ou admin contacté
 - ☐ Réponse partagée équipe si générique
-

13. Gouvernance du chapitre

13.1 Propriété

Rôle	Responsabilité
Direction établissement	Programme certification, autonomie
Responsable formation	Calendrier, registre, formateurs
Super-utilisateurs	Niveau 1, escalade
Référent terminologie	Cohérence Volumes 1–9

13.2 Revue annuelle collection M-BOOK

Mettre à jour matrices rôle volume si nouveaux modules.

13.3 Revue Haïti

Semestrielle : adoption, durées formation, ajustement calendrier.

13.4 Lien phases produit

19M, 19MDM, 5F/5G → module micro-formation + recertification ciblée.

13.5 Index des volumes

Vol.	Phase	Titre	Fichier
1	M-BOOK.FR.2	Accueil et inscription	handbook-fr-registration-intake.md
2	M-BOOK.FR.3	Triage et intake clinique	handbook-fr-triage-clinical-intake.md
3	M-BOOK.FR.4	Workflow prestataire et documentation	handbook-fr-provider-workflow-documentation.md

Vol.	Phase	Titre	Fichier
4	M-BOOK.FR.5	Workflow infirmier et exécution sortie	handbook-fr-nursing-discharge-execution.md
5	M-BOOK.FR.6	Pharmacie, laboratoire et imagerie	handbook-fr-pharmacy-lab-radiology.md
6	M-BOOK.FR.7	Orientation, admission, transfert et ROI	handbook-fr-disposition-admission-transfer-roi.md
7	M-BOOK.FR.8	Administration et gouvernance plateforme	handbook-fr-administration-governance-operations.md
8	M-BOOK.FR.9	Mobile, tablette et déploiement Haïti	handbook-fr-mobile-tablette-haiti.md
9	M-BOOK.FR.10	Formation, intégration et certification	handbook-fr-training-onboarding-certification.md

Annexes

A. Sigles formation

Sigle	Signification
Onboarding	Intégration initial
SU	Super-utilisateur
P1 / P2	Priorité manuel / go-live

B. Références

- Canon terminologique
- Inventaire workflows
- docs/HAITI_MVP_PILOT.md
- docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md
- docs/DEPLOYMENT_RUNBOOK.md

C. Placeholders visuels

- [CAPTURE D'ÉCRAN — Tableau de bord formation]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Registre attestation]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Session super-utilisateur]
- [CAPTURE D'ÉCRAN — Exercice scénario triage]
- [DIAGRAMME — Parcours formation par rôle]
- [DIAGRAMME — Niveaux certification]
- [DIAGRAMME — Calendrier Haïti 4 semaines]

— [DIAGRAMME — Escalade formation]

Fin du Volume 9 — M-BOOK.FR.10

Annexe A — Déploiement Haïti

Phase : M-BOOK.FR.11

Statut : Scaffold — contenu détaillé dans Volume 8 et Volume 9

Objectif

Consolider les références déploiement pilote Haïti pour l'export entreprise.

Contenu planifié (TODO)

A.1 Contexte pilote

- ☐ Effectifs, connectivité, matériel
- ☐ Référence docs/HAITI_MVP_PILOT.md

A.2 Prérequis go-live

- ☐ Formation semaines 1–4 (Volume 9)
- ☐ Super-utilisateurs nommés
- ☐ Protocole papier testé

A.3 Checklist 19M.8

- ☐ Cross-device regression
- ☐ Volume 8 § checklists

A.4 Contacts et escalade

- ☐ Support local
 - ☐ Runbooks panne / déploiement
-

Références volumes

Sujet	Volume
Mobile, tablette, connectivité	Volume 8
Programme formation 4 semaines	Volume 9
Accueil / triage terrain	Volumes 1–2

Références externes

— docs/HAITI_MVP_PILOT.md

- docs/DEPLOYMENT_RUNBOOK.md
 - docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md
-

Annexe A — M-BOOK.FR.11

Annexe B — Sécurité mobile et tablette

Phase : M-BOOK.FR.11

Statut : Scaffold

Objectif

Rappels sécurité pour usage tablette chevet et mobile en environnement clinique Haïti.

Contenu planifié (TODO)

B.1 Confidentialité écran

- ☐ Verrouillage appareil
- ☐ Pas de partage session
- ☐ Déconnexion fin de poste

B.2 Comptes nominatifs

- ☐ Interdiction comptes partagés
- ☐ Volume 9 § formation transversale

B.3 Appareils perdus / volés

- ☐ Procédure escalade admin
- ☐ Désactivation compte

B.4 Connectivité

- ☐ Pending sync — vérification post-reconnexion
 - ☐ Medora **dépendant du cloud**
-

Références

- Volume 8 — Mobile et Haïti
 - 07-index-captures-ecran.md — viewports tablette/mobile
-

Annexe B — M-BOOK.FR.11

Annexe C — Référence rapide

Phase : M-BOOK.FR.11

Statut : Scaffold

Objectif

Fiches une page par rôle pour impression / laminage poste.

Contenu planifié (TODO)

C.1 Accueil (FRONT_DESK)

- ☐ Routes : `/app/registration`, `/app/patients`
- ☐ Règle identité patient
- ☐ Volume 1 checklist

C.2 Triage (RN)

- ☐ Routes : `/app/emergency/triage`, `/app/emergency/trackboard`
- ☐ ESI — escalade détresse
- ☐ Volume 2 checklist

C.3 Médecin (PROVIDER)

- ☐ Routes : `/app/provider`, `/app/emergency/active/{id}`
- ☐ Orientation vs disposition
- ☐ Volume 3 checklist

C.4 Infirmier soins (RN)

- ☐ Routes : `/app/nursing`
- ☐ Exécution sortie décision prestataire
- ☐ Volume 4 checklist

C.5 Admin

- ☐ Routes : `/app/admin`
 - ☐ ROI — ne pas improviser
 - ☐ Volume 7 checklist
-

Références

- Index routes
- Index workflows
- Volume 9 — checklists §12

Annexe C — M-BOOK.FR.11

Annexe D — Scénarios de formation

Phase : M-BOOK.FR.11

Statut : Scaffold — scénarios détaillés dans Volume 9 §8

Objectif

Index centralisé des exercices pratiques pour formateurs.

Scénarios transverses (tous rôles)

ID	Scénario	Volume source
T1	Mauvais patient — stop avant enregistrement	Vol. 9 §8.1
T2	Réseau coupé — protocole papier	Vol. 9 §8.1
T3	Pending sync après reconnexion	Vol. 9 §8.1

Par rôle (TODO expansion)

- ☐ Accueil A1–A2 → Volume 9 §8.2
 - ☐ Triage TR1–TR3 → Volume 9 §8.3
 - ☐ Prestataire P1–P3 → Volume 9 §8.4
 - ☐ Infirmier N1–N2 → Volume 9 §8.5
 - ☐ Auxiliaires X1–X2 → Volume 9 §8.6
 - ☐ Admin AD1–AD2 → Volume 9 §8.7
-

Références

- Volume 9 — Formation
 - 08-index-diagrammes.md — diagrammes formation
-

Annexe D — M-BOOK.FR.11

Annexe E — Workflow papier / panne (downtime)

Phase : M-BOOK.FR.11

Statut : Scaffold

Objectif

Documenter la continuité de soins lorsque Medora est indisponible — **sans prétendre à un mode offline produit.**

Principes

Principe	Détail
Cloud-dépendant	Medora MVP nécessite connectivité pour synchronisation
Papier parallèle	Protocole institutionnel obligatoire en pilote Haïti
Reconciliation	Saisie différée après reconnexion — vérifier pending sync
Pas de contournement RBAC	Papier ne remplace pas contrôles admin

Contenu planifié (TODO)

E.1 Déclencheurs activation papier

- ☐ Perte réseau prolongée
- ☐ Indisponibilité service cloud
- ☐ Volume 8 + runbook panne

E.2 Formulaires papier recommandés

- ☐ Triage
- ☐ Ordres médicaments
- ☐ Sortie / orientation

E.3 Reconnexion

- ☐ Vérification pending sync
 - ☐ Débrief équipe
-

Références externes

- docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md
- Volume 8
- 08-index-diagrammes.md — D-14 connectivité dégradée

Annexe E — M-BOOK.FR.11

Gouvernance documentaire — Manuel entreprise Medora-S

Phase : M-BOOK.FR.11

Section : VI.1

1. Objectif

Définir comment la collection **M-BOOK.FR** est versionnée, revue, traduite et préparée pour export — sans modifier le comportement produit Medora-S.

2. Périmètre de la collection

Composant	Emplacement	Phase origine
Canon terminologique	docs/operations/french-terminology-1.0.0.fr.md	M-BOOK.FR.11
Inventaire workflows	docs/operations/french-workflows-1.0.0.fr.md	M-BOOK.FR.11
Registre risques	docs/operations/french-terminology-1.0.0.fr.md	M-BOOK.FR.11
Volumes 1–9	docs/operations/handbook-fr-*.md	M-BOOK.FR.2–10
Assemblage entreprise	docs/operations/medora-enterprise-handbook-fr/	M-BOOK.FR.11
Manifeste machine	handbook-manifest-fr.ts	M-BOOK.FR.11

3. Stratégie de versionnement

Niveau	Format	Exemple
Collection	M-BOOK.FR.{n}	M-BOOK.FR.11
Volume	1.0.0-draft → 1.0.0	Approbation direction
Assemblage	Aligné sur dernier volume majeur	1.0.0-draft
Canon	MBOOK_FR1_CANON_VERSION	Trace machine

Règles :

1. Toute modification substantielle d'un volume incrémente sa version mineure.
2. L'assemblage entreprise (FR.11) est mis à jour lors de l'ajout de volumes ou index.
3. Le manifeste TypeScript doit refléter les chemins source à jour.
4. Tests source-level (`frenchHandbook*19MBookFr*.test.ts`) bloquent les régressions documentation.

4. Revue annuelle

Document	Fréquence	Responsable
Volumes opérationnels 1–9	Annuelle	Responsable formation + référent clinique

Document	Fréquence	Responsable
Canon terminologique	Annuelle ou post-changement UI majeur	Référent terminologie
Index routes / workflows	Semestrielle	Admin + formateur
Inventaires visuels	À chaque campagne capture	Direction + IT
Registre risques	Trimestrielle (revue légère)	Référent terminologie

Déclencheurs revue immédiate :

- Initiative **19M** (responsive) — layout change
- **19T** carry-forward — workflow change
- **19MDM** — intelligence motif change
- Phase **5F/5G** — export / ROI change
- Déploiement nouvelle clinique

5. Propriété et responsabilités

Rôle	Responsabilité
Direction établissement	Approbation contenu formation, autonomie certification
Direction clinique pilote	Exactitude workflows, protocoles locaux
Responsable formation	Calendrier, registre attestation, formateurs
Administrateur Medora	Exactitude routes, RBAC, captures environnement test
Référent terminologie	Canon, glossaire, cohérence FR
Éditeur technique	Assemblage, export PDF/DOCX, manifeste

Medora-S fournit la documentation. L'établissement reste responsable de l'adaptation aux politiques locales.

6. Gouvernance traduction (édition anglaise future)

Principe	Application
FR = canon opérationnel	Édition française authoritative pour Haïti
EN = support dev / partenaires	Traduction après stabilisation FR
Clés i18n	en.ts / fr.ts — pas de duplication manuel
Workflow traduction	1) Gel volume FR · 2) Revue · 3) Traduction · 4) Validation clinique EN · 5) Publication séparée
Sigles cliniques	Conservés (ESI, HPI) avec expansion

Ne pas publier d'édition EN avant revue direction du volume FR correspondant.

7. Politique refresh captures d'écran

Événement	Action
Changement UI majeur (19M)	Re-capture priorités P1
Nouvelle route nav	Mise à jour index routes + capture si P1
Revue annuelle	Audit inventaire §07 — complétude
PHI incident	Retrait immédiat + re-capture

Voir 07-index-captures-ecran.md — **patient fictif obligatoire**.

8. Cadence revue déploiement

Cadence	Activité
Pré go-live	Checklist export + formation Haïti (Volume 9)
J+30 post go-live	Debrief formation, ajustement calendrier
Semestrielle Haïti	Volume 8 + Annexe A — connectivité, papier
Annuelle	Recertification personnel (Volume 9)

Références : docs/DEPLOYMENT_RUNBOOK.md · docs/ER_PILOT_DOWNTIME_RUNBOOK.md

9. Cadence revue Haïti

Sujet	Fréquence
Adoption tablettes / connectivité	Semestrielle
Protocole papier	Annuelle (exercice obligatoire)
Titres professionnels (IDE, IPS)	À l'embauche + annuelle
Super-utilisateurs backup	Trimestrielle

Référence : docs/HAITI_MVP_PILOT.md

10. Intégrité et tests

Mécanisme	Description
Tests source-level	Validation présence sections, routes, canon
Manifeste TS	Métadonnées volumes pour tooling export
pnpm verify:web	Pas de régression TypeScript web
Revue pair	Deux lecteurs pour volumes gouvernance (6, 7, 9)

11. Export et distribution

Format	Usage	Checklist
PDF	Formation imprimée, direction	export-readiness-checklist.md
DOCX	Édition locale, commentaires	Idem
Markdown repo	Source de vérité développement	Git

12. Limites explicites

Ce cadre documentaire :

- **Ne remplace pas** les politiques institutionnelles ni le jugement clinique ;
- **Ne certifie pas** légalement le personnel (certification = attestation interne Vol. 9) ;
- **Ne garantit pas** un mode hors-ligne complet — Medora reste **dépendant du cloud** en MVP.

Références

- Table des matières
- Manifeste
- Volume 9 — formation et certification

Fin gouvernance documentaire — M-BOOK.FR.11